==========

БАЗА ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ ДЛЯ АККРЕДИТАЦИИ ФМЗА (ВОПРОСЫ 1 - 80)

Вопрос 1

В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ № 323-ФЗ «ОБ ОСНОВАХ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» КАЖДЫЙ ИМЕЕТ ПРАВО НА МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ В ГАРАНТИРОВАННОМ ОБЪЕМЕ, ОКАЗЫВАЕМУЮ БЕЗ ВЗИМАНИЯ ПЛАТЫ В СООТВЕТСТВИИ С ПРОГРАММОЙ

1. обязательного медицинского страхования
2. развития здравоохранения
3. **государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи**
4. социально-экономического развития субъекта Российской Федерации

Вопрос 2

РЕШЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ МЕДИЦИНСКОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА БЕЗ СОГЛАСИЯ ГРАЖДАНЫНА ПРИ СУДНО-МЕДИЦИНСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЕ ИЛИ СУДЕБНО-ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЕ ПРИНИМАЕТСЯ

1. **судом**
2. консилиумом врачей
3. главным врачом медицинской организации
4. судебно-медицинским экспертом

Вопрос 3

ОСНОВНЫМ ПРИНЦИПОМ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ЯВЛЯЕТСЯ

1. приоритет экономических интересов медицинских организаций
2. приоритет интересов медицинских работников
3. доступность платных медицинских услуг
4. **приоритет интересов пациента при оказании медицинской помощи**

Вопрос 4

ЛЕЧАЩИЙ ВРАЧ НАЗНАЧАЕТСЯ

1. учредителем медицинской организации
2. **руководителем медицинской организации или выбирается пациентом**
3. страховой медицинской организацией
4. заведующим отделением

Вопрос 5

ОСНОВНЫМ ПРИНЦИПОМ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ЯВЛЯЕТСЯ

1. **охрана здоровья матери и ребенка**
2. охрана здоровья трудоспособного населения
3. приоритет интересов медицинского персонала
4. коммерциализация медицинских услуг

Вопрос 6

ИНФОРМИРОВАННОЕ ДОБРОВОЛЬНОЕ СОГЛАСИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО ИЛИ ОТКАЗ ОТ НЕГО ОФОРМЛЯЕТСЯ В ФОРМЕ

1. устного соглашения в присутствии свидетелей
2. записи в журнале регистрации пациентов
3. **электронного документа, подписанного усиленной ЭЦП, либо документа на бумажном носителе**
4. нотариально заверенного документа

Вопрос 7

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СВЕДЕНИЙ, СОСТАВЛЯЮЩИХ ВРАЧЕБНУЮ ТАЙНУ, БЕЗ СОГЛАСИЯ ГРАЖДАНЫНА ДОПУСКАЕТСЯ В ЦЕЛЯХ ПРОВЕДЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ И ЛЕЧЕНИЯ ГРАЖДАНЫНА, КОТОРЫЙ В РЕЗУЛЬТАТЕ СВОЕГО СОСТОЯНИЯ

1. **не способен выразить свою волю**
2. не имеет паспорта гражданина РФ
3. отказывается оплачивать медицинские услуги
4. находится в состоянии алкогольного опьянения

Вопрос 8

ПЕРВИЧНАЯ МЕДИКО-САНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ ЯВЛЯЕТСЯ

1. вспомогательным этапом лечения
2. **основой системы оказания медицинской помощи**
3. заключительным этапом медицинской реабилитации
4. частью высокотехнологичной медицинской помощи

Вопрос 9

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СВЕДЕНИЙ, СОСТАВЛЯЮЩИХ ВРАЧЕБНУЮ ТАЙНУ, БЕЗ СОГЛАСИЯ ГРАЖДАНЫНА ДОПУСКАЕТСЯ ПРИ УГРОЗЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ

1. любых соматических заболеваний
2. хронических неинфекционных заболеваний
3. профессиональных заболеваний
4. **инфекционных заболеваний, массовых отравлений и поражений**

Вопрос 10

НЕОБХОДИМЫМ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМ УСЛОВИЕМ МЕДИЦИНСКОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА ЯВЛЯЕТСЯ ДАЧА ИНФОРМИРОВАННОГО

1. согласия близких родственников пациента
2. разрешения руководителя медицинской организации
3. **добровольного согласия гражданина**
4. согласия страховой медицинской организации

Вопрос 11

СКОРАЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ СКОРАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ, МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ ОКАЗЫВАЕТСЯ ГРАЖДАНАМ

1. **бесплатно**
2. платно по прейскуранту
3. бесплатно только при наличии полиса ОМС
4. бесплатно только в дневное время

Вопрос 12

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОКАЗАНИЯ ГРАЖДАНАМ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ

1. исключительно федерального бюджета
2. личных средств граждан и работодателей
3. благотворительных фондов
4. **обязательного медицинского страхования и бюджетных ассигнований**

Вопрос 13

ПЕРВИЧНАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ МЕДИКО-САНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ ОКАЗЫВАЕТСЯ

1. фельдшерами и акушерами
2. **врачами-специалистами**
3. врачами-терапевтами участковыми
4. медицинскими сестрами общих практик

Вопрос 14

ОРГАНИЗАЦИЯ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ НАСЕЛЕНИЯ И

1. развитие частного сектора здравоохранения
2. увеличение объемов платной медицинской помощи
3. **формирование здорового образа жизни**
4. сокращение сроков стационарного лечения

Вопрос 15

ОСНОВНЫМ ПРИНЦИПОМ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ЯВЛЯЕТСЯ ДОСТУПНОСТЬ И

1. высокая стоимость медицинских услуг
2. **качество медицинской помощи**
3. приоритетность коммерческой деятельности
4. централизация медицинских учреждений

Вопрос 16

МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ ОКАЗЫВАЕТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С ПОРЯДКАМИ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ РФ ВСЕМИ МЕДИЦИНСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, А ТАКЖЕ НА ОСНОВЕ

1. методических указаний кафедр медицинских вузов
2. устава медицинской организации
3. распоряжений администрации муниципальных образований
4. **клинических рекомендаций**

Вопрос 17

ПЕРВИЧНАЯ ДОВРАЧЕБНАЯ МЕДИКО-САНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ ОКАЗЫВАЕТСЯ

1. врачами-терапевтами участковыми
2. врачами-специалистами узкого профиля
3. **фельдшерами, акушерами и другими медицинскими работниками со средним медицинским образованием**
4. санитарами и младшими медицинскими сестрами

Вопрос 18

ПАЛЛИАТИВНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ КОМПЛЕКС МЕРОПРИЯТИЙ, ВКЛЮЧАЮЩИЙ МЕДИЦИНСКИЕ

ВМЕШАТЕЛЬСТВА, ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА И МЕРОПРИЯТИЯ ПО УХОДУ, В ЦЕЛЯХ УЛУЧШЕНИЯ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ

1. **неизлечимо больных граждан**
2. граждан, проходящих плановую диспансеризацию
3. пациентов в периоде ранней послеоперационной реабилитации
4. военнослужащих и членов их семей

Вопрос 19
ОСНОВНЫМ ПРИНЦИПОМ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ЯВЛЯЕТСЯ ПРИОРИТЕТ

1. хирургических методов лечения
2. **профилактики в сфере охраны здоровья**
3. фармакотерапии перед другими методами
4. стационарной помощи перед амбулаторной

Вопрос 20
ПЕРВИЧНАЯ ВРАЧЕБНАЯ МЕДИКО-САНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ ОКАЗЫВАЕТСЯ

1. исключительно главными врачами больниц
2. узкими врачами-специалистами стационаров
3. фельдшерами скорой медицинской помощи
4. **врачами-терапевтами, врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами, врачами-педиатрами участковыми и врачами общей практики (семейными врачами)**

Вопрос 21
НЕ ОДОБРЕННЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ МЕТОДЫ ПРОФИЛАКТИКИ, ДИАГНОСТИКИ, ЛЕЧЕНИЯ И РЕАБИЛИТАЦИИ ПРИМЕНЯТЬСЯ

1. могут по письменному требованию пациента
2. могут на усмотрение лечащего врача
3. **не могут**
4. могут в рамках оказания платных медицинских услуг

Вопрос 22
ПРАВО НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РФ ИМЕЮТ ЛИЦА, ПОЛУЧИВШИЕ МЕДИЦИНСКОЕ ИЛИ ИНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РФ И ИМЕЮЩИЕ

1. **свидетельство об аккредитации специалиста**
2. только диплом об окончании вуза
3. трудовой договор с медицинской организацией
4. рекомендательное письмо от регионального министерства здравоохранения

Вопрос 23
ОБЯЗАННОСТЬ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОКАЗЫВАТЬ МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ В ЭКСТРЕННОЙ ФОРМЕ

1. носит рекомендательный характер
2. **закреплена законодательно**
3. зависит от наличия свободных коек в стационаре
4. определяется формой собственности клиники

Вопрос 24
ВРАЧЕБНАЯ КОМИССИЯ СОСТОИТ ИЗ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, ОДНОГО ИЛИ ДВУХ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, СЕКРЕТАРЯ И ЧЛЕНОВ

КОМИССИИ ИЗ ЧИСЛА

1. юристов и бухгалтеров клиники
2. представителей страховых медицинских организаций
3. представителей органов исполнительной власти
4. **врачей медицинской организации**

Вопрос 25
МЕДИЦИНСКАЯ ЭВАКУАЦИЯ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В ЦЕЛЯХ СПАСЕНИЯ ЖИЗНИ И СОХРАНЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ И ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ

1. только самостоятельное перемещение пациентов между корпусами
2. **санитарно-авиационную и санитарно-транспортную эвакуацию**
3. выдачу направлений на санаторно-курортное лечение
4. перевод сотрудников в другие филиалы клиники

Вопрос 26
ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВРАЧЕБНОЙ КОМИССИИ РЕГЛАМЕНТИРУЕТСЯ ПРИКАЗОМ

1. Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения
2. руководителя медицинской организации
3. **Министерства здравоохранения Российской Федерации**
4. Правительства Российской Федерации

Вопрос 27
ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ ВРАЧЕБНОЙ КОМИССИИ НАЗНАЧАЕТСЯ РУКОВОДИТЕЛЬ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ИЛИ

1. **заместитель руководителя медицинской организации**
2. главный бухгалтер медицинской организации
3. представитель страховой медицинской организации
4. заведующий канцелярией

Вопрос 28
ПООЩРЕНИЕ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ ЗА ДОБРОСОВЕСТНЫЙ ТРУД ЯВЛЯЕТСЯ _____ РУКОВОДИТЕЛЯ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

1. обязанностью
2. поручением вышестоящего органа
3. рекомендацией
4. **правом**

Вопрос 29
ЗА ПРОВЕДЕНИЕМ ЭКСПЕРТИЗЫ ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ

1. только общественный контроль
2. **государственный, ведомственный и внутренний контроль**
3. только международный аудит
4. контроль со стороны профсоюзных организаций

Вопрос 30
МЕДИЦИНСКИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НЕКОММЕРЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСНОВАННЫЕ НА ЛИЧНОМ ЧЛЕНСТВЕ ВРАЧЕЙ И

ОБЪЕДИНЯЮЩИЕ НЕ МЕНЕЕ 25 ПРОЦЕНТОВ ОТ ОБЩЕЙ ЧИСЛЕННОСТИ ВРАЧЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ СУБЪЕКТА РФ, ВПРАВЕ ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ В

1. **аттестации врачей для получения ими квалификационных категорий**
2. распределении финансовых средств фонда обязательного медицинского страхования
3. назначении главных врачей медицинских организаций
4. выдаче лицензий на осуществление медицинской деятельности

Вопрос 31
СОБЛЮДЕНИЕ ВРАЧЕБНОЙ ТАЙНЫ ЯВЛЯЕТСЯ _____ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ

1. правом
2. **обязанностью**
3. рекомендацией
4. пожеланием

Вопрос 32
ПОЛОЖЕНИЕ ОБ АККРЕДИТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ ДЛЯ ДОПУСКА К МЕДИЦИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УТВЕРЖДАЕТСЯ

1. законодательным органом субъекта РФ
2. Государственной Думой Федерального Собрания РФ
3. руководителем медицинской организации
4. **уполномоченным федеральным орган исполнительной власти**

Вопрос 33
РАЗГЛАШЕНИЕ СВЕДЕНИЙ, СОСТАВЛЯЮЩИХ ВРАЧЕБНУЮ ТАЙНУ, ДРУГИМ ГРАЖДАНАМ ДОПУСКАЕТСЯ

1. по устному требованию родственников пациента
2. **с письменного согласия гражданина**
3. на усмотрение лечащего врача
4. по запросу администрации по месту работы пациента

Вопрос 34

В ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НАЗНАЧЕНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ, НЕ ВХОДЯЩИХ В СООТВЕТСТВУЮЩИЕ КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ И СТАНДАРТЫ

1. допускаются, если пациент или его родственники письменно выразили такое желание
2. не допускаются
3. **допускаются в случае наличия медицинских показаний по решению врачебной комиссии** [323-ФЗ]
4. допускаются по согласованию с главным врачом медицинской организации

Вопрос 35

НА ЛЕЧАЩЕГО ВРАЧА ВОЗЛОЖЕНЫ ФУНКЦИИ ПО

1. проведению медико-социальной экспертизы
2. **организации и непосредственному оказанию пациенту медицинской помощи в период наблюдения за ним и его лечения** [323-ФЗ]

3. определению потребности медицинской организации в лекарственных средствах
4. расчету кадрового состава отделения

Вопрос 36

ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ОКАЗЫВАТЬ ПАЛЛИАТИВНУЮ МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ, МЕДИЦИНСКИЕ РАБОТНИКИ ДОЛЖНЫ ПРОЙТИ

1. аттестацию
2. сертификацию
3. аккредитацию
4. **специальное обучение** [323-ФЗ]

Вопрос 37

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ КЛИНИЧЕСКОЙ АПРОБАЦИИ УТВЕРЖДАЕТ

1. уполномоченный федеральный орган законодательной власти
2. руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения
3. руководитель медицинской организации
4. **уполномоченный федеральный орган исполнительной власти** [323-ФЗ]

Вопрос 38

В РАМКАХ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАНТИЙ БЕСПЛАТНОГО ОКАЗАНИЯ ГРАЖДАНАМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ГРАЖДАНИН ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ ИМЕЕТ ПРАВО НА ВЫБОР МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОДИН РАЗ В (В ГОДАХ)

1. 5
2. 2
3. **1** [323-ФЗ]
4. 3

Вопрос 39

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННУЮ МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ ОКАЗЫВАЮТ В

1. санаторно-курортных организациях
2. **стационарах** [323-ФЗ]
3. фельдшерско-акушерских пунктах
4. водолечебницах

Вопрос 40

ВРАЧЕБНАЯ КОМИССИЯ МОЖЕТ ПРОВОДИТЬ ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ МЕДИЦИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1. если это предусмотрено Уставом медицинской организации
2. если это рекомендовано Росздравнадзором
3. **по решению руководителя медицинской организации** [323-ФЗ]
4. по решению учредителя медицинской организации

Вопрос 41

МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ, ВКЛЮЧАЮЩАЯ В СЕБЯ ПРИМЕНЕНИЕ НОВЫХ СЛОЖНЫХ И УНИКАЛЬНЫХ МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ, С НАУЧНО ДОКАЗАННОЙ ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ, ЯВЛЯЕТСЯ

1. паллиативной
2. первичной медико-санитарной
3. скорой
4. **высокотехнологичной** [323-ФЗ]

Вопрос 42

ЕСЛИ ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПАЦИЕНТУ С ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ТРАВМОЙ ПРОВОДИТСЯ В АМБУЛАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ, ТО ЛИСТОК НЕТРУДОСПАСОБНОСТИ ФОРМИРУЕТСЯ В ДЕНЬ УСТАНОВЛЕНИЯ ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПАСОБНОСТИ НА _____, ВКЛЮЧАЯ НЕРАБОЧИЕ ПРАЗДНИЧНЫЕ И ВЫХОДНЫЕ ДНИ

1. период временной нетрудоспособности, но не более чем на 7 дней
2. период временной нетрудоспособности, но не более чем на 15 дней
3. период временной нетрудоспособности, но не более чем на 10 дней
4. **весь период временной нетрудоспособности** [1089н]

Вопрос 43

УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ (ВЫДАЧИ) ЛИСТКОВ НЕТРУДОСПАСОБНОСТИ УТВЕРЖДАЮТСЯ

1. распоряжением Федерального фонда обязательного медицинского страхования
2. инструкцией Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации
3. **приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации** [323-ФЗ]
4. постановлением Правительства Российской Федерации

Вопрос 44

ЕСЛИ ЛЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В АМБУЛАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ, ЛИСТОК НЕТРУДОСПАСОБНОСТИ ФОРМИРУЕТСЯ В ДЕНЬ УСТАНОВЛЕНИЯ ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПАСОБНОСТИ _____, ВКЛЮЧАЯ НЕРАБОЧИЕ ПРАЗДНИЧНЫЕ И ВЫХОДНЫЕ ДНИ

1. на период временной нетрудоспособности, но не более чем на 30 дней
2. на период временной нетрудоспособности, но не более чем на 21 день
3. **на весь период временной нетрудоспособности** [1089н]
4. на период временной нетрудоспособности, но не более чем на 45 дней

Вопрос 45

ФЕЛЬДШЕР СКОРОЙ ПОМОЩИ ФОРМИРОВАТЬ (ВЫДАВАТЬ) ЛИСТОК НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ

1. имеет право при отсутствии в бригаде врача
2. имеет право при работе в сельской местности
3. **не имеет права ни при каких условиях** [1089н]
4. имеет право в случае возложения на него отдельных функций лечащего врача

Вопрос 46

ЛИСТОК НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ ФОРМИРУЕТСЯ ГРАЖДАНЫНУ ПРИ НАСТУПЛЕНИИ У НЕГО ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПАСОБНОСТИ В СВЯЗИ С ЗАБОЛЕВАНИЕМ В ПЕРИОД ОТПУСКА

1. **ежегодного оплачиваемого** [1089н]
2. по беременности и родам
3. без сохранения заработной платы
4. по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет

Вопрос 47 ***(Множественный выбор)***

ДОСТУПНОСТЬ И КАЧЕСТВО МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ОБЕСПЕЧИВАЮТСЯ

1. использованием телемедицинских технологий (тоже оказывается верный)
2. **организацией мероприятий по первичной, вторичной и третичной профилактике хронических неинфекционных заболеваний** [323-ФЗ] (а этот вообще не верный, про третичную профилактику не говорится в этом законе)
3. внедрением единых подходов к назначению стимулирующих выплат медицинскому персоналу
4. **применением порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций и стандартов медицинской помощи** [323-ФЗ]

Вопрос 48 ***(Множественный выбор)***

КРИТЕРИЯМИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ МЕДИЦИНСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ЯВЛЯЮТСЯ

1. безопасность медицинской деятельности
2. **комфортность пребывания в медицинской организации** [323-ФЗ]
3. **доброжелательность и вежливость работников медицинской организации** [323-ФЗ]
4. **открытость и доступность информации о медицинской организации** [323-ФЗ]

Вопрос 49 ***(Множественный выбор)***

КАЧЕСТВО МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ ЗА СЧЕТ ПРИМЕНЕНИЯ

1. **клинических рекомендаций** [323-ФЗ]
2. методических рекомендаций
3. **стандартов медицинской помощи** [323-ФЗ]
4. **порядков оказания медицинской помощи** [323-ФЗ]

Вопрос 50 ***(Множественный выбор)***

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ОСМОТР ВСЕХ ГРАЖДАН В ВОЗРАСТЕ 18 ЛЕТ И СТАРШЕ ВКЛЮЧАЕТ ЛАБОРАТОРНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ В КРОВИ

1. общего билирубина
2. ионизированного кальция
3. **общего холестерина** [404н]
4. **глюкозы** [404н]

Вопрос 51 ***(Множественный выбор)***

ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ У НАСЕЛЕНИЯ ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА

1. **информирование граждан о факторах риска для их здоровья** [323-ФЗ]
2. повышение качества жизни граждан
3. раннее выявление симптомов заболеваний
4. **создание условий для занятий физической культурой и спортом** [323-ФЗ]

Вопрос 52 ***(Множественный выбор)***

ПРОФИЛАКТИКА НЕИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ НА УРОВНЯХ

1. **групповом** [323-ФЗ]
2. межгрупповом
3. **популяционном** [323-ФЗ]
4. **индивидуальном** [323-ФЗ]

Вопрос 53 ***(Множественный выбор)***

СТРАХОВАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ КОНТРОЛЬ ОБЪЕМОВ, СРОКОВ, КАЧЕСТВА И УСЛОВИЙ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ

1. **медико-экономической экспертизы** [326-ФЗ]
2. **медико-экономического контроля** [326-ФЗ]
3. **экспертизы качества медицинской помощи** [326-ФЗ]
4. лицензионного контроля

Вопрос 54 ***(Множественный выбор)***

ОБЯЗАННОСТЬМИ СТРАХОВАТЕЛЯ ЯВЛЯЮТСЯ

1. **регистрация и снятие с регистрационного учета в целях обязательного медицинского страхования** [326-ФЗ]
2. предоставление информации о регистрации в качестве страхователя в Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации

4. **своевременная и полная уплата страховых взносов на обязательное медицинское страхование** [326-ФЗ]

Вопрос 55 ***(Множественный выбор)***

К ПОЛНОМОЧИЯМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СФЕРЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ ОТНОСЯТ

1. **организацию обязательного медицинского страхования на всей территории страны** [326-ФЗ]
2. **установление круга лиц, подлежащих обязательному медицинскому страхованию** [326-ФЗ]
3. **организацию управления средствами обязательного медицинского страхования** [326-ФЗ]
4. утверждение территориальных программ обязательного медицинского страхования

Вопрос 56 ***(Множественный выбор)***

ОБЯЗАННОСТЯМИ МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ЯВЛЯЮТСЯ

1. проведение медико-экономического контроля реестров счетов за оказанную медицинскую помощь застрахованным лицам
2. **бесплатное оказание медицинской помощи застрахованным лицам** [326-ФЗ]
3. **ведение персонифицированного учета застрахованных лиц** [326-ФЗ] (по закону этот вариант неверен так как оргапизация ведёт учет медицинской помощи застрахованных лиц а не их самих, это делает тфомс)
4. **размещение на своем официальном сайте в сети «Интернет» информации о видах оказываемой медицинской помощи** [326-ФЗ]

Вопрос 57 ***(Множественный выбор)***

МЕДИЦИНСКАЯ СТЕРИЛИЗАЦИЯ МОЖЕТ БЫТЬ ПРОВЕДЕНА ТОЛЬКО ПО ПИСЬМЕННОМУ ЗАЯВЛЕНИЮ ГРАЖДАНЫНА

1. **в возрасте старше тридцати пяти лет** [323-ФЗ]
2. при наличии письменного согласия супруга (супруги)
3. **при наличии медицинских показаний, независимо от его возраста и наличия у него детей** [323-ФЗ]
4. **который имеет не менее двух детей, независимо от его возраста** [323-ФЗ]

Вопрос 58 ***(Множественный выбор)***

В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ № 323-ФЗ «ОБ ОСНОВАХ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» КАЖДЫЙ ИМЕЕТ ПРАВО НА

1. **бесплатную медицинскую помощь в гарантированном объёме в рамках программы государственных гарантий** [323-ФЗ]
2. **получение платных медицинских услуг и иных услуг, в том числе в соответствии с договором добровольного медицинского страхования** [323-ФЗ]
3. получение мер социальной поддержки в виде набора социальных услуг в зависимости от степени ограничений жизнедеятельности и качества жизни
4. бесплатное обеспечение всеми медицинскими изделиями, используемыми при оказании помощи, включая индивидуальные ортопедические приспособления и средства реабилитации

Вопрос 59 ***(Множественный выбор)***

НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ИМЕЮТ ПОЛНОМОЧИЯ ПО

1. **реализации программ по формированию здорового образа жизни** [323-ФЗ]
2. **санитарно-гигиеническому просвещению населения** [323-ФЗ]
3. **пропаганде донорства крови и ее компонентов** [323-ФЗ]
7. лицензированию медицинских организаций

Это вариант 59 вопроса

Вопрос 60 *(Множественный выбор)*
ПРИ ОФОРМЛЕНИИ ИНФОРМАЦИОННОГО ДОБРОВОЛЬНОГО СОГЛАСИЯ НА МЕДИЦИНСКОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО МЕДИЦИНСКИЙ РАБОТНИК ДОЛЖЕН В ДОСТУПНОЙ ФОРМЕ РАССКАЗАТЬ ПАЦИЕНТУ О

1. **целях, методах оказания медицинской помощи, связанном с ними риске** [323-ФЗ]
2. **предполагаемых результатах оказания медицинской помощи** [323-ФЗ]
3. **возможных вариантах медицинского вмешательства и его последствиях** [323-ФЗ]
4. предполагаемой длительности медицинского вмешательства

Вопрос 61 *(Множественный выбор)*
МЕДИЦИНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВПРАВЕ ОСТАВИТЬ ОБРАЩЕНИЕ ГРАЖДАНЫНА БЕЗ ОТВЕТА, ЕСЛИ В НЕМ СОДЕРЖАТСЯ

1. сведения, составляющие охраняемую законом тайну
2. **угрозы жизни, здоровью и имуществу членам семьи должностного лица** [59-ФЗ]
3. **угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица** [59-ФЗ]
4. **нецензурные либо оскорбительные выражения** [59-ФЗ]

Вопрос 62 *(Множественный выбор)*
КАЖДЫЙ ГРАЖДАНЫН ИМЕЕТ ПРАВО ПО МЕДИЦИНСКИМ ПОКАЗАНИЯМ НА БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ В МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПО

1. **медико-генетическим вопросам** [323-ФЗ]
2. **медико-психологическим аспектам семейно-брачных отношений** [323-ФЗ]
3. вопросам медико-социальной поддержки пациентов с редкими (орфанными) заболеваниями
4. **вопросам планирования семьи** [323-ФЗ]

Вопрос 63 *(Множественный выбор)*

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ

1. традиционных, апробированных
2. **сложных, уникальных** [323-ФЗ]
3. пробных, экспериментальных
4. **ресурсоемких, эффективных** [323-ФЗ]

Вопрос 64 *(Множественный выбор)*
ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ОКАЗАНИЯ ПАЛЛИАТИВНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПРЕДУСМАТРИВАЕТСЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ И

1. профессиональных некоммерческих организаций медицинских работников
2. производителей медицинского оборудования и расходных материалов для паллиативной помощи
3. **организаций социального обслуживания** [323-ФЗ]
4. **общественных объединений и некоммерческих организаций в сфере охраны здоровья** [323-ФЗ]

Вопрос 65 *(Множественный выбор)*
ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ В СТРУКТУРЕ МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ МОГУТ СОЗДАВАТЬСЯ

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ, ОКАЗЫВАЮЩИЕ УКАЗАННУЮ ПОМОЩЬ В НЕОТЛОЖНОЙ ФОРМЕ ПРИ

1. **состояниях, не требующих экстренной медицинской помощи** [323-ФЗ]
2. **состояниях, не сопровождающихся угрозой жизни пациента** [323-ФЗ]
3. состояниях, требующих проведения малоинвазивных вмешательств
4. **внезапных острых заболеваниях и обострении хронических заболеваний** [323-ФЗ]

Вопрос 66 *(Множественный выбор)*
ЕСЛИ ГРАЖДАНЫН ОТСТРАНЕН ОТ РАБОТЫ В СВЯЗИ С КАРАНТИНОМ, ТО ЛИСТОК НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ ФОРМИРУЕТСЯ НА ВЕСЬ

1. **период временного отстранения от работы** [1089н]
2. период изоляции гражданина (тоже верный)
3. инкубационный период заболевания
4. период обследования гражданина

Вопрос 67 *(Множественный выбор)*

ФОРМИРОВАНИЕ (ВЫДАЧА) И ПРОДЛЕНИЕ ЛИСТКА НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ ПОСЛЕ

1. **записи данных о состоянии здоровья пациента в медицинской документации** [1089н]
2. подачи гражданином заявления о согласии на оформление ему листка нетрудоспособности в электронном виде
3. получения добровольного информированного согласия пациента на медицинское вмешательство
4. **проведения осмотра пациента медицинским работником** [1089н]

Вопрос 68 *(Множественный выбор)*
ЛИСТКИ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ В ФОРМЕ ДОКУМЕНТА НА БУМАЖНОМ НОСИТЕЛЕ ВЫДАЮТСЯ ЛИЦАМ

1. **сведения о которых составляют государственную и иную охраняемую законом тайну** [1089н]
2. **в отношении которых реализуются меры государственной защиты** [1089н]
3. страдающим заболеваниями, представляющими опасность для окружающих
4. обратившимся с соответствующим заявлением к руководителю медицинской организации

Вопрос 69 *(Множественный выбор)*
Проверка Росздравнадзора установила, что в стационаре пациенты не получали лечебного питания. Обеспечение пациентов питанием осуществлялось сторонней коммерческой организацией путем аутсорсинга. При этом питание пациентам предоставлялось, но требования к рациону лечебного питания не соблюдались. ОЦЕНИТЕ ВЕРНОСТЬ ВСЕХ УТВЕРЖДЕНИЙ

1. в случае использования механизма аутсорсинга обеспечение лечебным питанием пациентов, находящихся на лечении в стационаре, не является обязанностью медицинской организации
2. согласно российскому законодательству, передача функции по обеспечение пациентов стационара питанием сторонней коммерческой организации на условиях аутсорсинга недопустима
3. **в случае нахождения на лечении в стационарных условиях пациент имеет право на получение лечебного питания** [323-ФЗ]
4. право пациента на получение лечебного питания в условиях стационара закреплено в Федеральном законе № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации»

Вопрос 70 *(Множественный выбор)*
Сотрудниками Росздравнадзора в рамках федерального государственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности была проведена проверка в городской поликлинике на предмет правильности выписки рецептов врачами. ОЦЕНИТЕ ВЕРНОСТЬ ВСЕХ УТВЕРЖДЕНИЙ

1. требование к врачам о запрете на выписку лекарственных препаратов на бланках, содержащих информацию рекламного характера, не закреплено законодательно

2. в соответствии с российским законодательством врачи имеют право на выписку рецептов на рецептурных бланках, на которых заранее напечатано название лекарственного препарата
3. **в соответствии с российским законодательством врачи не вправе выдавать рецепты на лекарственные препараты на бланках, содержащих информацию рекламного характера** [323-ФЗ]
4. **требование к врачам о запрете на выписку лекарственных препаратов на рецептурных бланках, на которых заранее напечатано наименование лекарственного препарата, закреплено законодательно** [323-ФЗ]

Вопрос 71 *(Множественный выбор)*
Врач центра здоровья обратился к заведующему отделением с просьбой пояснить, какие исследования в рамках профилактического медицинского осмотра можно проводить с использованием экспресс-методов. Заведующий отделением дал пояснения. ОЦЕНИТЕ ВЕРНОСТЬ ВСЕХ УТВЕРЖДЕНИЙ

1. определение уровня креатинина в крови можно проводить экспресс-методом, поскольку это позволяет выявлять пациентов с почечной недостаточностью непосредственно в центре здоровья
2. **определение уровня общего холестерина в крови можно проводить экспресс-методом непосредственно в центре здоровья, поскольку все центры здоровья оснащены таким портативным прибором** [1177н]
3. **определение уровня глюкозы в крови натощак можно проводить экспресс-методом непосредственно в центре здоровья, поскольку все центры здоровья оснащены таким портативным прибором** [1177н]
4. определение уровня гемоглобина в крови можно проводить экспресс-методом, поскольку этот метод позволяет быстро получить значение показателя непосредственно в центре здоровья

Вопрос 72 *(Множественный выбор)*
При анализе медицинской документации гражданина Ш., 42 лет, явившегося на диспансеризацию, врач установил, что месяц назад ему была сделана электрокардиограмма. Патологических изменений выявлено не было. Врач принял решение учесть результат ранее сделанной электрокардиограммы и не назначать это исследование повторно. ОЦЕНИТЕ ВЕРНОСТЬ ВСЕХ УТВЕРЖДЕНИЙ

1. **при проведении диспансеризации результаты ранее проведенных исследований могут быть учтены только в случае их подтверждения медицинскими документами гражданина** [323-ФЗ]
2. при проведении диспансеризации могут учитываться результаты ранее проведённых исследований, если с момента их выполнения прошло не более 6 месяцев
3. при проведении диспансеризации результаты ранее проведенных лабораторных и инструментальных исследований не учитываются
4. **в данной ситуации у врача есть основания учесть результаты ранее проведенных исследований** [323-ФЗ]

Вопрос 73 *(Множественный выбор)*
В Оренбургскую областную клиническую больницу поступил пациент К., которому по жизненным показаниям требуется оказание специализированной медицинской помощи в федеральном центре в городе Москве. Главный врач больницы обратился к руководителю территориального фонда обязательного медицинского страхования с просьбой решить вопрос оплаты транспортировки пациента К. на самолете санитарной авиации за счет средств обязательного медицинского страхования. ОЦЕНИТЕ ВЕРНОСТЬ ВСЕХ УТВЕРЖДЕНИЙ

1. **главный врач получил отказ от руководителя территориального фонда обязательного медицинского страхования, поскольку оплата транспортировки пациента К. санитарной авиацией за счет средств обязательного медицинского страхования невозможна** [326-ФЗ]
2. **оплата санитарно-авиационной транспортировки пациента К. согласно Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи проводится за счет средств регионального бюджета** [323-ФЗ]
3. **пациент К. имеет право на медицинскую эвакуацию в федеральный специализированный медицинский центр** [323-ФЗ]
4. все вопросы финансового обеспечения медицинской помощи застрахованным лицам в регионе находятся в компетенции территориального фонда обязательного медицинского страхования

Вопрос 74 *(Множественный выбор)*
Гражданка Д. выписана из родильного дома на пятый день после родов со своим новорожденным ребенком. На следующий день после выписки из роддома к ним пришел врач-педиатр участковый. Мать ребенка выразила опасения: «Может ли мой малыш бесплатно получать медицинскую помощь, ведь у него еще нет полиса обязательного медицинского страхования?» Врач дал разъяснения. ОЦЕНИТЕ ВЕРНОСТЬ ВСЕХ УТВЕРЖДЕНИЙ

1. гражданке Д. необходимо до истечения 60 дней со дня государственной регистрации рождения обратиться в страховую медицинскую организацию для получения полиса обязательного медицинского страхования для своего ребенка
2. **ребенок гражданки Д. является застрахованным той же страховой медицинской организацией, в которой застрахована гражданка Д.** [326-ФЗ]
3. **отсутствие полиса обязательного медицинского страхования у новорожденного ребенка гражданки Д. не является основанием для отказа в оказании ему бесплатной медицинской помощи** [326-ФЗ]
4. пока у ребенка гражданки Д. нет полиса обязательного медицинского страхования, бесплатная медицинская помощь будет оказываться только по экстренным показаниям

Вопрос 75 *(Множественный выбор)*

Медицинская сестра отказалась выдать электрокардиограмму пациента Е. его супруге, сославшись на врачебную тайну. Женщина обратилась к врачу функциональной диагностики. При внимательном изучении медицинской карты пациента Е. врач обратил внимание, что в добровольном информированном согласии содержится разрешение на информирование супруги о состоянии здоровья и проводимых исследованиях. ОЦЕНИТЕ ВЕРНОСТЬ ВСЕХ УТВЕРЖДЕНИЙ

1. **врач предоставил результаты ЭКГ-исследования супруге пациента Е. на основании того, что пациент указал ее в добровольном информированном согласии на медицинское вмешательство как лицо, которому разрешается сообщать сведения, составляющие врачебную тайну** [323-ФЗ]
2. врач не имел права выдавать результаты ЭКГ-исследования супруге пациента Е, потому что сведения, полученные при медицинском обследовании пациента, составляют врачебную тайну и не подлежат разглашению
3. **врач предоставил результаты ЭКГ-исследования супруге пациента Е., поскольку это не нарушает прав пациента и не противоречит Федеральному закону № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»** [323-ФЗ]
4. врач не имел права выдавать результаты ЭКГ-исследования супруге пациента Е, добровольное информированное согласие дается на медицинское вмешательство, а не на разглашение сведений, составляющих врачебную тайну

Вопрос 76

Медицинская сестра отказалась выдать электрокардиограмму пациента Е. его супруге, сославшись на врачебную тайну. Женщина обратилась к врачу функциональной диагностики. При внимательном изучении медицинской карты пациента Е. врач обратил внимание, что в добровольном информированном согласии содержится разрешение на информирование супруги о состоянии здоровья и проводимых исследованиях.ОЦЕНИТЕ ВЕРНОСТЬ ВСЕХ УТВЕРЖДЕНИЙ

1. врач предоставил результаты ЭКГ-исследования супруге пациента Е. на основании того, что пациент указал ее в добровольном информированном согласии на медицинское вмешательство как лицо, которому разрешается сообщать сведения, составляющие врачебную тайну

2. врач не имел права выдавать результаты ЭКГ-исследования супруге пациента Е, потому что сведения, полученные при медицинском обследовании пациента, составляют врачебную тайну и не подлежат разглашению

3. врач предоставил результаты ЭКГ-исследования супруге пациента Е., поскольку это не нарушает прав пациента и не противоречит Федеральному закону № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»

4. врач не имел права выдавать результаты ЭКГ-исследования супруге пациента Е., поскольку добровольное информированное согласие дается на медицинское вмешательство, а не на разглашение сведений, составляющих врачебную тайну

Вопрос 77

Пациент Р. обратился в поликлинику №1 с заявлением о прикреплении конкретно к врачу-терапевту участковому Г., который работает в данной медицинской организации. Главный врач ответил отказом в связи с тем, что врач Г. не согласен, так как на его участке численность прикрепленного населения существенно превышает нормативную.ОЦЕНИТЕ ВЕРНОСТЬ ВСЕХ УТВЕРЖДЕНИЙ

1. отказ главного врача правомерен, однако он должен был предложить пациенту Р. альтернативный вариант прикрепления к другому врачу-терапевту участковому****

2. отказ главного врача правомерен, так как пациент Р. имеет право на выбор врача с учетом согласия самого врача

3. отказ в прикреплении к конкретному врачу неправомерен, поскольку пациент Р. имеет право не только на выбор медицинской организации, но и на выбор врача

4. в данной ситуации, с учетом приоритета интересов пациента при оказании медицинской помощи, согласие врача Г. не требуется

Вопрос 78

Пациент У., неработающий пенсионер, 68 лет, находясь на лечении в стационаре, не соблюдает лечебно-охранительный режим: выходит за пределы отделения по личным надобностям, не уведомив медицинский персонал. Пациенты, находящиеся вместе с ним в палате, жалуются, что он мешает им отдыхать, громко разговаривает по телефону. Лечащий врач неоднократно проводил беседы с пациентом У.

о недопустимости нарушения правил внутреннего распорядка, однако пациент не изменил своего поведения. Тогда лечащий врач принял решение выписать пациента У. для продолжения лечения в амбулаторных условиях. Пациент У. считает, что таким образом лечащий врач нарушает его право на бесплатное лечение в стационаре, и обратился к заведующему отделением для разрешения возникшей конфликтной ситуации.ОЦЕНИТЕ ВЕРНОСТЬ ВСЕХ УТВЕРЖДЕНИЙ

1. пациенту У. было разъяснено, что лечащий врач вправе принять решение о выписке, если состояние здоровья пациента позволяет получать лечение в амбулаторных условиях

2. пациенту У. было разъяснено, что он обязан соблюдать режим лечения и правила поведения в медицинской организации, но ответственность за нарушение этих требований законом не предусмотрена

3. пациенту У. было разъяснено, что медицинская организация имеет право привлечь пациента У. к административной ответственности в случае нарушения правил внутреннего распорядка (неверно, так как больница не наказывает)

4. пациенту У. было разъяснено, что лечащий врач не имел права единолично принимать решение о его выписке для продолжения лечения в амбулаторных условиях(этот правильный, получается1,4)

Вопрос 79

Пациент Н., 41 год, работает по трудовому договору. В течение четырех месяцев является временно нетрудоспособным в связи с заболеванием, листок нетрудоспособности оформлен. При очередном приеме признаки временной нетрудоспособности сохраняются. По заключению врачебной комиссии клинический и трудовой прогноз благоприятный.ОЦЕНИТЕ ВЕРНОСТЬ ВСЕХ УТВЕРЖДЕНИЙ

1. в данной ситуации пациент Н. может быть направлен на медико-социальную экспертизу только при наличии обращения от его работодателя
2. **в данной ситуации пациент Н. может быть направлен на медико-социальную экспертизу по решению врачебной комиссии**
3. в данной ситуации пациент Н. на медико-социальную экспертизу не направляется
4. **в данной ситуации направление пациента Н. на медико-социальную экспертизу является обязательным**

Вопрос 80

Пациент К., 25 лет, работает по трудовому договору. Является временно нетрудоспособным в течение четырех месяцев в связи с травмой, листок нетрудоспособности оформлен. При очередном осмотре на приеме признаки временной нетрудоспособности сохраняются, при этом врачебная комиссия дала заключение о благоприятном клиническом и трудовом прогнозе.ОЦЕНИТЕ ВЕРНОСТЬ ВСЕХ УТВЕРЖДЕНИЙ

1. в данной ситуации для решения вопроса о продлении листка нетрудоспособности пациенту К. необходимо заключение врачебной комиссии****

2. в данной ситуации продление листка нетрудоспособности пациенту К. возможно, поскольку клинический и трудовой прогнозы благоприятны

3. продление листка нетрудоспособности при состояниях после травм и реконструктивных операций разрешено на срок не более десяти месяцев

4. в данной ситуации пациент К. должен быть направлен на медико-социальную экспертизу

Вопрос 1

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ МЕДИЦИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВКЛЮЧАЕТ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ, ГОСУДАРСТВЕННЫЙ, ВЕДОМСТВЕННЫЙ И _____ КОНТРОЛЬ

1. вневедомственный
2. страховой
3. **внутренний**
4. ежеквартальный

Вопрос 2

МЕДИЦИНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНО ПРОВОДИТ _____ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ МЕДИЦИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1. ведомственный
2. государственный
3. общественный
4. **внутренний**

Вопрос 3
РЕЗУЛЬТАТЫ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ МЕДИЦИНСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ВКЛЮЧЕНЫ В ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ

1. директора территориального фонда обязательного медицинского страхования субъекта Российской Федерации
2. **руководителей медицинских организаций**
3. главных медицинских сестер медицинских организаций
4. главного государственного санитарного врача субъекта Российской Федерации

Вопрос 4
РОСЗДРАВНАДЗОР ПРОВОДИТ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ В ОТНОШЕНИИ

1. финансово-хозяйственной деятельности
2. **требований по безопасному применению и эксплуатации медицинских изделий и их утилизации**
3. соблюдения противопожарной безопасности
4. соблюдения охраны труда

Вопрос 5
ПО МНЕНИЮ ЭКСПЕРТОВ ВОЗ ПОД ДОСТУПНОСТЬЮ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПОНИМАЮТ

1. приближенность медицинской организации к месту жительства и работе
2. **отсутствие географических, экономических и иных барьеров**
3. территориальный принцип оказания медицинской помощи
4. возможность выбора врача в прикреплённой медицинской организации

Вопрос 6

ВТОРИЧНАЯ ПРОФИЛАКТИКА ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ

1. меры по снижению влияния вредных факторов окружающей среды на организм человека
2. **проведение медицинских осмотров с целью выявления заболеваний на ранних стадиях развития**
3. проведение иммунопрофилактики среди различных групп населения
4. меры по формированию здорового образа жизни

Вопрос 7
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕДИЦИНСКИЕ ОСМОТРЫ ПРОВОДЯТСЯ С ЦЕЛЬЮ

1. коррекции лечения
2. формирования отчетности
3. выявления осложнений хронических заболеваний
4. **выявления ранних форм заболеваний и факторов риска**

Вопрос 7

С ЦЕЛЬЮ СВОЕВРЕМЕННОГО ВЫЯВЛЕНИЯ НАЧАЛЬНЫХ ФОРМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПРОВОДЯТ _____ МЕДИЦИНСКИЙ ОСМОТР

1. предрейсовый
2. **периодический**
3. предварительный
4. профилактический

Вопрос 8
ГРАЖДАНЕ С УСТАНОВЛЕННОЙ IIIa ГРУППОЙ ЗДОРОВЬЯ

1. подлежат диспансерному наблюдению врачом центра здоровья
2. **подлежат диспансерному наблюдению врачом-терапевтом участковым, врачами-специалистами**
3. подлежат диспансерному наблюдению врачом отделения медицинской профилактики
4. не подлежат диспансерному наблюдению

Вопрос 8

РАЗРАБОТКА И РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММ ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ ОБЕСПЕЧИВАЕТ ПРИОРИТЕТ
1. профилактики в сфере охраны здоровья
2. социальной защищенности граждан
3. интересов пациента
4. охраны здоровья детей

Вопрос 9
АНКЕТИРОВАНИЕ ПАЦИЕНТОВ, ПРОВОДИМОЕ В РАМКАХ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО ОСМОТРА, НАПРАВЛЕНО НА ОЦЕНКУ

1. удовлетворенности пациентов организацией профилактических медицинских осмотров и диспансеризации
2. **признаков хронических неинфекционных заболеваний и факторов риска их развития у пациентов**
3. их информированности о предоставляемых медицинской организацией услугах по профилактике хронических неинфекционных заболеваний
4. доступности исследований и консультаций при выполнении профилактических медицинских осмотров и диспансеризации

Вопрос 9

СОГЛАСНО СТ. 18 ФЗ-323 ОТ 21.11.2011 «ОБ ОСНОВАХ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» ПРАВО НА ОХРАНУ ЗДОРОВЬЯ ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ, В ЧАСТНОСТИ

1. созданием автоматизированного рабочего места медицинского работника
2. обеспечением дополнительных льгот
3. **доступной и качественной медицинской помощью**
4. обеспечением лекарственных препаратов

Вопрос 10
С ЦЕЛЬЮ СВОЕВРЕМЕННОГО ВЫЯВЛЕНИЯ НАЧАЛЬНЫХ ФОРМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПРОВОДЯТ _____ МЕДИЦИНСКИЙ ОСМОТР

1. предрейсовый
2. профилактический
3. **периодический**
4. предварический

Вопрос 10

ВТОРИЧНАЯ ПРОФИЛАКТИКА ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ

1. проведение иммунопрофилактики среди различных групп населения
2. меры по снижению влияния вредных факторов окружающей среды на организм человека
3. меры по формированию здорового образа жизни
4. **проведение медицинских осмотров с целью выявления заболеваний на ранних стадиях развития**

Вопрос 11

КОМПЛЕКС МЕРОПРИЯТИЙ, ВКЛЮЧАЮЩИЙ В СЕБЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ОСМОТР И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ОБСЛЕДОВАНИЙ, ПРОВОДИМОХ В ЦЕЛЯХ ОЦЕНКИ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ В ОТНОШЕНИИ ОПРЕДЕЛЕННЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ, НАЗЫВАЕТСЯ

1. консультацией
2. **диспансеризацией**
3. санацией
4. реабилитацией

Вопрос 11

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРИВИВОК РЕБЕНКУ ОТ РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) ТРЕБУЕТСЯ

1. заявление в письменной форме на имя руководителя медицинской организации
2. **информированное добровольное согласие в письменной форме**
3. согласие в устной форме
4. разрешение в письменной форме

____

Вопрос 12
МЕДИЦИНСКИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НЕКОММЕРЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ (АССОЦИАЦИИ, СОЮЗЫ) ВПРАВЕ УЧАСТВОВАТЬ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДОВ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ, В РАЗРАБОТКЕ ПРОГРАММ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ БЕСПЛАТНОГО ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, ЕСЛИ ОТ ОБЩЕЙ ЧИСЛЕННОСТИ ВРАЧЕЙ ДАННОЙ ТЕРРИТОРИИ СУБЪЕКТА РФ В НИХ СОСТОИТ _____ % ВРАЧЕЙ

1. 40
2. **25**
3. 50
4. 30

Вопрос 12

ГРАЖДАНЕ С УСТАНОВЛЕННОЙ IIIб ГРУППОЙ ЗДОРОВЬЯ

1. подлежат диспансерному наблюдению врачом отделения медицинской профилактики
2. не подлежат диспансерному наблюдению
3. **подлежат диспансерному наблюдению врачом-терапевтом участковым, врачами-специалистами**
4. подлежат диспансерному наблюдению врачом центра здоровья

____

Вопрос 13

СОГЛАСНО СТ. 18 323-ФЗ ОТ 21.11.2011 «ОБ ОСНОВАХ ОХРАЗО ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» ПРАВО НА ОХРАНУ ЗДОРОВЬЯ ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ, В ЧАСТНОСТИ

1. внедрением в медицинскую практику новых технологий
2. предоставлением дополнительных льгот
3. выделением основных продуктов питания малоимущим группам населения
4. **производством и реализацией продуктов питания соответствующего качества**

Вопрос 13

СОГЛАСНО СТ. 18 ФЗ № 323 ОТ 21.11.2011 «ОБ ОСНОВАХ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН В РФ» ПРАВО НА ОХРАНУ ЗДОРОВЬЯ ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ, В ЧАСТНОСТИ

1. охраной окружающей среды

2. предоставлением выбора места жительства
3. охраной имущества
4. обеспечением дополнительных льгот

———

Вопрос 14

СТРУКТУРА ТАРИФА НА ОПЛАТУ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В СИСТЕМЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ

1. Федеральным законом Российской Федерации

2. распоряжением органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации
3. постановлением Правительства Российской Федерации
4. распоряжением Федерального фонда обязательного медицинского страхования

Вопрос 14

СТРАХОВАТЕЛЯМИ ДЛЯ НЕРАБОТАЮЩИХ ГРАЖДАН ЯВЛЯЮТСЯ

1. страховые медицинские организации
2. индивидуальные предприниматели
3. **органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации**
4. муниципальные органы власти

Вопрос 14

ПОЛИС ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ ИМЕЕТ СИЛУ

1. только на территории того субъекта Российской Федерации, где выдан страховой полис
2. **на всей территории Российской Федерации**
3. только на территории того субъекта Российской Федерации, где проживает застрахованный
4. только на территории других государств, с которыми Российская Федерация имеет дипломатические отношения

———

Вопрос 15

ЗА СЧЕТ ГОСУДАРСТВА ФИНАНСИРУЕТСЯ СТРАХОВАНИЕ

1. имущества
2. добровольное медицинское
3. смешанное
4. **обязательное медицинское**

Вопрос 15
ЭКСПЕРТ КАЧЕСТВА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ДОЛЖЕН ИМЕТЬ СТАЖ РАБОТЫ ПО СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ВРАЧЕБНОЙ СПЕЦИАЛЬНОСТИ НЕ МЕНЕЕ (В ГОДАХ)

1. 10
2. 3
3. **5**
4. 7

Вопрос 15

СРЕДСТВА, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ ОПЛАТЫ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, ОКАЗАННОЙ В РАМКАХ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ, ЯВЛЯЮТСЯ

1. собственными средствами страховых медицинских организаций
2. **средствами целевого финансирования**
3. временно свободными средствами территориальных фондов обязательного медицинского страхования
4. временно свободными средствами Федерального фонда обязательного медицинского страхования

____

Вопрос 16
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ КАЖДЫЙ ИМЕЕТ ПРАВО НА МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ В ГАРАНТИРОВАННОМ ОБЪЕМЕ, ОКАЗЫВАЕМУЮ БЕЗ ВЗИМАНИЯ ПЛАТЫ, В СООТВЕТСТВИИ С

1. национальным проектом «Здравоохранение»
2. **программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи**
3. programme модернизации здравоохранения
4. целевыми муниципальными программами

Вопрос 16

РАЗМЕР И ПОРЯДОК РАСЧЕТА ТАРИФА СТРАХОВОГО ВЗНОСА НА ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ НЕРАБОТАЮЩЕГО НАСЕЛЕНИЯ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ

1. распоряжением Федерального фонда обязательного медицинского страхования
2. распоряжением органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации
3. **федеральным законом Российской Федерации**
4. постановлением Правительства Российской Федерации

Вопрос 16

ПОЛИС ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ ДОКУМЕНТОМ

1. удостоверяющим право застрахованного лица на бесплатное оказание медицинской помощи за пределами Российской Федерации

2. **удостоверяющим право застрахованного лица на бесплатное оказание медицинской помощи на всей территории Российской Федерации**
3. позволяющим получить медицинскую помощь по программе добровольного медицинского страхования
4. подтверждающим уплату гражданином страховых взносов в системе обязательного медицинского страхования

____

Вопрос 17
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ КАЖДЫЙ ИМЕЕТ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ И ИНЫХ УСЛУГ, В ТОМ ЧИСЛЕ В СООТВЕТСТВИИ С ДОГОВОРОМ _____ СТРАХОВАНИЯ

1. добровольного
2. социальногообязательногомедицинского
3. общегражданского
4. **добровольного медицинского**

Вопрос 17

С ЮРИДИЧЕСКОЙ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ КАК СОБЫТИЕ

1. предполагаемое
2. прошедшее
3. **совершившееся**
4. настоящее

Вопрос 17

ЗА СЧЕТ ГОСУДАРСТВА ФИНАНСИРУЕТСЯ СТРАХОВАНИЕ
1. обязательное медицинское
2. смешанное
3. имущества
4. добровольное медицинское

Вопрос 18
ПОЛИС ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ ДОКУМЕНТОМ

1. позволяющим получить медицинскую помощь по программе добровольного медицинского страхования
2. подтверждающим уплату гражданином страховых взносов в системе обязательного медицинского страхования
3. **удостоверяющим право застрахованного лица на бесплатное оказание медицинской помощи на всей территории Российской Федерации**
4. удостоверяющим право застрахованного лица на бесплатное оказание медицинской помощи за пределами Российской Федерации

Вопрос 18

ЕСЛИ ЗАСТРАХОВАННОЕ ЛИЦО НЕ ПОДАВАЛО ЗАЯВЛЕНИЕ О ВЫБОРЕ СТРАХОВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ТО ТАКОЙ ВЫБОР ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ
1. территориальным фондом обязательного медицинского страхования
2. Федеральным фондом обязательного медицинского страхования
3. органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации
4. медицинской организацией, к которой прикреплен гражданин

Вопрос 19
РАЗМЕР И ПОРЯДОК РАСЧЕТА ТАРИФА СТРАХОВОГО ВЗНОСА НА ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ НЕРАБОТАЮЩЕГО НАСЕЛЕНИЯ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ

1. постановлением Правительства Российской Федерации
2. **Федеральным законом Российской Федерации**
3. распоряжением Федерального фонда обязательного медицинского страхования
4. распоряжением органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации

Вопрос 19

ЗА СЧЕТ ГОСУДАРСТВА ФИНАНСИРУЕТСЯ СТРАХОВАНИЕ

1. добровольное медицинское
2. смешанное
3. **обязательное медицинское**
4. имущества

Вопрос 19

В РФ каждый имеет право на медицинскую помощь в гарантированном объёме, оказываемую без взимания платы в соответствии с
а) национальным проектом «Здравоохранение»
б) программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи
в) программой модернизации здравоохранения
г) целевыми муниципальными программами

Вопрос 20
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ

1. государственным органом власти
2. органом законодательной власти
3. центральным органом государственной власти
4. **федеральным органом исполнительной власти**

Вопрос 20

В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ ОТ 21.11.2011 № 323 «ОБ ОСНОВАХ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» ПАЦИЕНТ ИМЕЕТ ПРАВО НА ВЫБОР

1. методик лабораторного исследования
2. лекарственных средств при лечении в стационаре
3. **врача и медицинской организации**
4. методик инструментального обследования

Вопрос 20
Одним из принципов охраны здоровья в РФ является
а) безвозмездность оказания медицинской помощи
б) запрет эвтаназии
в) государственный характер здравоохранения

Вопрос 21
ПАЦИЕНТ ИМЕЕТ ПРАВО НА

1. бесплатное обеспечение лекарственными препаратами в амбулаторных условиях независимо от заболевания
2. **получение информации о своих правах и обязанностях**
3. самостоятельный выбор методов лабораторной диагностики
4. самостоятельный выбор схемы лечения

Вопрос 21

КАЖДАЯ ЖЕНЩИНА ИМЕЕТ ПРАВО НА ИСКУССТВЕННОЕ ПРЕРЫВАНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ ПО ЕЕ ЖЕЛАНИЮ ПРИ СРОКЕ БЕРЕМЕННОСТИ ДО (В НЕДЕЛЯХ)

1. двенадцати
2. четырнадцати
3. восемнадцати
4. шестнадцати

Вопрос 22
ОДНОЙ ИЗ ОБЯЗАННОСТЕЙ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ

1. участие в клинической апробации лекарственных препаратов для подтверждения их эффективности
2. проведение мероприятий по снижению риска травматизма и профессиональных заболеваний
3. осуществление научной и (или) научно-прикладной деятельности в области медицины
4. **участие в реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи**

Вопрос 22

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ ОПРЕДЕЛЕНЫ В

1. Гражданском кодексе Российской Федерации
2. Федеральном законе № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации»
3. **Федеральном законе № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»**
4. Трудовом кодексе Российской Федерации

Вопрос 23
СВЕДЕНИЯ О РОЖДЕННОМ РЕБЕНКЕ И ЕГО МАТЕРИ МЕДИЦИНСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ

1. передают органам местного самоуправления, в т.ч. администрациям сельских поселений
2. передают в Министерство юстиции Российской Федерации
3. **вносят в Федеральный реестр медицинских документов о рождении**
4. вносят в Единый государственный реестр записей актов гражданского состояния

Вопрос 23

ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЕМ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ

1. социальная помощь
2. предоставление санаторно-курортных услуг
3. диагностика

4. профилактика

Вопрос 24
ОДНИМ ИЗ ОГРАНИЧЕНИЙ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МЕДИЦИНСКИМИ РАБОТНИКАМИ СВОЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ С РАЗЛИЧНЫМИ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИМИ КОМПАНИЯМИ ЯВЛЯЕТСЯ ЗАПРЕТ НА

1. участие в научно-практических конференциях
2. участие в работе некоммерческих профессиональных медицинских ассоциаций
3. заключение договоров о проведении клинических исследований лекарственных препаратов
   4. оплату отдыха, проезда к месту отдыха за счет организаций, занимающихся разработкой, производством и (или) реализацией лекарственных препаратов

Вопрос 24

ПРИОРИТЕТ ИНТЕРЕСОВ ПАЦИЕНТА ПРИ ОКАЗАНИИ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ЯВЛЯЕТСЯ ОСНОВНЫМ _____ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ

1. критерием
2. правилом
3. понятием
   4. принципом

Вопрос 25
ПРИ ЛИЧНОМ ОБРАЩЕНИИ К РУКОВОДИТЕЛЮ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ С ВОПРОСАМИ, РЕШЕНИЕ КОТОРЫХ НЕ ВХОДИТ В ЕГО КОМПЕТЕНЦИЮ, ГРАЖДАНИНУ ДАЕТСЯ

1. отказ в рассмотрении обращения
2. разъяснение о необходимости изложить свое обращение в письменном виде
3. **разъяснение, куда и в каком порядке ему следует обратиться**
4. разъяснение о рассмотрении его обращения в особом порядке

Вопрос 25

СУРРОГАТНОЙ МАТЕРЬЮ МОЖЕТ БЫТЬ ЖЕНЩИНА В ВОЗРАСТЕ ОТ ДВАДЦАТИ ДО ТРИДЦАТИ ПЯТИ ЛЕТ, ПОЛУЧИВШАЯ МЕДИЦИНСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОБ УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОМ СОСТОЯНИИ ЗДОРОВЬЯ, ИМЕЮЩАЯ _____ ЗДОРОВОГО(ЫХ) СОБСТВЕННОГО(ЫХ) РЕБЕНКА(ДЕТЕЙ)

1. 3
2. **1**
3. 2
4. 4

Вопрос 26

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ОПРЕДЕЛЕНЫ В
1. Федеральном законе от 21.11.2011 № 323 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»
2. Гражданском кодексе Российской Федерации
3. Налоговом кодексе Российской Федерации
4. Бюджетном кодексе Российской Федерации

Вопрос 26
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ОПРЕДЕЛЕНЫ В
1. Федеральном законе от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»

2. Бюджетном кодексе Российской Федерации
3. Гражданском кодексе Российской Федерации
4. Налоговом кодексе Российской Федерации

Вопрос 27
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ ГРАЖДАННИН МОЖЕТ ВЫБИРАТЬ МЕДИЦИНСКУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ ___ В ГОД

1. 2 раза
2. 3 раза
3. **1раз**
4. 4 раза

Вопрос 27

ОТВЕТ НА ОБРАЩЕНИЕ ГРАЖДАНА, ПОСТУПИВШЕЕ ДОЛЖНОСТНОМУ ЛИЦУ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ, ПОДЛЕЖИТ

1. размещению на информационном стенде медицинской организации
2. **направлению по адресу электронной почты, указанному в обращении**
3. размещению на официальном сайте медицинской организации
4. выдаче на бумажном носителе лично в медицинской организации

Вопрос 27

СВЕДЕНИЯ ОБ УМЕРШЕМ ЛИЦЕ МЕДИЦИНСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ

1. вносят в Единый государственный реестр записей актов гражданского состояния
2. передают органам местного самоуправления, в т.ч. администрациям сельских поселений
3. передают в Министерство юстиции Российской Федерации
4. **вносят в Федеральный реестр медицинских документов о смерти**

Вопрос 28
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА (РОСПОТРЕБНАДЗОР) ЯВЛЯЕТСЯ

1. некоммерческой профессиональной медицинской организацией
2. **Федеральным органом исполнительной власти**
3. саморегулируемой организацией
4. федеральным органом законодательной власти

Вопрос 28

ПРИОРИТЕТ ИНТЕРЕСОВ ПАЦИЕНТА ПРИ ОКАЗАНИИ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ РЕАЛИЗУЕТСЯ ПУТЕМ

1. соблюдения правил техники безопасности при осуществлении медицинской деятельности
2. соблюдения норм трудовой дисциплины
3. рационального использования лекарственных средств у льготных категорий граждан
4. **соблюдения этических и моральных норм, уважительного и гуманного отношения к пациенту**

Вопрос 28
ВРАЧ, НА КОТОРОГО ВОЗЛОЖЕНЫ ФУНКЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И НЕПОСРЕДСТВЕННОМУ ОКАЗАНИЮ ПАЦИЕНТУ МЕДИЦИНСКОЙ

ПОМОЩИ В ПЕРИОД НАБЛЮДЕНИЯ ЗА НИМ И ЕГО ЛЕЧЕНИЯ, ЯВЛЯЕТСЯ

1. врачом неотложной помощи
2. дежурным врачом
3. **лечащим врачом**
4. заведующим отделением

Вопрос 29
ПРАВО НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ИМЕЮТ ЛИЦА, ПОЛУЧИВШИЕ МЕДИЦИНСКОЕ ИЛИ ИНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИХСКИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И
1. прошедшие аккредитацию
2. прошедшие лицензирование
3. прошедшие сертификацию
4. прошедшие аттестацию

Вопрос 29
ПИСЬМЕННОЕ ОБРАЩЕНИЕ ГРАЖДАНА ПОДЛЕЖИТ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ РЕГИСТРАЦИИ В ТЕЧЕНИЕ _____ ДНЕЙ С МОМЕНТА ПОСТУПЛЕНИЯ В МЕДИЦИНСКУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ

1. 2
2. 5
3. 4
4. **3**

Вопрос 29
ОДНОЙ ИЗ ОБЯЗАННОСТЕЙ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ

1. проведение мероприятий по снижению риска травматизма и профессиональных заболеваний
2. участие в клинической апробации лекарственных препаратов для подтверждения их эффективности
3. осуществление научной и (или) научно-прикладной деятельности
   4. участие в реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи

Вопрос 29

МЕДИЦИНСКИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НЕКОММЕРЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСНОВАННЫЕ НА ЛИЧНОМ ЧЛЕНСТВЕ ВРАЧЕЙ И ОБЪЕДИНЯЮЩИЕ НЕ МЕНЕЕ 25 ПРОЦЕНТОВ ОТ ОБЩЕЙ ЧИСЛЕННОСТИ ВРАЧЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ СУБЪЕКТА РФ, ВПРАВЕ ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ В

1. проведении обучения в ординатуре с целью подготовки кадров высшей квалификации
2. проведении внеплановых проверок Росздравнадзора
3. лицензировании медицинской деятельности
   4. аттестации врачей для получения ими квалификационных категорий

Вопрос 30
КАЖДАЯ ЖЕНЩИНА ИМЕЕТ ПРАВО НА ИСКУССТВЕННОЕ ПРЕРЫВАНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ ПО ЕЕ ЖЕЛАНИЮ ПРИ СРОКЕ БЕРЕМЕННОСТИ ДО (В НЕДЕЛЯХ)

1. шестнадцати
2. **двенадцати**
3. восемнадцати
4. четырнадцати

Вопрос 30

ОСНОВНЫМ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫМ ДОКУМЕНТОМ, РЕГУЛИРУЮЩИМ СФЕРУ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ЯВЛЯЕТСЯ

1. Федеральный закон от 29.11.2010 г. № 326 «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации»
2. Международная классификация болезней 10 пересмотра
3. **Федеральный закон от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»**
4. Федеральный закон от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей»

Вопрос 30

ПРИ ЛИЧНОМ ПРИЕМЕ У РУКОВОДИТЕЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ГРАЖДАН ПРЕДЪЯВЛЯЕТ

1. свой полис обязательного медицинского страхования
2. свой страховой номер индивидуального лицевого счета
3. документ, подтверждающий отсутствие у него судимости
4. **документ, удостоверяющий его личность**

Вопрос 30

ПАЦИЕНТ ИМЕЕТ ПРАВО НА

1. выбор лиц, которым может быть передана информация о состоянии его здоровья

2. самостоятельный выбор схемы лечения
3. самостоятельный выбор методов инструментальной диагностики
4. получение лечебного питания в амбулаторных условиях

Вопрос 31

В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ ОТ 21.11.2011 № 323 «ОБ ОСНОВАХ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» ПАЦИЕНТ ИМЕЕТ ПРАВО НА ВЫБОР

1. лекарственных средств при лечении в стационаре
2. методик лабораторного исследования
3. методик инструментального обследования
4. **врача и медицинской организации**

Вопрос 31

ВНЕСЕНИЕ ДОЛЖНОСТНЫМ ЛИЦОМ ЗАВЕДОМО ЛОЖНЫХ СВЕДЕНИЙ В МЕДИЦИНСКУЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ ЯВЛЯЕТСЯ

1. мошенничеством
2. превышением должностных полномочий
3. **служебным подлогом**
4. халатностью

Вопрос 32

ЛИЦА, ЗАКЛЮЧЕННЫЕ ПОД СТРАЖУ, ИМЕЮТ ПРАВО НА ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

1. в государственных и муниципальных медицинских организациях

2. только в медицинских организациях федеральной службы исполнения наказаний
3. в медицинских организациях частной системы здравоохранения
4. в медицинских организациях, имеющих лицензию на оказание медицинской помощи заключенным под стражу

Вопрос 32
ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО НЕЗАВИСИМО ОТ ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЙ ФОРМЫ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЕ МЕДИЦИНСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ЯВЛЯЕТСЯ _____ ОРГАНИЗАЦИЕЙ

1. социальной
2. **медицинской**
3. санитарно-просветительной
4. фармацевтической

Вопрос 32

КОМПЛЕКС МЕДИЦИНСКИХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ ПО НАЗНАЧЕНИЮ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА И НАПРАВЛЕННЫХ НА УСТРАНЕНИЕ ИЛИ ОБЛЕГЧЕНИЕ ПРОЯВЛЕНИЙ ЗАБОЛЕВАНИЯ, ЯВЛЯЕТСЯ

1. охраной здоровья
2. санацией
3. **лечением**
4. профилактикой

Вопрос 32

Государственный контроль за обеспечением безопасности донорской крови и её компонентов осуществляет
а) Министерство здравоохранения РФ
б) Роспотребнадзор
в) центральный орган управления здравоохранением субъекта
г) Федеральное медико-биологическое агентство

Вопрос 32
НЕОБХОДИМЫМ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМ УСЛОВИЕМ МЕДИЦИНСКОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА ЯВЛЯЕТСЯ

1. заявление о выборе медицинской организации
2. **дача информированного добровольного согласия**
3. электронное заключение врачебной комиссии
4. письменное направление от лечащего врача

Вопрос 33
ДОСТУПНОСТЬ И КАЧЕСТВО МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ЯВЛЯЮТСЯ ОДНИМ ИЗ ОСНОВНЫХ _____ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ

1. факторов
2. критериев
3. понятий
4. **принципов**

Вопрос 33

МЕДИЦИНСКИЕ РАБОТНИКИ ИМЕЮТ ПРАВО НА

1. предоставление пациенту образцов лекарственных препаратов, полученных бесплатно от фармацевтических компаний
2. оплату отдыха, проезда к месту отдыха за счет организаций, занимающихся разработкой, производством и (или) реализацией лекарственных препаратов
3. **создание профессиональных некоммерческих организаций**

4. выписку лекарственных препаратов на бланках, содержащих рекламную информацию

Вопрос 33

Положение об аккредитации специалистов для допуска к медицинской деятельности утверждается
а) уполномоченным федеральным органом исполнительной власти
б) органом законодательной власти субъекта РФ
в) уполномоченным федеральным органом законодательной власти
г) органом исполнительной власти субъекта РФ

Вопрос 34
СКОРАЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ СКОРАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ, МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ ОКАЗЫВАЕТСЯ ГРАЖДАНАМ В ЭКСТРЕННОЙ И НЕОТЛОЖНОЙ ФОРМЕ
1. бесплатно
2. платно вне медицинских организаций
3. платно при травмах и отравлениях
4. с частичной оплатой транспортных услуг

Вопрос 34
ПЕРВИЧНАЯ МЕДИКО-САНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ МОЖЕТ ОКАЗЫВАТЬСЯ

1. в диспансере
2. **в кабинете врача общей практики**
3. в бюро судебно-медицинской экспертизы
4. на станции переливания крови

Вопрос 34

Перечень медицинских показаний и противопоказаний для медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения утверждается
а) главным внештатным специалистом по медицинской реабилитации
б) уполномоченным федеральным органом исполнительной власти
в) руководителем санаторно-курортной организации
г) уполномоченным федеральным органом законодательной власти

Вопрос 35
ЛИЦА, ИНФИЦИРОВАННЫЕ ВИРУСОМ ИММУНОДЕФИЦИТА ЧЕЛОВЕКА, ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ ПРЕПАРАТАМИ ВКЛЮЧАЮТСЯ В

1. муниципальный регистр
2. персонифицированный реестр
3. **Федеральный регистр**
4. Национальный реестр

Вопрос 35

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ШТАТНЫЕ НОРМАТИВЫ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ЕЕ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ВКЛЮЧЕНЫ В

1. стандарт медицинской помощи
2. **порядок оказания медицинской помощи**
3. стандартные операционные процедуры
4. клинические рекомендации

Вопрос 35

ПЕРВИЧНАЯ МЕДИКО-САНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ ВКЛЮЧАЕТ

1. профилактику заболеваний

2. оказание высокотехнологичной помощи

3. обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации

4. помощь при дорожно-транспортных происшествиях

Вопрос 36

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННУЮ МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ ОКАЗЫВАЮТ В

1. водолечебницах
2. **стационарах**
3. санаторно-курортных организациях
4. фельдшерско-акушерских пунктах

Вопрос 36

МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ, ОТСРОЧКА ОКАЗАНИЯ КОТОРОЙ НА ОПРЕДЕЛЕННОЕ ВРЕМЯ НЕ ПОВЛЕЧЕТ УХУДШЕНИЯ СОСТОЯНИЯ ПАЦИЕНТА, УГРОЗЫ ЕГО ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЮ, СЧИТАЕТСЯ

1. оптимальной
2. отложенной
3. **плановой**
4. амбулаторной

Вопрос 36

ВРАЧЕБНАЯ КОМИССИЯ МОЖЕТ ПРОВОДИТЬ ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ МЕДИЦИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1. по решению руководителя медицинской организации

2. если это предусмотрено Уставом медицинской организации

3. если это рекомендовано Росздравнадзором

4. по решению учредителя медицинской организации

Вопрос 37

МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ, ОТСРОЧКА ОКАЗАНИЯ КОТОРОЙ НА ОПРЕДЕЛЕННОЕ ВРЕМЯ НЕ ПОВЛЕЧЕТ УХУДШЕНИЯ СОСТОЯНИЯ ПАЦИЕНТА, УГРОЗЫ ЕГО ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЮ, СЧИТАЕТСЯ

1. отложенной
2. амбулаторной
3. оптимальной
4. **плановой**

Вопрос 37

КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ВРАЧЕБНОЙ КОМИССИИ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ

1. руководитель Росздравнадзора
2. **руководитель медицинской организации**
3. уполномоченный федеральный орган исполнительной власти
4. уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации

Вопрос 37

ПЕРЕЧЕНЬ МЕДИЦИНСКИХ ПОКАЗАНИЙ И ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ ДЛЯ МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ И САНАТОРНО-КУРОРТНОГО ЛЕЧЕНИЯ УТВЕРЖДАЕТСЯ

1. уполномоченным федеральным органом исполнительной власти

2. руководителем санаторно-курортной организации

3. главным внештатным специалистом по медицинской реабилитации

4. уполномоченным федеральным органом законодательной власти

Вопрос 38

ПЕРЕЧЕНЬ МЕДИЦИНСКИХ ПОКАЗАНИЙ И ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ ДЛЯ МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ И САНАТОРНО-КУРОРТНОГО ЛЕЧЕНИЯ УТВЕРЖДАЕТСЯ

1. главным внештатным специалистом по медицинской реабилитации
2. **уполномоченным федеральным органом исполнительной власти**
3. руководителем санаторно-курортной организации
4. уполномоченным федеральным органом законодательной власти

Вопрос 38

ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ РЕШЕНИЕ О МЕДИЦИНСКОЙ ЭВАКУАЦИИ ВПРАВЕ ПРИНИМАТЬ

1. руководитель Всероссийской службы медицины катастроф

2. глава Регионального комитета по чрезвычайным ситуациям

3. командующий Всероссийской службой гражданской обороны

4. руководитель территориального органа МЧС России

Вопрос 39

СОГЛАСНО СТ. 41 КОНСТИТУЦИИ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ РФ ОКАЗЫВАЕТСЯ ГРАЖДАНАМ

1. платно или бесплатно, в зависимости от места жительства
2. платно
3. **бесплатно**
4. платно или бесплатно, в зависимости от возраста

Вопрос 39

ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ИНОСТРАННЫМ ГРАЖДАНАМ ОПРЕДЕЛЯЕТ

1. руководитель медицинской организации
2. **Правительство Российской Федерации**
3. уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации
4. Министерство здравоохранения Российской Федерации

Вопрос 39

СКОРАЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ СКОРАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ, МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ ОКАЗЫВАЕТСЯ ГРАЖДАНАМ В ЭКСТРЕННОЙ И НЕОТЛОЖНОЙ ФОРМЕ

1. платно вне медицинских организаций
2. **бесплатно**

3. платно при травмах и отравлениях
4. с частичной оплатой транспортных услуг

Вопрос 40
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ВРАЧЕБНОЙ КОМИССИИ ВЫДАЕТСЯ ПАЦИЕНТУ НЕ ПОЗДНЕЕ

1. трех календарных дней со дня поступления запроса
2. трех календарных дней со дня оформления протокола
3. трех рабочих дней со дня поступления запроса
   4. трех рабочих дней со дня оформления протокола

Вопрос 40

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНАЯ ПОМОЩЬ, ОКАЗЫВАЕТСЯ

1. на дому
2. **в стационарных условиях и в дневном стационаре**
3. в санатории
4. в центрах паллиативной помощи

Вопрос 41
ОРГАНИЗАЦИЯ ОКАЗАНИЯ ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПО ПРИНЦИПУ

1. плановому
2. **территориально-участковому**
3. этапному
4. административному

Вопрос 41

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ КЛИНИЧЕСКОЙ АПРОБАЦИИ УТВЕРЖДАЕТ
1. уполномоченный федеральный орган исполнительной власти
2. руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения
3. уполномоченный орган законодательной власти
4. руководитель медицинской организации

Вопрос 41

К АМБУЛАТОРНЫМ УСЛОВИЯМ ОТНОСИТСЯ ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

1. в местах общественного питания, торговли
2. **на дому при вызове медицинского работника**
3. в транспортном средстве общего пользования
4. при медицинской эвакуации

Вопрос 42
ФОРМИРОВАНИЕ ЛИСТКА НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ ЗАПРЕЩЕНО
1. лицам, находящимся под стражей или административным арестом
2. государственным гражданским служащим

Вопрос 42
ВЫДАЧА ЛИСТКА НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ НА БУМАЖНОМ НОСИТЕЛЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПРИ ПРЕДЪЯВЛЕНИИ

1. идентификационного номера налогоплательщика
2. **документа, удостоверяющего личность**
3. страхового номера индивидуального лицевого счета гражданина в системе индивидуального (персонифицированного) учета
4. заявления на имя главного врача медицинской организации, в которой гражданин был признан нетрудоспособным

Вопрос 42
ЛИЦАМ, У КОТОРЫХ ЗАБОЛЕВАНИЕ ИЛИ ТРАВМА НАСТУПИЛИ В ТЕЧЕНИЕ _____ КАЛЕНДАРНЫХ ДНЕЙ СО ДНЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ РАБОТЫ ПО ТРУДОВОМУ ДОГОВОРУ, ФОРМИРУЕТСЯ ЛИСТОК НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ

1. 5
2. 10
3. **30**
4. 15

Вопрос 43
ЕСЛИ ГРАЖДАННИН ОТСТРАНЕН ОТ РАБОТЫ В СВЯЗИ С КАРАНТИНОМ, ТО ЛИСТОК НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ ФОРМИРУЕТСЯ

1. врачом по общей гигиене
2. врачом-инфекционистом
3. врачом-эпидемиологом
4. **врачом-инфекционистом, а в случае его отсутствия – лечащим врачом**

Вопрос 43

ЛИСТОК НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ ПРИ УСЫНОВЛЕНИИ ОДНОГО РЕБЕНКА В ВОЗРАСТЕ ДО ТРЕХ МЕСЯЦЕВ ФОРМИРУЕТСЯ НА СРОК ДО _____ КАЛЕНДАРНЫХ ДНЕЙ, ИСЧИСЛЯЕМЫЙ С ДАТЫ РОЖДЕНИЯ РЕБЕНКА

1. 140
2. **70**
3. 90
4. 110

Вопрос 43

ПРОВЕРКУ СОБЛЮДЕНИЯ ПОРЯДКА ФОРМИРОВАНИЯ (ВЫДАЧИ), ПРЕДЛЕНИЯ И ОФОРМЛЕНИЯ ЛИСТКОВ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ ПРОВОДИТ

1. Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
2. Территориальный фонд обязательного медицинского страхования
3. Министерство здравоохранения Российской Федерации
4. **Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации**

Вопрос 44
ЛЕЧАЩИЙ ВРАЧ ЕДИНОЛИЧНО ФОРМИРУЕТ ЛИСТОК НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ НА СРОК ДО

1. десяти рабочих дней включительно

2. десяти календарных дней включительно
3. пятнадцати рабочих дней включительно
4. пятнадцати календарных дней включительно

Вопрос 44

ЛИСТОК НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ ФОРМИРУЕТСЯ ГРАЖДАНЫНУ ПРИ НАСТУПЛЕНИИ У НЕГО ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ В СВЯЗИ С ЗАБОЛЕВАНИЕМ В ПЕРИОД ОТПУСКА

1. по беременности и родам
2. без сохранения заработной платы
3. **ежегодного оплачиваемого**
4. по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет

Вопрос 44

ПРАВО ФОРМИРОВАНИЯ (ВЫДАЧИ) ЛИСТКОВ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ ИМЕЮТ МЕДИЦИНСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ, НЕЗАВИСИМО ОТ ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЙ ФОРМЫ, ИМЕЮЩИЕ _____ НА МЕДИЦИНСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ВКЛЮЧАЯ РАБОТЫ (УСЛУГИ) ПО ЭКСПЕРТИЗЕ ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ

1. лицензию
2. регламент
3. аккредитацию
4. сертификат

Вопрос 45
ЛИСТОК НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ ФОРМИРУЕТСЯ ГРАЖДАННИНУ ПРИ НАСТУПЛЕНИИ У НЕГО ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ В СВЯЗИ С ЗАБОЛЕВАНИЕМ В ПЕРИОД ОТПУСКА

1. без сохранения заработной платы
2. по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет
3. по беременности и родам
4. ежегодного оплачиваемого

Вопрос 45

УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ (ВЫДАЧИ) ЛИСТКОВ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ УТВЕРЖДАЮТСЯ

1. приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации
2. постановлением Правительства Российской Федерации
3. распоряжением Федерального фонда обязательного медицинского страхования
4. инструкцией Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации

Вопрос 46
ФЕЛЬДШЕР СКОРОЙ ПОМОЩИ ФОРМИРОВАТЬ (ВЫДАВАТЬ) ЛИСТОК НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ

1. имеет право при работе в сельской местности
2. **не имеет права ни при каких условиях**
3. имеет право в случае возложения на него отдельных функций лечащего врача
4. имеет право при отсутствии в бригаде врача

Вопрос 46

1. десяти календарных дней включительно
2. **пятнадцати календарных дней включительно**
3. десяти рабочих дней включительно
4. пятнадцати рабочих дней включительно

Вопрос 46

ЕСЛИ ГРАЖДАНЫН НА МОМЕНТ НАСТУПЛЕНИЯ СТРАХОВОГО СЛУЧАЯ РАБОТАЕТ У ДВУХ РАБОТОДАТЕЛЕЙ, ВРАЧ ФОРМИРУЕТ ЕМУ

1. два листка нетрудоспособности: в форме электронного документа для предоставления по основному месту работы, на бумажном носителе — для предоставления по другому месту работы
2. один листок нетрудоспособности в форме электронного документа для предоставления только по основному месту работы
3. **один листок нетрудоспособности в форме электронного документа для обоих работодателей**
4. два листка нетрудоспособности в форме электронного документа для предоставления по каждому месту работы

Вопрос 47

ПРИ ОКАЗАНИИ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ НЕНАДЛЕЖАЩЕГО КАЧЕСТВА СТРАХОВЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ИМЕЮТ ПРАВО *(Множественный выбор)*

1. отказать медицинской организации в оплате медицинской помощи
2. наложить штраф на медицинскую организацию (тоже верно)
3. заблокировать счет медицинской организации
4. уменьшить медицинской организации сумму оплаты медицинской помощи

Вопрос 48

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ МЕДИЦИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОВЕРЯЮТ СОБЛЮДЕНИЕ *(Множественный выбор)*

1. правил проведения диагностических исследований
2. правил внутреннего распорядка
3. санитарно-эпидемиологических правил и норм
4. порядков оказания медицинской помощи

Вопрос 49

В СИСТЕМЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНТРОЛЯ ОБЪЕМОВ, СРОКОВ, КАЧЕСТВА И УСЛОВИЙ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ УСТАНАВЛИВАЕТ _____ МЕРОПРИЯТИЙ

1. периодичность проведения **тоже верно**
2. место проведения
3. **формы проведения**
4. продолжительность **тоже верно**

Вопрос 50

ПЕРИОДИЧЕСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ОСМОТР ПРОВОДИТСЯ В ЦЕЛЯХ *(Множественный выбор)*

1. динамического наблюдения за состоянием здоровья работников
2. выявления медицинских противопоказаний к осуществлению отдельных видов работ
3. определения потребности в реабилитации и мерах социальной защиты
4. своевременного выявления начальных форм профессиональных заболеваний

Вопрос 51

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ОСМОТР ПРОВОДИТСЯ ЕЖЕГОДНО *(Множественный выбор)*

1. в рамках консилиума врачей
2. в рамках диспансерного наблюдения
   3. в рамках диспансеризации
   4. в качестве самостоятельного мероприятия

Вопрос 52
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО МЕДИЦИНСКОГО ОСМОТРА У ГРАЖДАНИНА ОПРЕДЕЛЯЮТ ГРУППУ

1. диспансерного наблюдения
2. **здоровья**
3. физической подготовленности
4. инвалидности

____

Вопрос 52
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ОСМОТР ВСЕХ ГРАЖДАН В ВОЗРАСТЕ 18 ЛЕТ И СТАРШЕ ВКЛЮЧАЕТ ЛАБОРАТОРНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ В КРОВИ *(Множественный выбор)*

1. общего билирубина
2. ионизированного кальция
3. **общего холестерина**
4. **глюкозы**

Вопрос 53:
МЕДИЦИНСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ИМЕЮТ ПРАВО ОБЖАЛОВАТЬ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ПО ОЦЕНКЕ ОБЪЕМОВ, СРОКОВ, КАЧЕСТВА И УСЛОВИЙ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, ПОЛУЧЕННЫЕ ОТ
Варианты ответа:

1. Федерального фонда обязательного медицинского страхования **тоже верно**
2. **территориального фонда обязательного медицинского страхования (почему то во второй раз ответ вышел неверный)**
3. Координационного совета по защите прав застрахованных
4. **страховых медицинских организаций**

____

Вопрос 54:
ОБЯЗАННОСТЯМИ СТРАХОВАТЕЛЯ ЯВЛЯЮТСЯ
Варианты ответа:

1. предоставление информации о регистрации в качестве страхователя в Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации
2. **своевременная и полная уплата страховых взносов на обязательное медицинское страхование**
3. **регистрация и снятие с регистрационного учета в целях обязательного медицинского страхования**
4. **предоставление информации о взносах на обязательное медицинское страхование в Федеральную налоговую службу (почему то он тоже не является верным)**

____

Вопрос 55:
ЛИЦА, ЗАСТРАХОВАННЫЕ В СИСТЕМЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ, ИМЕЮТ ПРАВО НА
Варианты ответа:

1. бесплатное лекарственное обеспечение при амбулаторном лечении
2. выбор и замену страховой медицинской организации, осуществляющей деятельность в сфере обязательного медицинского страхования
3. защиту персональных данных, необходимых для ведения персонифицированного учета в сфере обязательного медицинского страхования
4. выбор врача и медицинской организации, осуществляющей деятельность в сфере обязательного медицинского страхования

Вопрос 56:
СТРАХОВЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ОСУЩЕСТВЛЯЮТ СВОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ОСНОВАНИИ ДОГОВОРОВ, ЗАКЛЮЧЕННЫХ МЕЖДУ СТРАХОВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ И
Варианты ответа:

1. Федеральным фондом обязательного медицинского страхования
2. **медицинской организацией**
3. застрахованным лицом
4. **территориальным фондом обязательного медицинского страхования**

Вопрос 56
В СОСТАВ КОМИССИИ ПО РАЗРАБОТКЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ В СУБЪЕКТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ВХОДЯТ ПРЕДСТАВИТЕЛИ

1. общественных некоммерческих организаций, представляющих интересы пациентов
2. территориального фонда, страховых медицинских организаций, медицинских организаций
3. медицинских профессиональных некоммерческих организаций, профессиональных союзов медицинских работников
4. органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации

Вопрос 57
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СВЕДЕНИЙ, СОСТАВЛЯЮЩИХ ВРАЧЕБНУЮ ТАЙНУ, БЕЗ СОГЛАСИЯ ГРАЖДАНА ИЛИ ЕГО ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ДОПУСКАЕТСЯ ПО ЗАПРОСУ
1. военно-врачебных комиссий
2. кадровых служб Министерства обороны Российской Федерации
3. военных комиссариатов
4. кадровых служб Министерства здравоохранения Российской Федерации

Вопрос 58
В ОБЯЗАННОСТИ ГРАЖДАН ВХОДИТ
1. соблюдение режима лечения
2. забота о сохранении своего здоровья
3. информирование врача об изменении своего семейного положения
4. соблюдение правил поведения пациента в медицинских организациях

Вопрос 59
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РАЗРЕШЕНЫ МЕДИЦИНСКИЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА ПО ИЗМЕНЕНИЮ ПОЛА
1. связанные с лечением нарушений формирования половых органов у детей при генетических и эндокринных заболеваниях
2. связанные с лечением пороков развития половых органов у детей
3. проводимые по желанию лица, не достигшего возраста восемнадцати лет и способного дать осознанное добровольное согласие на коррекцию половых признаков, при наличии письменного согласия родителей или законных представителей
4. проводимые по желанию совершеннолетнего дееспособного гражданина

Вопрос 60
ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОКРУГОВ, ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ

1. обеспечивают организацию оказания медицинской помощи только в случае передачи им соответствующих полномочий
2. **организуют информирование населения муниципального образования о возможности распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих**
3. организуют проведение медицинских экспертиз, медицинских осмотров и медицинских освидетельствований

4. обеспечивают создание благоприятных условий в целях привлечения медицинских работников для работы в медицинских организациях

Вопрос 63
ЗАБОЛЕВАНИЯ, КОТОРЫЕ ИМЕЮТ РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ДО 10 СЛУЧАЕВ НА 100 ТЫСЯЧ НАСЕЛЕНИЯ, ЯВЛЯЮТСЯ

1. эпизодическими
2. **редкими**
3. эндемическими

4. орфанными

Вопрос 64
В ФУНКЦИИ ВРАЧЕБНОЙ КОМИССИИ ВХОДИТ

1. проведение обязательного психиатрического освидетельствования(тоже верный)
2. **проведение отбора пациентов для получения высокотехнологичной медицинской помощи**
3. принятие решения о категории годности к военной службе

4. принятие решения о направлении пациента на медико-социальную экспертизу

Вопрос 64

В ФУНКЦИИ ВРАЧЕБНОЙ КОМИССИИ ВХОДИТ

1. принятие решений по вопросам закупки лекарственных препаратов у единственного поставщика

2. оценка качества, обоснованности и эффективности лечебно-диагностических мероприятий, в том числе назначения лекарственных препаратов
3. продление листков нетрудоспособности
4. принятие решения о назначении и применении лекарственных препаратов, не предусмотренных соответствующей клинической рекомендацией

Вопрос 65

В ФУНКЦИИ ВРАЧЕБНОЙ КОМИССИИ ВХОДИТ ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ ПО ВОПРОСАМ
1. профилактики, диагностики, лечения и медицинской реабилитации
2. закупки лекарственных препаратов в соответствии с перечнем жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов
3. совершенствования организации оказания медицинской помощи населению на основе внедрения системы менеджмента качества (тоже верно)
4. проведения медицинских экспертиз, медицинских осмотров и медицинских освидетельствований **тоже верно**

Вопрос 65
В ФУНКЦИИ ВРАЧЕБНОЙ КОМИССИИ ВХОДИТ
1. принятие решения о направлении пациента на медико-социальную экспертизу
2. принятие решения о категории годности к военной службе
3. проведение отбора пациентов для получения высокотехнологичной медицинской помощи
4. проведение обязательного психиатрического освидетельствования **верно**

Вопрос 66
ЕСЛИ ГРАЖДАНиН ОТСТРАНЕН ОТ РАБОТЫ В СВЯЗИ С КАРАНТИНОМ, ТО ЛИСТОК НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ ФОРМИРУЕТСЯ НА ВЕСЬ

1. период временного отстранения от работы (этот тоже правильный)
2. **период изоляции гражданина**
3. период обследования гражданина
4. инкубационный период заболевания

___

Вопрос 66
В ЛИСТКЕ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ НЕ УКАЗЫВАЕТСЯ
1. номер документа, удостоверяющего личность
2. период временного нетрудоспособности
3. наименование медицинской организации
4. диагноз

Вопрос 50 :
ПРИ АНТРОПОМЕТРИИ В ХОДЕ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО ОСМОТРА ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ ИЗМЕРЯЮТ *(Множественный выбор)*
Варианты ответа:

1. окружность головы
   2. рост
   3. массу тела
   4. окружность талии

Вопрос 68
ЛИСТКИ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ В ФОРМЕ ДОКУМЕНТА НА БУМАЖНОМ НОСИТЕЛЕ ВЫДАЮТСЯ ЛИЦАМ
1. в отношении которых реализуются меры государственной защиты
2. страдающим заболеваниями, представляющими опасность для окружающих
3. обратившимся с соответствующим заявлением к руководителю медицинской организации
4. сведения о которых составляют государственную и иную охраняемую законом тайну

Вопрос 71
Гражданин К., 37 лет, обратился к врачу с просьбой направить его на диспансеризацию, но получил отказ. Врач направил его на профилактический медицинский осмотр. Гражданин К. посчитал, что его права нарушены, и обратился с жалобой к главному врачу поликлиники.
ОЦЕНИТЕ ВЕРНОСТЬ ВСЕХ УТВЕРЖДЕНИЙ

1. направление гражданина К. на профилактический медицинский осмотр неправомерно, поскольку перечни медицинских исследований при диспансеризации и профилактическом осмотре различаются
2. отказ врача неправомерен, потому что гражданам в возрасте от 30 лет и старше диспансеризация проводится 1 раз в год, следовательно, гражданин К. имеет право ее пройти
3. права пациента К. нарушены, и отказ врача неправомерен, потому что гражданин имеет право на проведение диспансеризации в любом возрасте и в любой медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь
   4. отказ врача правомерен, потому что гражданам в возрасте от 18 до 39 лет диспансеризация проводится 1 раз в три года,

следовательно, гражданин К. будет подлежать диспансеризации по достижении возраста 39 лет

___

Вопрос 71

Текст вопроса:

Врач, молодой специалист, обратился к своему наставнику с просьбой разъяснить, как оценить эффективность проводимых профилактических медицинских осмотров. Наставник дал соответствующее разъяснение.

ОЦЕНИТЕ ВЕРНОСТЬ ВСЕХ УТВЕРЖДЕНИЙ

1. эффективность профилактических медицинских осмотров оценивается по уровню удовлетворенности пациентов: если большинство опрошенных дают высокие оценки, значит, мероприятия достигают поставленных целей
2. эффективность профилактических медицинских осмотров напрямую определяется количеством выявленных заболеваний по их результатам: чем больше абсолютное число выявленных случаев, тем выше эффективность проведенных осмотров
3. **для оценки эффективности используется показатель охвата граждан профилактическими медицинскими осмотрами, который отражает долю граждан, прошедших медосмотр, от общего числа подлежащих медосмотру**
4. главным показателем эффективности профилактических медицинских осмотров является количество осмотренных пациентов в расчете на одного врача: чем больше пациентов осмотрел врач за отчётный период, тем успешнее реализуется программа профилактики

Вопрос 70

Гражданин Б. обратился с жалобой к главному врачу поликлиники в связи с тем, что лечащий врач рекомендовал ему провести ультразвуковое исследование органов брюшной полости на платной основе. Гражданин Б. уточнил у врача, что данное исследование предусмотрено клиническими рекомендациями в соответствии с его диагнозом и входит в программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. Однако лечащий врач мотивировал свою рекомендацию тем, что в поликлинике очередь на бесплатные исследования более одного месяца.

ОЦЕНИТЕ ВЕРНОСТЬ ВСЕХ УТВЕРЖДЕНИЙ *(Внимание: это вопрос с множественным выбором!)*

1. рекомендация лечащего врача обоснована, поскольку гражданин Б. нуждался в плановой медицинской помощи и, следовательно, имел право выбрать способ получения медицинской помощи: платно или бесплатно
2. **сроки проведения диагностических исследований, в том числе ультразвуковых, устанавливаются в соответствии с программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи**
3. **отказ в оказании медицинской помощи в соответствии с программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и взимание платы за ее оказание не допускаются**
4. предложение пройти ультразвуковое исследование на платной основе является правильным, так как врач заинтересован в получении результатов исследования в кратчайшие сроки для определения тактики ведения пациента

Вопрос 70

Текст вопроса:

Гражданин А. наблюдался в поликлинике №1. Он сменил место жительства и обратился с заявлением к главному врачу о прикреплении к поликлинике №2, которая была расположена ближе к дому. Главный врач поликлиники №2 отказал в прикреплении на том основании, что гражданин А. уже менял медицинскую организацию в течение текущего года.

ОЦЕНИТЕ ВЕРНОСТЬ ВСЕХ УТВЕРЖДЕНИЙ

1. при изменении места жительства гражданин имеет право выбора медицинской организации чаще, чем 1 раз в год

2. гражданин не имеет права на выбор медицинской организации
3. гражданин имеет право выбора медицинской организации не чаще, чем 1 раз в год
4. прикрепление гражданина к медицинской организации осуществляет страховая компания, в которой застрахован гражданин

Вопрос 72

Текст вопроса:

При прохождении диспансеризации в поликлинике пациент Г. поинтересовался у медицинского лаборанта, где он может пройти анонимное обследование на ВИЧ. Медицинский лаборант затруднился с ответом.

ОЦЕНИТЕ ВЕРНОСТЬ ВСЕХ УТВЕРЖДЕНИЙ

1. в данной ситуации необходимо было направить гражданина Г. к своему врачу-терапевту участковому
2. в данной ситуации необходимо было направить гражданина Г. в регистратуру медицинской организации
3. **в данной ситуации необходимо было направить гражданина Г. в отделение (кабинет) медицинской профилактики или центр здоровья**
4. в данной ситуации необходимо было направить гражданина Г. к заведующему отделением клинической лабораторной диагностики

Вопрос 73

Текст вопроса:

Находясь в отпуске в другом регионе, гражданин Н., имеющий полис обязательного медицинского страхования, обратился в городскую больницу с жалобами на боли в животе. После осмотра в приемном отделении он был госпитализирован по экстренным показаниям в хирургическое отделение. Пациенту пояснили, что госпитализация платная, потому что он является иногородним и не может получить специализированную медицинскую помощь в рамках обязательного медицинского страхования.

ОЦЕНИТЕ ВЕРНОСТЬ ВСЕХ УТВЕРЖДЕНИЙ

1. гражданин Н. является застрахованным лицом и имеет право на бесплатное оказание медицинской помощи при наступлении страхового случая

2. медицинская помощь в экстренной форме гражданину Н. должна была быть оказана безотлагательно и бесплатно

3. недопустимость отказа в оказании медицинской помощи в соответствии с программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи закреплена в Федеральном законе №326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации»

4. специализированная медицинская помощь в стационарных условиях иногородним пациентам не подлежит оплате за счет средств обязательного медицинского страхования

———

Вопрос 73

Гражданин Т., имеющий постоянную регистрацию во Владимирской области, в связи с семейными обстоятельствами временно переехал в Новосибирск для осуществления ухода за больной родственницей. Через некоторое время ему самому понадобилась медицинская помощь в связи с полученной бытовой травмой. Он обратился в поликлинику города Новосибирска, но в бесплатной медицинской помощи ему было отказано.

ОЦЕНИТЕ ВЕРНОСТЬ ВСЕХ УТВЕРЖДЕНИЙ

1. иногороднему пациенту, не имеющему временной регистрации, первичная медико-санитарная помощь оказывается на платной основе
2. бытовая травма не является страховым случаем и не подлежит оплате за счет средств обязательного медицинского страхования
3. пациенту, не прикрепленному к поликлинике, первичная медико-санитарная помощь не оказывается
4. **застрахованные лица имеют право на бесплатное оказание им медицинской помощи при наступлении страхового случая**

Вопрос 74

Текст вопроса:

Гражданке Г. была проведена операция по эндопротезированию тазобедренного сустава в рамках обязательного медицинского страхования. Эндопротез был приобретен самостоятельно по рекомендации хирурга. Гражданка Г. обратилась в страховую медицинскую организацию с просьбой компенсировать затраты на покупку протеза.

ОЦЕНИТЕ ВЕРНОСТЬ ВСЕХ УТВЕРЖДЕНИЙ

1. компенсация затрат на самостоятельно приобретенный эндопротез страховой медицинской организацией не производится, поскольку страховщик не является стороной сделки купли-продажи, которую заключила гражданка Г. (Неверный ответ не учить его)

2. компенсация затрат на самостоятельно приобретенный эндопротез производится на паритетных условиях: 50% - за счет средств обязательного медицинского страхования, 50% - за счет личных средств пациента

3. законодательством Российской Федерации не предусмотрена компенсация страховой медицинской организацией затрат на самостоятельно приобретенный эндопротез

4. страховая медицинская организация обязана компенсировать гражданке Г. затраты на приобретение эндопротеза в размере 100% от его стоимости

Вопрос 74

Иностранный гражданин, работающий по трудовому договору в частной строительной компании города Н., обратился в департамент

здравоохранения с жалобой. В страховой медицинской организации ему отказали в выдаче полиса обязательного медицинского страхования и предложили заключить договор добровольного медицинского страхования.
ОЦЕНИТЕ ВЕРНОСТЬ ВСЕХ УТВЕРЖДЕНИЙ
1. иностранные граждане, постоянно или временно проживающие в Российской Федерации и работающие по трудовому договору, относятся к застрахованным лицам
2. страховая медицинская организация обязана удостовериться в уплате строительной компанией, выступающей работодателем иностранного гражданина, страховых взносов на обязательное медицинское страхование в отношении данного лица
3. полис обязательного медицинского страхования удостоверяет право застрахованного лица на бесплатное оказание медицинской помощи на всей территории Российской Федерации в объеме, предусмотренном базовой программой обязательного медицинского страхования
4. страховые медицинские организации, работающие в системе обязательного медицинского страхования, не имеют права заключать договоры добровольного медицинского страхования

Вопрос 79
Текст вопроса:
Пациент Н., 41 год, работает по трудовому договору. В течение четырех месяцев является временно нетрудоспособным в связи с заболеванием, листок нетрудоспособности оформлен. При очередном приеме признаки временной нетрудоспособности сохраняются. По заключению врачебной комиссии клинический и трудовой прогноз благоприятный.
ОЦЕНИТЕ ВЕРНОСТЬ ВСЕХ УТВЕРЖДЕНИЙ

1. в данной ситуации пациент Н. может быть направлен на медико-социальную экспертизу только при наличии обращения от его работодателя
2. **в данной ситуации пациент Н. на медико-социальную экспертизу не направляется**
3. в данной ситуации пациент Н. может быть направлен на медико-социальную экспертизу по решению врачебной комиссии
4. в данной ситуации направление пациента Н. на медико-социальную экспертизу является обязательным

Вопрос 79
Гражданка М., 35 лет, работает бухгалтером в школе. С 12 февралявозникла необходимость ухода за больным отцом. Ей был сформирован листок нетрудоспособности с 12 по 18 февраля. С 19 февраля она должна была приступить к работе, однако необходимость ухода за отцом сохранялась. Лечащий врач в продлении листка нетрудоспособности отказал.
ОЦЕНИТЕ ВЕРНОСТЬ ВСЕХ УТВЕРЖДЕНИЙ *(Внимание: это вопрос с множественным выбором!)*
1. в данной ситуации у лечащего врача нет оснований для продления листка нетрудоспособности
2. при сохранении необходимости ухода за взрослым членом семьи лицу, осуществляющему уход, выдается листок нетрудоспособности на весь период до выздоровления пациента
3. в случаях ухода за взрослым членом семьи при лечении в амбулаторных условиях листок нетрудоспособности формируется не более чем на 7 календарных дней
4. в данной ситуации у лечащего врача есть основания для направления гражданки М. на врачебную комиссию для продления листка нетрудоспособности на срок до 15 дней

___

Вопрос 80
Гражданка Д. обратилась в поликлинику после окончания рабочей смены. Врач установил признаки временной нетрудоспособности и сформировал (выдал) листок нетрудоспособности.
ОЦЕНИТЕ ВЕРНОСТЬ ВСЕХ УТВЕРЖДЕНИЙ *(Внимание: это вопрос с множественным выбором!)*

1. дата освобождения от работы в листке нетрудоспособности указывается независимо от желания гражданки Д.
2. дата освобождения от работы в листке нетрудоспособности может быть указана по желанию гражданки Д. со дня обращения за медицинской помощью
3. **дата освобождения от работы в листке нетрудоспособности может быть указана по желанию гражданки Д. со следующего календарного дня после окончания рабочей смены**
4. дата освобождения от работы в листке нетрудоспособности должна соответствовать дате признания гражданки Д. временно нетрудоспособной

Вопрос 80

Текст вопроса:
Гражданка Д. обратилась в поликлинику после окончания рабочей смены. Врач установил признаки временной нетрудоспособности и сформировал (выдал) листок нетрудоспособности.
ОЦЕНИТЕ ВЕРНОСТЬ ВСЕХ УТВЕРЖДЕНИЙ

1. дата освобождения от работы в листке нетрудоспособности может быть указана по желанию гражданки Д. со дня обращения за медицинской помощью
2. **дата освобождения от работы в листке нетрудоспособности может быть указана по желанию гражданки Д. со следующего календарного дня после окончания рабочей смены**
3. дата освобождения от работы в листке нетрудоспособности указывается независимо от желания гражданки Д.
4. дата освобождения от работы в листке нетрудоспособности должна соответствовать дате признания гражданки Д. временно нетрудоспособной

___

Вопрос 75
Пациент П., 35 лет, доставлен в приемное отделение городской больницы бригадой скорой помощи. При осмотре выявлены многочисленные повреждения и травмы. Пациент утверждает, что упал с лестницы. Врач понимает, что признаки повреждений носят явно криминальный характер.
ОЦЕНИТЕ ВЕРНОСТЬ ВСЕХ УТВЕРЖДЕНИЙ *(Внимание: это вопрос с множественным выбором!)*

1. в данной ситуации информирование органов внутренних дел проводится только с согласия пациента П.
2. **в данной ситуации информирование органов внутренних дел не является разглашением врачебной тайны**
3. **если у врача есть достаточные основания полагать, что вред здоровью пациента П. причинен в результате противоправных действий, то он обязан проинформировать органы внутренних дел**
4. если у врача есть достаточные основания полагать, что вред здоровью пациента П. причинен в результате противоправных действий, то он обязан направить пациента на освидетельствование в бюро судебно-медицинской экспертизы

Вопрос 75
Текст вопроса:
Во время плановой вакцинации против гриппа после осмотра врачом-педиатром школьнику 16 лет медицинская сестра сделала прививку. Мать согласия на вакцинацию не давала, поскольку ранее у сына наблюдалась аллергическая реакция на компоненты вакцины, и эта информация была отражена в медицинской документации.
ОЦЕНИТЕ ВЕРНОСТЬ ВСЕХ УТВЕРЖДЕНИЙ
1. информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство может дать несовершеннолетний в возрасте старше 15 лет
2. в данной ситуации без согласия одного из родителей или иного законного представителя несовершеннолетнего ребенка проведение вакцинации не допускается
3. проведение вакцинации в данной ситуации недопустимо независимо от наличия или отсутствия информированного добровольного согласия на медицинское вмешательство
4. без подтверждения факта получения от школьника информированного добровольного согласия на медицинское вмешательство объективная оценка действий врача в данной ситуации невозможна

Вопрос 75

Обучающийся С., 14 лет, на официальных спортивных соревнованиях среди школ города получил травму и был доставлен бригадой скорой помощи в медицинскую организацию. В целях расследования несчастного случая администрация образовательного учреждения запросила у медицинской организации сведения о состоянии здоровья обучающегося. Лечащий врач в предоставлении сведений отказал, сославшись на то, что родители возражают против разглашения сведений о состоянии здоровья своего ребенка.
ОЦЕНИТЕ ВЕРНОСТЬ ВСЕХ УТВЕРЖДЕНИЙ

1. врач должен был провести разъяснительную беседу с родителями обучающегося С. и получить их письменное согласие на разглашение сведений, составляющих врачебную тайну
2. врач должен был предоставить сведения образовательной организации, так как в подобной ситуации это не противоречит

Федеральному закону №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»
если родители обучающегося С. не дали согласия на разглашение сведений о состоянии его здоровья, то врач не имел права передавать эти сведения кому-либо

4. при расследовании несчастного случая с обучающимся С., произошедшего во время его участия в спортивных соревнованиях, сведения, составляющие врачебную тайну, могут быть предоставлены без согласия родителей

Вопрос 76

Текст вопроса:

Пациент М., 27 лет, обратился к врачу с просьбой о предоставлении рентгеновского снимка для получения консультации у другого специалиста. Врач отказал ему в просьбе, объяснив свой отказ необходимостью сохранения целостности медицинской документации, и предложил сделать копию описания снимка.

ОЦЕНИТЕ ВЕРНОСТЬ ВСЕХ УТВЕРЖДЕНИЙ

в данной ситуации возможна выдача только описания рентгеновского снимка, так как оригиналы снимков подлежат обязательному архивному хранению в той медицинской организации, где они были выполнены

пациент имеет право непосредственно знакомиться с медицинской документацией и получать на основании такой документации консультации у других специалистов

медицинская организация обязана обеспечить пациенту возможность ознакомления с медицинской документацией, отражающей состояние его здоровья; обязанность медицинской организации передавать указанную документацию сторонним специалистам для консультаций законодательством не предусмотрена

4. в данной ситуации нарушено право пациента на получение информации о состоянии своего здоровья

Вопрос 76

Ребенок В., 14 лет, обратился в детскую стоматологическую поликлинику в сопровождении бабушки с целью проведения плановой санации полости рта. Для оформления информированного добровольного согласия на медицинское вмешательство врач потребовал присутствия одного из родителей.

ОЦЕНИТЕ ВЕРНОСТЬ ВСЕХ УТВЕРЖДЕНИЙ *(Внимание: это вопрос с множественным выбором!)*

требования врача неправомерны, так как бабушка является близким родственником ребенка В. и имеет право дать информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство

2. информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство в отношении ребенка В. должен дать один из родителей или иной законный представитель

3. требования врача правомером, так как бабушка не является законным представителем ребенка В.

4. ребенок В. может дать информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство по достижении возраста 15 лет

Вопрос 76

Пациент М., 40 лет, обратился на приём к врачу-стоматологу-ортопеду. В процессе медицинского осмотра врач, не спрашивая разрешения, решил сфотографировать полость рта пациента для публикации данного клинического случая в научной статье. Пациент категорически отказался от фотографирования.

ОЦЕНИТЕ ВЕРНОСТЬ ВСЕХ УТВЕРЖДЕНИЙ

1. разглашение сведений, составляющих врачебную тайну, в целях их публикации в научных изданиях допускается с письменного согласия гражданина

2. при фотографировании полости рта идентифицировать личность пациента невозможно, следовательно, согласие пациента не требуется

3. если врач планирует использование фотографии полости рта пациента в научных целях, в том числе для публикации в научной статье, согласие пациента не требуется

4. действия врача неэтичны, так как врач должен был предупредить пациента о намерении сфотографировать полость рта и объяснить, в каких целях он планирует использовать фотографию

Вопрос 77

Сослуживец пациента К., поступившего накануне в отделение кардиореанимации, позвонил на пост медицинской сестры и поинтересовался, находится ли его коллега по работе К. на лечении и каково состояние его здоровья. Медицинская сестра И. сказала: «Да, такой пациент находится у нас на лечении, но информацию о его здоровье я могу сообщить только близким родственникам».

ОЦЕНИТЕ ВЕРНОСТЬ ВСЕХ УТВЕРЖДЕНИЙ *(Внимание: это вопрос с множественным выбором!)*

1. сведения о факте обращения пациента К. за оказанием медицинской помощи составляют врачебную тайну

2. на медицинскую сестру И. не распространяются требования о соблюдении врачебной тайны, потому что она имеет среднее профессиональное образование и врачом не является

3. врачебную тайну составляют только сведения о состоянии здоровья пациента К.

4. в данной ситуации медицинская сестра И. нарушила врачебную тайну

Вопрос 77

Пациент Р. обратился в поликлинику №1 с заявлением о прикреплении конкретно к врачу-терапевту участковому Г., который работает в данной медицинской организации. Главный врач ответил отказом в связи с тем, что врач Г. не согласен, так как на его участке численность прикрепленного населения существенно превышает нормативную.

ОЦЕНИТЕ ВЕРНОСТЬ ВСЕХ УТВЕРЖДЕНИЙ

1. отказ главного врача правомерен, однако он должен был предложить пациенту Р. альтернативный вариант прикрепления к другому врачу-терапевту участковому

2. отказ главного врача правомерен, так как пациент Р. имеет право на выбор врача с учетом согласия самого врача

3. в данной ситуации, с учетом приоритета интересов пациента при оказании медицинской помощи, согласие врача Г. не требуется

4. отказ в прикреплении к конкретному врачу неправомерен, поскольку пациент Р. имеет право не только на выбор медицинской организации, но и на выбор врача

———

Вопрос 78

Врач-терапевт участковый, который только начал свою трудовую деятельность после окончания вуза, решил назначить пациентке Л. лекарственный препарат, не предусмотренный клиническими рекомендациями. Ранее у пациентки Л. была тяжелая аллергическая реакция на лекарственный препарат, входящий в клинические рекомендации. Молодой врач обратился к более опытному коллеге с вопросом о том, как правильно оформить это назначение. Опытный врач-терапевт дал разъяснения молодому коллеге.

ОЦЕНИТЕ ВЕРНОСТЬ ВСЕХ УТВЕРЖДЕНИЙ

1. в данной ситуации врач-терапевт участковый должен направить пациентку Л. на врачебную комиссию для назначения лекарственного препарата, не предусмотренного клиническими рекомендациями

2. в данной ситуации врач-терапевт участковый должен направить пациентку Л. в стационар для подбора персонализированной лекарственной терапии

3. в данной ситуации врач-терапевт участковый должен собрать консилиум врачей для подбора лекарственной терапии с учетом индивидуальных особенностей пациентки Л.

4. в данной ситуации врач-терапевт участковый вправе единолично принять решение о назначении пациентке Л. лекарственного препарата, не предусмотренного клиническими рекомендациями

Вопрос 78

Пациентка Н. была направлена на лечение в кардиологический диспансер. Она попросила заведующего отделением предоставить информацию о квалификации лечащего врача.

ОЦЕНИТЕ ВЕРНОСТЬ ВСЕХ УТВЕРЖДЕНИЙ *(Внимание: это вопрос с множественным выбором!)*

1. пациентка Н. имеет право на получение запрашиваемой информации в доступной для нее форме

2. сведения об уровне образования и квалификации врача не могут быть предоставлены пациентке Н., поскольку относятся к личным данным и не подлежат разглашению

3. сведения об уровне образования и квалификации врача могут быть предоставлены пациентке Н. только с согласия самого врача

4. сведения об уровне образования и квалификации врача размещаются в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе на сайте медицинской организации

———

Врач, молодой специалист, обратился к более опытному коллеге с просьбой пояснить, как оценить абсолютный сердечно-сосудистый

риск у граждан в возрасте от 40 до 64 лет включительно, страдающих хроническими неинфекционными заболеваниями. Коллега дал пояснения.
ОЦЕНИТЕ ВЕРНОСТЬ ВСЕХ УТВЕРЖДЕНИЙ

1. если у пациента данной возрастной группы отягощена наследственность по сердечно-сосудистой патологии, то уровень абсолютного сердечно-сосудистого риска расценивается как очень высокий
2. если у пациента данной возрастной группы отягощена наследственность по сахарному диабету, то уровень абсолютного сердечно-сосудистого риска расценивается как очень высокий
   3. если у пациента данной возрастной группы диагностированы сердечно-сосудистые заболевания атеросклеротического генеза, то уровень абсолютного сердечно-сосудистого риска расценивается как очень высокий
   4. если у пациента данной возрастной группы диагностирован сахарный диабет второго типа, то уровень абсолютного сердечно-сосудистого риска расценивается как очень высокий

———

Вопрос 79
Пациент К., 25 лет, работает по трудовому договору. Является временно нетрудоспособным в течение четырех месяцев в связи с травмой, листок нетрудоспособности оформлен. При очередном осмотре на приеме признаки временной нетрудоспособности сохраняются, при этом врачебная комиссия дала заключение о благоприятном клиническом и трудовом прогнозе.
ОЦЕНИТЕ ВЕРНОСТЬ ВСЕХ УТВЕРЖДЕНИЙ
1. в данной ситуации продление листка нетрудоспособности пациенту К. возможно, поскольку клинический и трудовой прогнозы благоприятны
2. продление листка нетрудоспособности при состояниях после травм и реконструктивных операций разрешено на срок не более десяти месяцев
3. в данной ситуации пациент К. должен быть направлен на медико-социальную экспертизу
4. в данной ситуации для решения вопроса о продлении листка нетрудоспособности пациенту К. необходимо заключение врачебной комиссии

———

Вопрос 80
Пациент Р., 59 лет, работающий по трудовому договору, наблюдается в поликлинике с хроническим неинфекционным заболеванием. В течение 4 месяцев является временно нетрудоспособным. Врачебная комиссия сделала заключение о неблагоприятном клиническом и трудовом прогнозе и направила пациента Р. на медико-социальную экспертизу. Однако пациент отказался от ее прохождения.
ОЦЕНИТЕ ВЕРНОСТЬ ВСЕХ УТВЕРЖДЕНИЙ

1. в данной ситуации листок нетрудоспособности продлевается по решению врачебной комиссии на срок не более десяти месяцев
2. в случае отказа от прохождения медико-социальной экспертизы пациент направляется на стационарное лечение с открытым листком нетрудоспособности
   3. в случае отказа пациента Р. от прохождения медико-социальной экспертизы листок нетрудоспособности не продлевается
   4. пациент Р. имеет право отказаться от проведения медико-социальной экспертизы без объяснения причин

———

Вопрос 56
В СОСТАВ КОМИССИИ ПО РАЗРАБОТКЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ В СУБЪЕКТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ВХОДЯТ ПРЕДСТАВИТЕЛИ *(Внимание: это вопрос с множественным выбором!)*
Варианты ответа:

1. общественных некоммерческих организаций, представляющих интересы пациентов
   2. территориального фонда, страховых медицинских организаций, медицинских организаций
   3. медицинских профессиональных некоммерческих организаций, профессиональных союзов медицинских работников
   4. органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации

___

Вопрос 57
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СВЕДЕНИЙ, СОСТАВЛЯЮЩИХ ВРАЧЕБНУЮ ТАЙНУ, БЕЗ СОГЛАСИЯ ГРАЖДАНИНА ИЛИ ЕГО ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ДОПУСКАЕТСЯ ПО ЗАПРОСУ *(Внимание: это одиночный выбор!)*

1. военно-врачебных комиссий
2. кадровых служб министерства обороны Российской Федерации
3. **военных комиссариатов**
4. кадровых служб министерства здравоохранения Российской Федерации

____

Вопрос 58
В ОБЯЗАННОСТЬ ГРАЖДАН ВХОДИТ *(Внимание: это вопрос с множественным выбором!)*
1. соблюдение режима лечения
2. забота о сохранении своего здоровья
3. информирование врача об изменении своего семейного положения
4. соблюдение правил поведения пациента в медицинских организациях

Вопрос 47
Текст вопроса:
ДОСТУПНОСТЬ И КАЧЕСТВО МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ОБЕСПЕЧИВАЮТСЯ

1. гарантией компенсации ущерба здоровью вследствие ненадлежащего качества медицинской помощи
   2. возможностью выбора медицинской организации и врача
   3. организацией оказания медицинской помощи по принципу приближенности к месту жительства, месту работы или обучения
   4. наличием необходимого количества медицинских работников и уровнем их квалификации

Вопрос 48
Текст вопроса:
ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ МЕДИЦИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЯЗАНЫ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ МЕДИЦИНСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ _____ СИСТЕМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
1. частной
2. национальной
3. муниципальной
4. государственной

Вопрос 65
Текст вопроса:
ПРИ ОКАЗАНИИ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ
1. клеточные технологии
2. методы генной инженерии
3. наномедицинские системы
4. роботизированная техника

Вопрос 66

Текст вопроса:

ЛИСТОК НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ ИМЕЕТ ПРАВО ФОРМИРОВАТЬ

1. врач-хирург

2. врач-стоматолог

3. врач-эпидемиолог

4. врач-терапевт

Вопрос 57

Текст вопроса:

ГРАЖДАНЕ ИМЕЮТ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ ДОСТОВЕРНОЙ И СВОЕВРЕМЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ О

1. рейтингах медицинских организаций и индивидуальных показателях эффективности работы медицинских работников
   2. санитарно-эпидемиологическом благополучии района проживания
   3. потенциальной опасности для здоровья выполняемых работ и оказываемых услуг
   4. безопасности пищевых продуктов и рациональных нормах питания

Вопрос 58

Текст вопроса:

ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОКРУГОВ, ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ

1. организуют проведение медицинских экспертиз, медицинских осмотров и медицинских освидетельствований
2. **обеспечивают создание благоприятных условий в целях привлечения медицинских работников для работы в медицинских организациях**
3. обеспечивают организацию оказания медицинской помощи только в случае передачи им соответствующих полномочий

   4. организуют информирование населения муниципального образования о возможности распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих

Вопрос 67

Текст вопроса:

ФОРМИРОВАНИЕ ЛИСТКА НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ В ФОРМЕ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТА ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПРИ ПРЕДЪЯВЛЕНИИ

1. письменного заявления
2. идентификационного номера налогоплательщика
   3. страхового номера индивидуального лицевого счета гражданина в системе индивидуального (персонифицированного) учета
   4. документа, удостоверяющего личность

Вопрос 68

Текст вопроса:

ЛИСТОК НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ НЕ ФОРМИРУЕТСЯ

1. гражданам, находящимся под стражей или административным арестом

2. обучающимся в образовательных и научных организациях

3. государственным гражданским служащим, муниципальным служащим

4. гражданам, если у них не выявлено признаков временной нетрудоспособности

Вопрос 63

Текст вопроса:

МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ КЛАССИФИЦИРУЕТСЯ ПО

1. условиям

2. формам

3. видам

4. типам

Вопрос 64

Текст вопроса:

ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ОКАЗАНИЯ ПАЛЛИАТИВНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПРЕДУСМАТРИВАЕТСЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ И

1. организаций социального обслуживания

2. общественных объединений и некоммерческих организаций в сфере охраны здоровья

3. профессиональных некоммерческих организаций медицинских работников

4. производителей медицинского оборудования и расходных материалов для паллиативной помощи

Вопрос 61

В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ № 323-ФЗ «ОБ ОСНОВАХ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» КАЖДЫЙ ИМЕЕТ ПРАВО НА

1. получение платных медицинских услуг и иных услуг, в том числе в соответствии с договором добровольного медицинского страхования

2. бесплатное обеспечение всеми медицинскими изделиями, используемыми при оказании помощи, включая индивидуальные ортопедические приспособления и средства реабилитации

3. получение мер социальной поддержки в виде набора социальных услуг в зависимости от степени ограничений жизнедеятельности и качества жизни

4. бесплатную медицинскую помощь в гарантированном объеме в рамках программы государственных гарантий

Вопрос 62

РЕШЕНИЕ О ВЫДАЧЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА ЗАНЯТИЕ НАРОДНОЙ МЕДИЦИНОЙ ПРИНИМАЕТСЯ НА ОСНОВАНИИ ЗАЯВЛЕНИЯ ГРАЖДАНА И

1. заключения экспертизы качества и безопасности медицинской помощи, проведенной независимой группой экспертов
2. **представления медицинской профессиональной некоммерческой организации**
3. совместного представления медицинской профессиональной некоммерческой организации и медицинской организации
4. ходатайства общественной организации, объединяющей пациентов

Вопрос 1

РАЗРАБАТЫВАТЬ И УТВЕРЖДАТЬ КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВОПРОСАМ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ МОГУТ ТОЛЬКО

1. **медицинские профессиональные некоммерческие организации**
2. органы местного самоуправления
3. органы исполнительной власти субъектов РФ
4. Министерство здравоохранения РФ и Министерство юстиции РФ

Вопрос 4

ПОНЯТИЕ «КАЧЕСТВО МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ» ОПРЕДЕЛЕНО

1. распоряжением Федерального фонда социального восстановления
2. распоряжением Федерального фонда обязательного медицинского страхования
3. **Федеральным законом**
4. приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации

Вопрос 2

ПО МНЕНИЮ ЭКСПЕРТОВ ВОЗ ПОД ДОСТУПНОСТЬЮ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПОНИМАЮТ

1. возможность выбора врача в прикрепленной медицинской организации
2. территориальный принцип оказания медицинской помощи
3. приближенность медицинской организации к месту жительства и работе
4. **отсутствие географических, экономических и иных барьеров**

Вопрос 3

ПРИ ВНЕЗАПНЫХ ОСТРЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ БЕЗ ЯВНЫХ ПРИЗНАКОВ УГРОЗЫ ЖИЗНИ ПАЦИЕНТА МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ ДОЛЖНА БЫТЬ ОКАЗАНА В _____ ФОРМЕ

1. экстренной
2. плановой
3. **неотложной**
4. срочной

Вопрос 6
ПРИ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОМ МЕДИЦИНСКОМ ОСМОТРЕ ГРАЖДАНАМ В ВОЗРАСТЕ 65 ЛЕТ И СТАРШЕ ПРОВОДЯТ ОЦЕНКУ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ, ВКЛЮЧАЮЩУЮ

1. оценку относительного и абсолютного сердечно-сосудистого риска
2. установление степени утраты трудоспособности и степени нарушения функционирования органов и систем
3. определение качества жизни, связанного со здоровьем, основных ограничений жизнедеятельности и барьеров окружающей среды
4. **выявление риска падений, симптомов остеопороза, сердечной недостаточности, депрессии, нарушений слуха и зрения**

Вопрос 8

ПОД МЕДИЦИНСКИМ ОСМОТРОМ, ПРОВОДИМЫМ ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ НА РАБОТУ В ЦЕЛЯХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ РАБОТНИКА ПОРУЧАЕМОЙ ЕМУ РАБОТЕ, ПОНИМАЮТ _____ МЕДИЦИНСКИЙ ОСМОТР

1. профилактический
2. периодический
3. **предварительный**
4. предсменный

Вопрос 10
ПОРЯДОК И ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ ОСМОТРОВ, ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ, ДИСПАНСЕРНОГО НАБЛЮДЕНИЯ И ПЕРЕЧЕНЬ ВКЛЮЧАЕМЫХ В НИХ ИССЛЕДОВАНИЙ УТВЕРЖДАЮТСЯ, КАК ПРАВИЛО,

1. методическими рекомендациями Федерального фонда обязательного медицинского страхования
2. приказом главного врача медицинской организации
3. постановлением Правительства Российской Федерации
4. **уполномоченным федеральным органом исполнительной власти**

Вопрос 11

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНО ОПРЕДЕЛЯЮТ ГРУППУ

1. физической подготовленности
2. для занятий физической культурой
3. здоровья для планирования профилактических мер и лечения
4. **риска развития хронических неинфекционных заболеваний**

Вопрос 12
СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ВАКЦИНАЦИИ ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ

1. Программой государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи
2. планом работы прививочного кабинета медицинской организации
3. **Национальным календарем профилактических прививок**
4. приказом главного врача медицинской организации

Вопрос 13
ВАЖНЫМ РАЗДЕЛОМ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ДЕТСКОЙ ПОЛИКЛИНИКИ ЯВЛЯЕТСЯ

1. выдача направления на госпитализацию нуждающимся
2. анализ преемственности между медицинскими организациями
3. **проведение профилактических приемов**
4. формирование отчетности по итогам работы за год

Вопрос 15

ПОЛИС ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ ДОКУМЕНТОМ, УДОСТОВЕРЯЮЩИМ ПРАВО ЗАСТРАХОВАННОГО ЛИЦА НА

1. оказание медицинской помощи на платной основе
2. получение страховой выплаты в результате стойкой утраты работоспособности
3. **бесплатное оказание медицинской помощи на всей территории РФ**
4. оплату листка временной нетрудоспособности

Вопрос 16
ЗАЩИТА ПРАВ ГРАЖДАН В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ПОЛУЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПО ПРОГРАММЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ ОБЯЗАННОСТЬЮ

1. медицинского учреждения
2. прокуратуры
3. **страховой медицинской организации**
4. суда

Вопрос 18

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ КАК ВИД МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ _____ В ОТЛИЧИЕ ОТ _____ МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ

1. **некоммерческим; добровольного**
2. страхованием ответственности; популяционного
3. имущественным; группового
4. коммерческим; индивидуального

Вопрос 22
ЕСЛИ В ПИСЬМЕННОМ ОБРАЩЕНИИ К РУКОВОДИТЕЛЮ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ НЕ УКАЗАНЫ ФАМИЛИЯ НАПРАВИВШЕГО ЕГО ЛИЦА ЛИБО ЕГО ПОЧТОВЫЙ АДРЕС, ТО

1. ответ на обращение направляется после установления почтового адреса заявителя
2. **ответ на обращение не дается**
3. обращение не регистрируется
4. обращение направляется в органы внутренних дел для установления личности заявителя

Вопрос 23

ОДНИМ ИЗ ОСНОВНЫХ ПРИНЦИПОВ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ЯВЛЯЕТСЯ

1. социальная защита граждан РФ
2. безусловное выполнение пожеланий пациента по выбору методов диагностики и лечения
3. взаимодействие со средствами массовой информации
4. **недопустимость отказа в оказании медицинской помощи**

Вопрос 23

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА (РОСПОТРЕБНАДЗОР) ЯВЛЯЕТСЯ

1. **федеральным органом исполнительной власти**
2. некоммерческой профессиональной медицинской организацией
3. федеральным органом законодательной власти
4. саморегулируемой организацией

Вопрос 24
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ

1. органом законодательной власти
2. **федеральным органом исполнительной власти**
3. государственным органом власти
4. центральным органом государственной власти.

Вопрос 25

В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЛИЦА, НЕЗАКОННО ЗАНИМАЮЩИЕСЯ МЕДИЦИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ, НЕСУТ _____ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

1. персональную
2. процессуальную
3. **уголовную**
4. материальную

Вопрос 31

ПИСЬМЕННОЕ ОБРАЩЕНИЕ ГРАЖДАНЫНА К РУКОВОДИТЕЛЮ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДОЛЖНО БЫТЬ РАССМОТРЕНО В ТЕЧЕНИЕ

1. 21 дня со дня поступления
2. 21 дня со дня регистрации
3. **30 дней со дня регистрации**
4. 30 дней со дня поступления

Вопрос 33
ПОЛОЖЕНИЕ ОБ АККРЕДИТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ ДЛЯ ДОПУСКА К МЕДИЦИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УТВЕРЖДАЕТСЯ

1. **уполномоченным федеральным органом исполнительной власти**
2. органом законодательной власти субъекта Российской Федерации
3. уполномоченным федеральным органом законодательной власти
4. органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации

Вопрос 34
ПЕРЕЧЕНЬ МЕДИЦИНСКИХ ПОКАЗАНИЙ И ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ ДЛЯ МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ И САНАТОРНО-КУРОРТНОГО ЛЕЧЕНИЯ УТВЕРЖДАЕТСЯ

1. главным внештатным специалистом по медицинской реабилитации
2. **уполномоченным федеральным органом исполнительной власти**
3. руководителем санаторно-курортной организации
4. уполномоченным федеральным органом законодательной власти

Вопрос 37

НА ЛЕЧАЩЕГО ВРАЧА ВОЗЛОЖЕНЫ ФУНКЦИИ ПО

1. **организации и непосредственному оказанию пациенту медицинской помощи в период наблюдения за ним и его лечения**
2. расчету кадрового состава отделения
3. проведению медико-социальной экспертизы
4. определению потребности медицинской организации в лекарственных средствах

Вопрос 40
ПЕРЕЧЕНЬ ЗАБОЛЕВАНИЙ, ПРЕДСТАВЛЯЮЩИХ ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ОКРУЖАЮЩИХ, И ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПРИ УГРОЗЕ ИХ РАСПРОСТРАНЕНИЯ УТВЕРЖДАЮТСЯ

1. Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения
2. **Правительством Российской Федерации**
3. Федеральным медико-биологическим агентством
4. Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Вопрос 40
ПЕРЕЧЕНЬ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ УТВЕРЖДАЕТСЯ

1. Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения
2. Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
3. Министерством здравоохранения Российской Федерации
4. **Правительством Российской Федерации**

Вопрос 41

ГРАЖДАНЕ, НАХОДЯЩИЕСЯ НА ЛЕЧЕНИИ

1. вправе требовать внесения изменений в тактику лечения, обследования в соответствии с собственными желаниями и усмотрениями
2. не обязаны соблюдать режим лечения и правила поведения пациента в медицинских организациях
3. **обязаны соблюдать режим лечения и правила поведения пациента в медицинских организациях**
4. могут придерживаться привычного для них распорядка дня, режима питания и поведения

Вопрос 42

ЕСЛИ ЛЕЧЕНИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ПРОВОДИТСЯ В АМБУЛАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ, ЛИСТОК НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ ФОРМИРУЕТСЯ В ДЕНЬ УСТАНОВЛЕНИЯ ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ НА _____, ВКЛЮЧАЯ НЕРАБОЧИЕ ПРАЗДНИЧНЫЕ И ВЫХОДНЫЕ ДНИ

1. период временной нетрудоспособности, но не более чем на 10 дней
2. **весь период временной нетрудоспособности**
3. период временной нетрудоспособности, но не более чем на 15 дней
4. период временной нетрудоспособности, но не более чем на 7 дней

Вопрос 44

ФЕЛЬДШЕР ИМЕЕТ ПРАВО ЕДИНОЛИЧНО ФОРМИРОВАТЬ ЛИСТОК НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ НА СРОК ДО

1. десяти рабочих дней включительно
2. пятнадцати календарных дней включительно
3. **десяти календарных дней включительно**
4. пятнадцати рабочих дней включительно

Вопрос 45

ЛЕЧАЩИЙ ВРАЧ ЕДИНОЛИЧНО ФОРМИРУЕТ ЛИСТОК НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ НА СРОК ДО

1. **пятнадцати календарных дней включительно**
2. пятнадцати рабочих дней включительно
3. десяти рабочих дней включительно
4. десяти календарных дней включительно

Вопрос 46
ЕСЛИ ГРАЖДАНЫН ОТСТРАНЕН ОТ РАБОТЫ В СВЯЗИ С КАРАНТИННОМ, ТО ЛИСТОК НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ ФОРМИРУЕТСЯ

1. врачом по медицинской профилактике
2. **врачом-инфекционистом**
3. врачом по общей гигиене
4. врачом-эпидемиологом

Вопрос 50

ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ У НАСЕЛЕНИЯ ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА

1. повышение качества жизни граждан
2. раннее выявление симптомов заболеваний
3. **информирование граждан о факторах риска для их здоровья**
4. **создание условий для занятий физической культурой и спортом**

Вопрос 52

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО МЕДИЦИНСКОГО ОСМОТРА У ГРАЖДАНЫНА ОПРЕДЕЛЯЮТ ГРУППУ

1. **диспансерного наблюдения**
2. **здоровья**
3. инвалидности
4. физической подготовленности

Вопрос 53

ЛИЦА, ЗАСТРАХОВАННЫЕ В СИСТЕМЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ, ИМЕЮТ ПРАВО НА

1. бесплатное лекарственное обеспечение при амбулаторном лечении
2. **выбор врача и медицинской организации, осуществляющей деятельность в сфере обязательного медицинского страхования**
3. **защиту персональных данных, необходимых для ведения персонифицированного учета в сфере обязательного медицинского страхования**
4. **выбор и замену страховой медицинской организации, осуществляющей деятельность в сфере обязательного медицинского страхования**

Вопрос 54

В СОСТАВ КОМИССИИ ПО РАЗРАБОТКЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ В СУБЪЕКТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ВХОДЯТ ПРЕДСТАВИТЕЛИ

1. общественных некоммерческих организаций, представляющих интересы пациентов
2. **территориального фонда, страховых медицинских организаций, медицинских организаций**
3. **медицинских профессиональных некоммерческих организаций, профессиональных союзов медицинских работников**
4. **органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации**

Вопрос 55

СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ В СИСТЕМЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ МОЖЕТ БЫТЬ ОБУСЛОВЛЕН

1. **заболеванием**
2. **травмой**
3. смертью
4. профилактическим осмотром

Вопрос 57

ГРАЖДАНЕ ИМЕЮТ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ ДОСТОВЕРНОЙ И СВОЕВРЕМЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ О

1. рейтингах медицинских организаций и индивидуальных показателях эффективности работы медицинских работников
2. **безопасности пищевых продуктов и рациональных нормах питания**
3. **санитарно-эпидемиологическом благополучии района проживания**
4. **потенциальной опасности для здоровья выполняемых работ и оказываемых услуг**

Вопрос 59
ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОКРУГОВ, ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ

1. **организуют информирование населения муниципального образования о возможности распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих**
2. **обеспечивают организацию оказания медицинской помощи только в случае передачи им соответствующих полномочий**
3. **обеспечивают создание благоприятных условий в целях привлечения медицинских работников для работы в медицинских организациях**
4. организуют проведение медицинских экспертиз, медицинских осмотров и медицинских освидетельствований

Вопрос 60
КАЖДЫЙ ГРАЖДАНЫН ИМЕЕТ ПРАВО ПО МЕДИЦИНСКИМ ПОКАЗАНИЯМ НА БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ В МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПО

1. вопросам медико-социальной поддержки пациентов с редкими (орфанными) заболеваниями
2. **вопросам планирования семьи**
3. **медико-генетическим вопросам**
4. **медико-психологическим аспектам семейно-брачных отношений**

Вопрос 61
ПРИ НАПРАВЛЕНИИ В МЕДИЦИНСКУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ ЖАЛОБЫ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ ГРАЖДАНЫН В ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ ДОЛЖЕН УКАЗАТЬ

1. **свои фамилию, имя и, при наличии, отчество**
2. **адрес электронной почты либо уникальный идентификатор личного кабинета на Едином портале государственных услуг**
3. наименование медицинской организации, в которую он направляет жалобу
4. фамилию, имя, отчество должностного лица, к которому он обращается

Вопрос 48
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ МЕДИЦИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОВЕРЯЮТ СОБЛЮДЕНИЕ

1. санитарно-эпидемиологических правил и норм
2. **порядков оказания медицинской помощи**
3. правил внутреннего распорядка
4. **правил проведения диагностических исследований**

Вопрос 57
ГРАЖДАНЫН МОЖЕТ ДАТЬ СОГЛАСИЕ НА РАЗГЛАШЕНИЕ СВЕДЕНИЙ О СЕБЕ, СОСТАВЛЯЮЩИХ ВРАЧЕБНУЮ ТАЙНУ, В

1. **виде заявления в простой письменной форме**
2. **информированном добровольном согласии на медицинское вмешательство**
3. виде заявления, заверенного нотариусом
4. устной форме при личном обращении в медицинскую организацию

Вопрос 67
ПРИ ОФОРМЛЕНИИ ЛИСТКА НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ ДВУЗНАЧНЫЙ КОД УКАЗЫВАЕТСЯ В ПОЛЕ

1. «Родственная (семейная) связь»
2. **«Причина нетрудоспособности»**
3. **«Дополнительный код»**
4. **«Отметки о нарушении условий оказания медицинской помощи»**

Вопрос 68

ФОНД ПЕНСИОННОГО И СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ВПРАВЕ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ПРОВЕРКУ СОБЛЮДЕНИЯ ПОРЯДКА _____ ЛИСТКОВ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ

1. **продления**
2. **оформления**
3. **выдачи**
4. хранения

Вопрос 69 [Высший блок]
Гражданин Б. обратился с жалобой к главному врачу поликлиники в связи с тем, что лечащий врач рекомендовал ему провести ультразвуковое исследование органов брюшной полости на платной основе. Гражданин Б. уточнил у врача, что данное исследование предусмотрено клиническими рекомендациями в соответствии с его диагнозом и входит в программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. Однако лечащий врач мотивировал свою рекомендацию тем, что в поликлинике очередь на бесплатные исследования более одного месяца.
ОЦЕНИТЕ ВЕРНОСТЬ ВСЕХ УТВЕРЖДЕНИЙ

1. предложение пройти ультразвуковое исследование на платной основе является правильным, так как врач заинтересован в получении результатов исследования в кратчайшие сроки для определения тактики ведения пациента
2. **отказ в оказании медицинской помощи в соответствии с программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и взимание платы за ее оказание не допускаются**
3. **сроки проведения диагностических исследований, в том числе ультразвуковых, устанавливаются в соответствии с программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи**
4. рекомендация лечащего врача обоснована, поскольку гражданин Б. нуждался в плановой медицинской помощи и, следовательно, имел право выбрать способ получения медицинской помощи: платно или бесплатно

Вопрос 70
Гражданин А. наблюдался в поликлинике №1. Он сменил место жительства и обратился с заявлением к главному врачу о прикреплении к поликлинике №2, которая была расположена ближе к дому. Главный врач поликлиники №2 отказал в прикреплении на том основании, что гражданин А. уже менял медицинскую организацию в течение текущего года.
ОЦЕНИТЕ ВЕРНОСТЬ ВСЕХ УТВЕРЖДЕНИЙ

1. гражданин имеет право выбора медицинской организации не чаще, чем 1 раз в год
2. гражданин не имеет права на выбор медицинской организации
3. **при изменении места жительства гражданин имеет право выбора медицинской организации чаще, чем 1 раз в год**
4. прикрепление гражданина к медицинской организации осуществляет страховая компания, в которой застрахован гражданин

Вопрос 70
При проведении проверки в рамках федерального государственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности пациент сообщил проверяющим, что ему было отказано в ознакомлении со своей медицинской документацией на бумажном носителе и предложено воспользоваться для этого своей электронной медицинской картой. При этом пациент указал на низкий уровень компьютерной грамотности и отсутствие навыков работы с ней.
ОЦЕНИТЕ ВЕРНОСТЬ ВСЕХ УТВЕРЖДЕНИЙ

1. медицинская документация должна быть доступна только медицинским работникам и не предназначена для пациентов
2. вопросы соблюдения прав пациентов не являются предметом федерального государственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности
3. **в данной ситуации врач был обязан помочь пациенту ознакомиться с медицинской документацией в электронном виде**
4. **в данной ситуации были нарушены права пациента на непосредственное ознакомление с медицинской документацией, отражающей состояние его здоровья**

Вопрос 71
Врач центра здоровья обратился к заведующему отделением с просьбой пояснить, какие исследования в рамках профилактического медицинского осмотра можно проводить с использованием экспресс-методов. Заведующий отделением дал пояснения.
ОЦЕНИТЕ ВЕРНОСТЬ ВСЕХ УТВЕРЖДЕНИЙ

1. определение уровня гемоглобина в крови можно проводить экспресс-методом, поскольку этот метод позволяет быстро получить значение показателя непосредственно в центре здоровья
2. **определение уровня общего холестерина в крови можно проводить экспресс-методом непосредственно в центре здоровья, поскольку все центры здоровья оснащены таким портативным прибором**
3. **определение уровня глюкозы в крови натощак можно проводить экспресс-методом непосредственно в центре здоровья, поскольку все центры здоровья оснащены таким портативным прибором**
4. определение уровня креатинина в крови можно проводить экспресс-методом, поскольку это позволяет выявлять пациентов с почечной недостаточностью непосредственно в центре здоровья

Вопрос 71
Гражданин О., 25 лет, работает во вредных и опасных условиях труда. После трудоустройства впервые был направлен фельдшером здравпункта для прохождения периодического медицинского осмотра. Гражданин О. пояснил, что недавно он проходил профилактический медицинский осмотр в поликлинике по месту жительства.
ОЦЕНИТЕ ВЕРНОСТЬ ВСЕХ УТВЕРЖДЕНИЙ
1. периодический медицинский осмотр проводится для определения соответствия состояния здоровья работника поручаемой ему работе, а профилактический медицинский осмотр нацелен на предупреждение социально значимых заболеваний
2. в данной ситуации можно освободить гражданина О. от прохождения периодического медицинского осмотра, поскольку недавно он проходил профилактический медицинский осмотр в поликлинике по месту жительства
3. освободить гражданина О. от прохождения периодического медицинского осмотра возможно при условии предоставления медицинских документов о прохождении профилактического медицинского осмотра
4. в данной ситуации невозможно освободить гражданина О. от прохождения периодического медицинского осмотра, поскольку цели и задачи профилактического и периодического медицинского осмотра различны

Вопрос 72
Гражданин К., 37 лет, обратился к врачу с просьбой направить его на диспансеризацию, но получил отказ. Врач направил его на профилактический медицинский осмотр. Гражданин К. посчитал, что его права нарушены, и обратился с жалобой к главному врачу поликлиники.
ОЦЕНИТЕ ВЕРНОСТЬ ВСЕХ УТВЕРЖДЕНИЙ

1. права пациента К. нарушены, и отказ врача неправомерен, потому что гражданин имеет право на проведение диспансеризации в любом возрасте и в любой медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь
2. **направление гражданина К. на профилактический медицинский осмотр правомерно, поскольку перечни медицинских исследований при диспансеризации и профилактическом осмотре различаются**
3. отказ врача неправомерен, потому что гражданам в возрасте от 30 лет и старше диспансеризация проводится 1 раз в год, следовательно, гражданин К. имеет право ее пройти
4. **отказ врача правомерен, потому что гражданам в возрасте от 18 до 39 лет диспансеризация проводится 1 раз в три года, следовательно, гражданин К. будет подлежать диспансеризации по достижении возраста 39 лет**

Вопрос 72

Гражданка Т., 34 лет, обратилась в трудовую инспекцию с жалобой на работодателя, который не отпустил ее с работы для прохождения диспансеризации, сославшись на производственную необходимость.

ОЦЕНИТЕ ВЕРНОСТЬ ВСЕХ УТВЕРЖДЕНИЙ

1. работодатели обязаны отпускать работников для прохождения медицинских осмотров и диспансеризации в соответствии с графиком, который утверждается работодателем до начала календарного года и доводится до сведения работников

2. работодатели обязаны беспрепятственно отпускать работников для прохождения медицинских осмотров и диспансеризации

3. работодатели обязаны отпускать работников для прохождения медицинских осмотров и диспансеризации, определяя конкретное время освобождения с учетом производственной необходимости

4. работодатели обязаны обеспечивать условия для прохождения работниками медицинских осмотров и диспансеризации

Вопрос 73

Гражданка Е. обратилась в страховую медицинскую организацию с жалобой на ненадлежащее качество медицинской помощи. Находясь в командировке в другом городе, она заболела и обратилась в ближайшую поликлинику, поскольку ей необходимо было получить медицинскую помощь и оформить листок нетрудоспособности. В кабинете неотложной помощи фельдшер сделал ей внутримышечную инъекцию жаропонижающего препарата. В оформлении листка нетрудоспособности фельдшер отказал, поскольку гражданка Е. была иногородней. По возвращении домой гражданке Е. был установлен диагноз «пневмония». Она проходила длительное лечение из-за того, что своевременно ей не была сделана рентгенография легких и не были назначены антибиотики.

ОЦЕНИТЕ ВЕРНОСТЬ ВСЕХ УТВЕРЖДЕНИЙ

1. если на фельдшера кабинета неотложной помощи были возложены отдельные функции лечащего врача, то он был обязан сформировать листок нетрудоспособности гражданине Е. единолично сроком до семи календарных дней
2. **если на фельдшера кабинета неотложной помощи были возложены отдельные функции лечащего врача, то он был обязан направить гражданку Е. к врачу-терапевту для оформления листка нетрудоспособности**
3. **установление обоснованности отказа в формировании (выдаче) листка нетрудоспособности гражданке Е. не входит в полномочия страховой медицинской организации**
4. установление обоснованности отказа в формировании (выдаче) листка нетрудоспособности гражданке Е. входит в полномочия территориального фонда обязательного медицинского страхования

Вопрос 74

Гражданка Д. выписана из родильного дома на пятый день после родов со своим новорожденным ребенком. На следующий день после выписки из роддома к ним пришел врач-педиатр участковый. Мать ребенка выразила опасения: "Может ли мой малыш бесплатно получать медицинскую помощь, ведь у него еще нет полиса обязательного медицинского страхования?" Врач дал разъяснения.

ОЦЕНИТЕ ВЕРНОСТЬ ВСЕХ УТВЕРЖДЕНИЙ

1. пока у ребенка гражданки Д. нет полиса обязательного медицинского страхования, бесплатная медицинская помощь будет оказываться только по экстренным показаниям
2. **гражданке Д. необходимо до истечения 30 дней со дня государственной регистрации рождения обратиться в страховую медицинскую организацию для получения полиса обязательного медицинского страхования для своего ребенка**
3. **ребенок гражданки Д. является застрахованным той же страховой медицинской организацией, в которой застрахована гражданка Д.**
4. **отсутствие полиса обязательного медицинского страхования у новорожденного ребенка гражданки Д. не является основанием для отказа в оказании ему бесплатной медицинской помощи**

Вопрос 75

Пациент М., 40 лет, обратился на приём к врачу — стоматологу-ортопеду. В процессе медицинского осмотра врач, не спрашивая разрешения, решил сфотографировать полость рта пациента для публикации данного клинического случая в научной статье. Пациент категорически отказался от фотографирования.
ОЦЕНИТЕ ВЕРНОСТЬ ВСЕХ УТВЕРЖДЕНИЙ

1. при фотографировании полости рта идентифицировать личность пациента невозможно, следовательно, согласие пациента не требуется
2. **действия врача неэтичны, так как врач должен был предупредить пациента о намерении сфотографировать полость рта и объяснить, в каких целях он планирует использовать фотографию**
3. если врач планирует использование фотографии полости рта пациента в научных целях, в том числе для публикации в научной статье, согласие пациента не требуется
4. **размещение сведений, составляющих врачебную тайну, в целях их публикации в научных изданиях допускается с письменного согласия гражданина**

Вопрос 75 (Множественный выбор)
На сайте городской больницы была размещена фотография пациента К. до и после операции по коррекции нижней челюсти в качестве примера мастерства челюстно-лицевых хирургов. Пациент К. давал письменное согласие на фотографирование, но не предполагал, что его фотография будет размещена на сайте. Он обратился с жалобой к главному врачу городской больницы.
ОЦЕНИТЕ ВЕРНОСТЬ ВСЕХ УТВЕРЖДЕНИЙ

1.размещение фотографии пациента К. на сайте не нарушает права пациента, поскольку он давал письменное согласие на фотографирование, и его фотография является собственностью медицинской организации

2. размещение фотографии пациента К. на сайте является нарушением Федерального закона № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»

3. размещение фотографии пациента К. на сайте является разглашением сведений, составляющих врачебную тайну, поскольку другие граждане узнали о факте его обращения за медицинской помощью и диагнозе

4. разглашение сведений, составляющих врачебную тайну, другим гражданам допускается только с письменного согласия гражданина

Вопрос 76
Пациент А., состоящий на диспансерном учете в психоневрологическом диспансере, изъявил желание сохранить в тайне данные о своем здоровье. При расследовании уголовного дела, по которому ранее проходил данный пациент, адвокат направил запрос о состоянии его здоровья. Медицинская организация передала соответствующую информацию адвокату. Пациент подал жалобу в связи с разглашением врачебной тайны.
ОЦЕНИТЕ ВЕРНОСТЬ ВСЕХ УТВЕРЖДЕНИЙ

1. **по запросу органов дознания, следствия, суда, прокуратуры информация о состоянии здоровья пациента А. может быть предоставлена без его согласия**
2. **в данной ситуации жалоба пациента А. обоснована, действия медицинской организации неправомерны**
3. адвокат, действующий в интересах пациента А., имеет право получить информацию о состоянии его здоровья
4. **информация о состоянии здоровья пациента А. не может быть предоставлена адвокату, так как это означает разглашение врачебной тайны**

Вопрос 77
Находясь на лечении в дневном стационаре, гражданка П. обратилась к медицинской сестре Ж. с просьбой «побыстрее поставить капельницу», так как ей нужно успеть забрать внука из детского сада. На что медицинская сестра грубо ответила: «Вас здесь много таких, а я одна. Пришли лечиться, так ждите! Как освобожусь, так и поставлю вам капельницу». Гражданка П. получила назначенное врачом лечение, но посчитала, что медицинская сестра должна быть наказана за такое отношение к ней и обратилась с жалобой к главному врачу поликлиники.
ОЦЕНИТЕ ВЕРНОСТЬ ВСЕХ УТВЕРЖДЕНИЙ

1. **гражданка П. вправе рассчитывать на уважительное и гуманное отношение со стороны медицинских работников**

2. медицинская сестра Ж. выполнила назначения врача, следовательно, оснований для признания жалобы обоснованной нет
3. **в данной ситуации медицинская сестра Ж. нарушила принципы медицинской этики, и жалоба пациентки П. является обоснованной**
4. в данной ситуации медицинская сестра Ж. действовала в соответствии с должностной инструкцией, и оснований для привлечения ее к дисциплинарной ответственности нет

Вопрос 1
ДОСТУПНОСТЬ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ЯВЛЯЕТСЯ ОДНИМ ИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ПРИ

1. разработке устава медицинской организации
2. разработке номенклатуры медицинских услуг
3. аккредитации медицинской организации
4. **независимой оценке медицинских услуг**

Вопрос 7
ПОД МЕДИЦИНСКИМ ОСМОТРОМ ПОНИМАЮТ КОМПЛЕКС МЕДИЦИНСКИХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ВЫЯВЛЕНИЕ ПАТОЛОГИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЙ, ЗАБОЛЕВАНИЙ И

1. предупреждение рецидивов хронических заболеваний
2. прогнозирование преждевременной смертности
3. проведение реабилитационных мероприятий
4. **факторов риска их развития**

Вопрос 9
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНО ОПРЕДЕЛЯЮТ ГРУППЫ

1. физической подготовленности
2. **здоровья для планирования профилактических мер и лечения**
3. для занятий физической культурой
4. риска развития хронических неинфекционных заболеваний

Вопрос 12
АНКЕТИРОВАНИЕ ПАЦИЕНТОВ, ПРОВОДИМОЕ В РАМКАХ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО ОСМОТРА, НАПРАВЛЕНО НА ОЦЕНКУ
1. признаков хронических неинфекционных заболеваний и факторов риска их развития у пациентов
2. их информированности о предоставляемых медицинской организацией услугах по профилактике хронических неинфекционных заболеваний
3. удовлетворенности пациентов организацией профилактических медицинских осмотров и диспансеризации
4. доступности исследований и консультаций при выполнении профилактических медицинских осмотров и диспансеризации

СТРУКТУРА ТАРИФА НА ОПЛАТУ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В СИСТЕМЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ

1. распоряжением органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации
2. **федеральным законом Российской Федерации**
3. распоряжением Федерального фонда обязательного медицинского страхования
4. постановлением Правительства Российской Федерации

Вопрос 16

ЭКСПЕРТИЗА КАЧЕСТВА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ В СФЕРЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ, ПРЕДУСМАТРИВАЕТ ОЦЕНКУ

1. соответствия фактических сроков предоставления медицинской помощи запланированным
2. степени выполнения запланированных объемов оказанной медицинской помощи по программе обязательного медицинского страхования
3. соответствия сведений о стоимости оказанной помощи нормативам затрат
4. **степени достижения запланированного результата при лечении пациента**

Вопрос 20

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТВЕЧАЕТ ЗА

1. реализацию мер по профилактике в сфере охраны здоровья

2. регистрацию лиц, пострадавших от радиационного воздействия и подвергшихся радиационному облучению в результате Чернобыльской и других радиационных катастроф и инцидентов

3. подготовку предложений Правительству по вопросам обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения

4. лицензирование медицинской деятельности медицинских организаций, фармацевтической деятельности, деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений

Вопрос 24

СВЕДЕНИЯ О РОЖДЕННОМ РЕБЕНКЕ И ЕГО МАТЕРИ МЕДИЦИНСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ

1. вносят в Федеральный реестр медицинских документов о рождении

2. передают в Министерство юстиции Российской Федерации

3. вносят в Единый государственный реестр записей актов гражданского состояния

4. передают органам местного самоуправления, в т.ч. администрациям сельских поселений

Вопрос 25

ЕСЛИ ТЕКСТ ПИСЬМЕННОГО ОБРАЩЕНИЯ К РУКОВОДИТЕЛЮ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ НЕ ПОДДАЕТСЯ ПРОЧТЕНИЮ, ТО ОТВЕТ НА ОБРАЩЕНИЕ НЕ ДАЕТСЯ, И ГРАЖДАНИН ИНФОРМИРУЕТСЯ ОБ ЭТОМ В ТЕЧЕНИЕ

1. 3 дней со дня поступления обращения
2. 3 дней со дня регистрации обращения
3. **7 дней со дня регистрации обращения**
4. 7 дней со дня поступления обращения

Вопрос 26

СВЕДЕНИЯ ОБ УМЕРШЕМ ЛИЦЕ МЕДИЦИНСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ

1. вносят в Федеральный реестр медицинских документов о смерти

2. передают в Министерство юстиции Российской Федерации

3. передают органам местного самоуправления, в т.ч. администрациям сельских поселений

4. вносят в Единый государственный реестр записей актов гражданского состояния

Вопрос 27

К ПОЛНОМОЧИЯМ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ ОТНОСЯТ ОРГАНИЗАЦИЮ ПРОВЕДЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ ЭКСПЕРТИЗ, МЕДИЦИНСКИХ ОСМОТРОВ И МЕДИЦИНСКИХ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЙ ТОЛЬКО В

1. медицинских организациях, подведомственных федеральным и региональным органам исполнительной власти
2. **медицинских организациях, подведомственных федеральным органам исполнительной власти**
3. медицинских организациях особого типа, подведомственных федеральным органам исполнительной власти
4. казенных и бюджетных медицинских организациях, подведомственных федеральным органам исполнительной власти

Вопрос 30

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ ОРГАНОМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ В СФЕРЕ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ СУБЪЕКТА РФ ЯВЛЯЕТСЯ

1. Управление Роспотребнадзора субъекта РФ
2. Территориальный орган Федерального службы по надзору в сфере здравоохранения
3. Правительство субъекта РФ
4. **Министерство (департамент, комитет, управление) здравоохранения субъекта РФ**

Вопрос 34

В КОНСИЛИУМЕ ПРИНИМАЮТ УЧАСТИЕ

1. несколько врачей одной или нескольких специальностей

2. врачи и средний медицинский персонал одной специальности

3. врачи только одной специальности

4. врачи и средний медицинский персонал нескольких специальностей

Вопрос 35

ДЛЯ ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ ХАРАКТЕРНО

1. обеспечение населения высокотехнологичной медицинской помощью
2. **предоставление населению первого контакта с системой здравоохранения**
3. обеспечение населения доступной стационарной помощи
4. оказание населению скорой медицинской помощи

Вопрос 37

ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ОКАЗЫВАТЬ ПАЛЛИАТИВНУЮ МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ, МЕДИЦИНСКИЕ РАБОТНИКИ ДОЛЖНЫ ПРОЙТИ

1. аттестацию
2. аккредитацию
3. сертификацию
4. **специальное обучение**

Вопрос 38
ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ КЛИНИЧЕСКОЙ АПРОБАЦИИ УТВЕРЖДАЕТ

1. руководитель медицинской организации
2. руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения
3. **уполномоченный федеральный орган исполнительной власти**
4. уполномоченный федеральный орган законодательной власти

Вопрос 46
ФЕЛЬДШЕР СКОРОЙ ПОМОЩИ ФОРМИРОВАТЬ (ВЫДАВАТЬ) ЛИСТОК НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ

1. имеет право при отсутствии в бригаде врача
2. имеет право в случае возложения на него отдельных функций лечащего врача
3. **не имеет права ни при каких условиях**
4. имеет право при работе в сельской местности

Вопрос 47
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ МЕДИЦИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОВЕРЯЮТ СОБЛЮДЕНИЕ

1. санитарно-эпидемиологических правил и норм
2. **правил проведения диагностических исследований**
3. **порядков оказания медицинской помощи**
4. правил внутреннего распорядка

Вопрос 50

ОТВЕТСТВЕННЫМИ ЗА ПРОВЕДЕНИЕ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕДИЦИНСКИХ ОСМОТРОВ И ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ ВСЕГО ПРИКРЕПЛЕННОГО НАСЕЛЕНИЯ ЯВЛЯЮТСЯ

1. **медицинские работники отделений (кабинетов) медицинской профилактики** [404н]
2. **руководители медицинских организаций** [404н]
3. **медицинские работники центров здоровья** [404н]
4. медицинские работники центров общественного здоровья и медицинской профилактики

Вопрос 52
НА ПЕРВОМ ЭТАПЕ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ ГРАЖДАНАМ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВОЗРАСТА И СОПУТСТВУЮЩЕЙ ПАТОЛОГИИ ПРОВОДЯТ ОПРЕДЕЛЕНИЕ РИСКА СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

1. альтернативного
2. **относительного**
3. **абсолютного**
4. вероятного

Вопрос 54

СОСТАВ ПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ФОНДА ВКЛЮЧАЕТ

1. представителей федеральных органов законодательной и исполнительной власти

2. представителей общероссийских объединений работодателей, общероссийских объединений профсоюзов и иных общественных объединений

3. руководителя уполномоченного федерального органа исполнительной власти и председателя Федерального фонда**вхолит по должности**

4. представителей Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения, Федеральной антимонопольной службы

Вопрос 57

ПРИ НАПРАВЛЕНИИ ЖАЛОБЫ В МЕДИЦИНСКУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ В ПИСЬМЕННОМ ВИДЕ ГРАЖДАНАН ОБЯЗАН

1. указать свои фамилию, имя, отчество, почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ

2. указать фамилию, имя, отчество или должность должностного лица, которому адресовано обращение

3. указать ожидаемый срок предоставления ответа

4. поставить личную подпись и дату

Вопрос 59

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СВЕДЕНИЙ, СОСТАВЛЯЮЩИХ ВРАЧЕБНУЮ ТАЙНУ, БЕЗ СОГЛАСИЯ ГРАЖДАННКА ИЛИ ЕГО ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ДОПУСКАЕТСЯ В ЦЕЛЯХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ УЧЕТА И КОНТРОЛЯ

1. качества и безопасности медицинской деятельности

2. финансовых затрат на лечение гражданина

3. в системе обязательного социального страхования

4. в системе обязательного пенсионного страхования

Вопрос 60

МЕДИЦИНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОСТАВЛЯЕТ ЖАЛОБУ ГРАЖДАННКА БЕЗ ОТВЕТА, ЕСЛИ

1. текст письменного обращения позволяет предположить у гражданина наличие психического заболеваниямедицинская помощь гражданину в данной медицинской организации не оказывалась

   3. в письменном обращении содержится вопрос, на который неоднократно давались письменные ответы по существу

   4. текст письменного обращения не поддается прочтению

Вопрос 61

ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОКРУГОВ, ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ

1. обеспечивают организацию оказания медицинской помощи только в случае передачи им соответствующих полномочий

2. обеспечивают создание благоприятных условий в целях привлечения медицинских работников для работы в медицинских организациях

3. организуют проведение медицинских экспертиз, медицинских осмотров и медицинских освидетельствований

4. организуют информирование населения муниципального образования о возможности распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих

Вопрос 64

ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ОКАЗАНИЯ ПАЛЛИАТИВНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПРЕДУСМАТРИВАЕТСЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ И

1. производителей медицинского оборудования и расходных материалов для паллиативной помощи
2. профессиональных некоммерческих организаций медицинских работников
3. организаций социального обслуживания
4. общественных объединений и некоммерческих организаций в сфере охраны здоровья

Вопрос 68
ФОРМИРОВАНИЕ ЛИСТКА НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ В ФОРМЕ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТА ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПРИ ПРЕДЪВЛЕНИИ

1. письменного заявления
2. идентификационного номера налогоплательщика
3. документа, удостоверяющего личность
4. страхового номера индивидуального лицевого счета гражданина в системе индивидуального (персонифицированного) учета

Вопрос 70
Пациент Д., 82 лет, находится в стационаре с тяжёлым неизлечимым заболеванием. Он попросил лечащего врача не сообщать супруге о своем диагнозе, чтобы «ее не расстраивать». Однако лечащий врач посчитал необходимым проинформировать супругу с учетом неблагоприятного прогноза заболевания у ее мужа.
ОЦЕНИТЕ ВЕРНОСТЬ ВСЕХ УТВЕРЖДЕНИЙ
1. врач был обязан учесть мнение пациента Д. и не сообщать о его диагнозе супруге
2. врач был обязан убедить пациента Д. в том, что о его диагнозе необходимо сообщить супруге
3. врач был обязан сообщить о диагнозе пациента Д. его супруге независимо от прогноза заболевания
4. врач был вправе принимать решение об информировании супруги пациента Д. с учетом прогноза заболевания

Вопрос 72
ВРАЧ ЦЕНТРА ЗДОРОВЬЯ ОБРАТИЛСЯ К ЗАВЕДУЮЩЕМУ ОТДЕЛЕНИЕМ С ПРОСЬБОЙ ПОЯСНИТЬ, КАКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В РАМКАХ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО МЕДИЦИНСКОГО ОСМОТРА МОЖНО ПРОВОДИТЬ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭКСПРЕСС-МЕТОДОВ. ЗАВЕДУЮЩИЙ ОТДЕЛЕНИЕМ ДАЛ ПОЯСНЕНИЯ.
ОЦЕНИТЕ ВЕРНОСТЬ ВСЕХ УТВЕРЖДЕНИЙ

1. определение уровня креатинина в крови можно проводить экспресс-методом, поскольку это позволяет выявлять пациентов с почечной недостаточностью непосредственно в центре здоровья
2. определение уровня гемоглобина в крови можно проводить экспресс-методом, поскольку этот метод позволяет быстро получить значение показателя непосредственно в центре здоровья
3. определение уровня глюкозы в крови натощак можно проводить экспресс-методом непосредственно в центре здоровья, поскольку все центры здоровья оснащены таким портативным прибором
4. определение уровня общего холестерина в крови можно проводить экспресс-методом непосредственно в центре здоровья, поскольку все центры здоровья оснащены таким портативным прибором

Вопрос 73
Гражданин Республики Казахстан М. прибыл в город Омск в гости к своему брату, гражданину Российской Федерации. Днем у него повысилось артериальное давление, произошла потеря сознания. Была вызвана скорая медицинская помощь. Врач скорой медицинской помощи предупредил о необходимости оплатить выезд бригады.
ОЦЕНИТЕ ВЕРНОСТЬ ВСЕХ УТВЕРЖДЕНИЙ
1. поводом для вызова скорой медицинской помощи в экстренной форме являются внезапные острые заболевания, состояния, обострения хронических заболеваний, представляющие угрозу жизни пациента, в том числе потеря сознания
2. иностранному гражданину, не застрахованному в системе обязательного медицинского страхования в Российской Федерации и не имеющему медицинского полиса, скорая медицинская помощь оказывается на платной основе
3. требование врача скорой медицинской помощи оплатить выезд бригады скорой медицинской помощи является нарушением прав иностранного гражданина М. как пациента

4. скорая медицинская помощь в экстренной форме должна быть оказана иностранному гражданину М. бесплатно

Вопрос 74
Гражданин Т., имеющий постоянную регистрацию во Владимирской области, в связи с семейными обстоятельствами временно переехал в Новосибирск для осуществления ухода за больной родственницей. Через некоторое время ему самому понадобилась медицинская помощь в связи с полученной бытовой травмой. Он обратился в поликлинику города Новосибирска, но в бесплатной медицинской помощи ему было отказано.
ОЦЕНИТЕ ВЕРНОСТЬ ВСЕХ УТВЕРЖДЕНИЙ

1. иногороднему пациенту, не имеющему временной регистрации, первичная медико-санитарная помощь оказывается на платной основе
2. бытовая травма не является страховым случаем и не подлежит оплате за счет средств обязательного медицинского страхования
3. **застрахованные лица имеют право на бесплатное оказание им медицинской помощи при наступлении страхового случая**
4. пациенту, не прикрепленному к поликлилинике, первичная медико-санитарная помощь не оказывается

Вопрос 75
К главному врачу городской больницы поступила письменная жалоба от пациентки В., 36 лет, в которой она указывает, что во время лечения в стационаре были нарушены её права как пациента. Изучая информацию о своем заболевании, она обнаружила, что в процессе лечения использовался лекарственный препарат, не предусмотренный клиническими рекомендациями. В ходе служебного расследования было установлено, что пациентка поступила в стационар в тяжёлом состоянии, и препарат, не предусмотренный клиническими рекомендациями, был назначен ей в связи с нарушением функции жизненно важных органов. Соответствующее решение было принято после проведения консилиума врачей.
ОЦЕНИТЕ ВЕРНОСТЬ ВСЕХ УТВЕРЖДЕНИЙ
1. в данной ситуации лекарственный препарат, не предусмотренный соответствующей клинической рекомендацией, был применен по жизненным показаниям, а значит, легитимно
2. в данной ситуации назначение и применение лекарственного препарата, не предусмотренного соответствующей клинической рекомендацией, должно быть оформлено решением врачебной комиссии
3. решение о назначении и применении лекарственного препарата, не предусмотренного соответствующей клинической рекомендацией, принимается с учетом согласия пациента
4. консилиум врачей вправе назначить лекарственный препарат, не предусмотренный соответствующей клинической рекомендацией

Вопрос 76
Пациент К., страдающий неизлечимым заболеванием и находящийся в хосписе, обратился к дочери с просьбой об эвтаназии. Дочь узнала из средств массовой информации о том, что в некоторых странах эвтаназия разрешена, и обратилась к лечащему врачу за разъяснением о возможности проведения эвтаназии пациенту К.
ОЦЕНИТЕ ВЕРНОСТЬ ВСЕХ УТВЕРЖДЕНИЙ

1. проведение эвтаназии противоречит общепризнанным принципам и нормам международного права, поэтому легально в Российской Федерации она не проводится
2. несмотря на возможность осуществления эвтаназии, врач в Российской Федерации вправе воздержаться от участия в данной процедуре
3. **проведение эвтаназии противоречит этическим принципам медицины и в Российской Федерации запрещено законодательно**
4. проведение эвтаназии в Российской Федерации возможно только в частных медицинских организациях, имеющих соответствующую лицензию

Вопрос 77
Пациент Д. находился на лечении в центральной районной больнице Н-ской области. Эффект от проводимой терапии отсутствовал, и состояние его здоровья прогрессивно ухудшалось. Родственники настаивали на переводе пациента Д. в ведущую многопрофильную медицинскую организацию — областную больницу Н-ской области — для лечения лекарственным препаратом, не зарегистрированным в

Российской Федерации, но который мог бы ему помочь. Консилиум врачей принял решение продолжить лечение пациента Д. в центральной районной больнице и назначить ему не зарегистрированный в Российской Федерации лекарственный препарат.
ОЦЕНИТЕ ВЕРНОСТЬ ВСЕХ УТВЕРЖДЕНИЙ
1. решение о назначении по жизненным показаниям пациенту Д. не зарегистрированного в Российской Федерации лекарственного препарата принято обоснованно и не противоречит законодательству
2. консилиум врачей не может принимать решение о назначении пациенту Д. не зарегистрированного в Российской Федерации лекарственного препарата
3. решение о назначении пациенту Д. не зарегистрированного в Российской Федерации лекарственного препарата может принять врачебная комиссия только Н-ской областной больницы, являющейся ведущей многопрофильной медицинской организацией в регионе
4. врачебная комиссия центральной районной больницы Н-ской области не имеет права принимать решение о назначении пациенту Д. не зарегистрированного в Российской Федерации лекарственного препарата

———

Вопрос 78
Пациент Р. обратился в поликлинику №1 с заявлением о прикреплении конкретно к врачу-терапевту участковому Г., который работает в данной медицинской организации. Главный врач ответил отказом в связи с тем, что врач Г. не согласен, так как на его участке численность прикрепленного населения существенно превышает нормативную.
ОЦЕНИТЕ ВЕРНОСТЬ ВСЕХ УТВЕРЖДЕНИЙ
1. отказ главного врача правомерен, однако он должен был предложить пациенту Р. альтернативный вариант прикрепления к другому врачу-терапевту участковому
2. в данной ситуации, с учетом приоритета интересов пациента при оказании медицинской помощи, согласие врача Г. не требуется
3. отказ главного врача правомерен, так как пациент Р. имеет право на выбор врача с учетом согласия самого врача
4. отказ в прикреплении к конкретному врачу неправомерен, поскольку пациент Р. имеет право не только на выбор медицинской организации, но и на выбор врача

———

Вопрос 79
Пациент Ж., 52 года, работает по трудовому договору. В течение четырех месяцев является временно нетрудоспособным в связи с заболеванием, листок нетрудоспособности оформлен. При очередном приеме признаки временной нетрудоспособности сохраняются. По заключению врачебной комиссии клинический и трудовой прогноз неблагоприятный.
ОЦЕНИТЕ ВЕРНОСТЬ ВСЕХ УТВЕРЖДЕНИЙ

1. при очевидном неблагоприятном клиническом и трудовом прогнозе продление листка нетрудоспособности возможно только по заключению врачебной комиссии и на срок не более десяти месяцев
2. продление листка нетрудоспособности на срок более четырех месяцев возможно только при благоприятном клиническом и трудовом прогнозе
3. **при очевидном неблагоприятном клиническом и трудовом прогнозе не позднее четырех месяцев с даты начала временной нетрудоспособности пациент направляется для прохождения медико-социальной экспертизы**
4. независимо от клинического и трудового прогноза продление листка нетрудоспособности возможно по заключению врачебной комиссии на весь период заболевания

———

Вопрос 80
Гражданка В. обратилась в поликлинику к врачу с просьбой выдать ей «больничный» со вчерашнего дня, поскольку она заболела накануне, на работу не ходила, вызывала скорую медицинскую помощь.
ОЦЕНИТЕ ВЕРНОСТЬ ВСЕХ УТВЕРЖДЕНИЙ
1. по решению врачебной комиссии врач сформировал (выдал) гражданке В. листок нетрудоспособности со вчерашнего дня
2. врач направил гражданку В. на врачебную комиссию
3. врач обязан единолично сформировать (выдать) листок нетрудоспособности со вчерашнего дня, поскольку гражданка В. вызывала скорую медицинскую помощь, что документально подтверждает факт ее заболевания накануне
4. врач отказал гражданке В. в формировании (выдаче) листка нетрудоспособности со вчерашнего дня

Вопрос 1
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ МЕДИЦИНСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ СОЗДАЕТСЯ
1. общественный совет
2. контрольная комиссия
3. экспертный комитет
4. независимая группа

Вопрос 2
НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПОРЯДКИ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

1. носят рекомендательный характер для частных медицинских организаций
2. **обязательны для исполнения всеми медицинскими организациями**
3. должны учитываться при организации оказания помощи социально незащищенным группам населения
4. должны учитываться при проведение научных исследований

Вопрос 3
В ПОЛНОМОЧИЯ РОСЗДРАВНАДЗОРА ВХОДИТ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ В ОТНОШЕНИИ СОБЛЮДЕНИЯ

1. финансовой дисциплины
2. противопожарной безопасности
3. охраны труда
   4. прав граждан в сфере охраны здоровья

Вопрос 4
НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОКАЗАНИЯ УСЛУГ МЕДИЦИНСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ЯВЛЯЕТСЯ ОДНОЙ ИЗ ФОРМ _____ КОНТРОЛЯ
1. общественного
2. ведомственного
3. внутреннего
4. государственного

Вопрос 7
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРИВИВОК РЕБЕНКУ ОТ РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) ТРЕБУЕТСЯ
1. информированное добровольное согласие в письменной форме
2. разрешение в письменной форме
3. согласие в устной форме
4. заявление в письменной форме на имя руководителя медицинской организации

Вопрос 9
ПОРЯДОК И ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ ОСМОТРОВ, ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ, ДИСПАНСЕРНОГО НАБЛЮДЕНИЯ И ПЕРЕЧЕНЬ ВКЛЮЧАЕМЫХ В НИХ ИССЛЕДОВАНИЙ УТВЕРЖДАЮТСЯ, КАК ПРАВИЛО,

1. методическими рекомендациями федерального фонда обязательного медицинского страхования
2. постановлением Правительства Российской Федерации
3. **Зуполномоченным федеральным органом исполнительной власти**
4. приказом главного врача медицинской организации

Вопрос 15
КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ СТРАХОВЫХ МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ВПРАВЕ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ

1. медицинские организации
2. застрахованные лица
3. общественные некоммерческие организации
4. **территориальный фонд**

Вопрос 17
ЭКСПЕРТ КАЧЕСТВА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ДОЛЖЕН ИМЕТЬ СТАЖ РАБОТЫ ПО СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ВРАЧЕБНОЙ СПЕЦИАЛЬНОСТИ НЕ МЕНЕЕ (В ГОДАХ)

1. 7
2. 3
3. **10**
4. 5

Вопрос 20
ПОЛОЖЕНИЕ О ЕДИНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ УТВЕРЖДЕНО
1. Правительством Российской Федерации
2. уполномоченным федеральным органом исполнительной власти
3. Государственной Думой Федерального собрания Российской Федерации
4. Министерством здравоохранения Российской Федерации

Вопрос 21
ОДНОЙ ИЗ ОБЯЗАННОСТЕЙ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ

1. осуществление научной и (или) научно-исследовательской деятельности в области медицины
2. **внедрение безопасных методов сбора медицинских отходов и обеспечение защиты от травмирования элементами медицинских изделий**
3. заключение соглашений с фармацевтическими компаниями о назначении или рекомендации пациентам лекарственных препаратов, медицинских изделий
4. проведение фундаментальных и прикладных научных исследований

Вопрос 24
ЕСЛИ ОТВЕТ НА ОБРАЩЕНИЕ ГРАЖДАНАНИНА К РУКОВОДИТЕЛЮ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ДАН БЕЗ РАЗГЛАШЕНИЯ СВЕДЕНИЙ, СОСТАВЛЯЮЩИХ ГОСУДАРСТВЕННУЮ ИЛИ ИНУЮ ОХРАНЯЕМУЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ ТАЙНУ, ТО

1. переписка с гражданином по данному вопросу прекращается
2. **гражданину сообщается о невозможности дать ответ**
3. данное обращение направляется в органы внутренних дел
4. данное обращение направляется в комитет государственной безопасности

Вопрос 26
РЕГУЛЯРНОЕ ИНФОРМИРОВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ЧЕРЕЗ СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, О РАСПРОСТРАНЕННОСТИ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ВХОДИТ В КОМПЕТЕНЦИЮ
1. федеральных органов государственной власти

2. координационных советов по правам застрахованных лиц
3. органов местного самоуправления
4. территориальных органов Росздравнадзора

Вопрос 27
РАЗГЛАШЕНИЕМ ВРАЧЕБНОЙ ТАЙНЫ ЯВЛЯЕТСЯ
1. информирование третьих лиц о результатах, полученных в ходе проведения обследования и анализов
2. сообщение сведений о состоянии здоровья законным представителям
3. предоставление информации по запросу следствия, суда, военкомата и прокуратуры
4. обмен информацией между медучреждениями для оказания квалифицированной помощи

Вопрос 28
К ВИДУ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПО ПРОГРАММЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ БЕСПЛАТНОГО ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ОТНОСЯТ

1. санаторно-курортную помощь
2. медицинскую помощь в рамках клинической апробации
3. **скорую, в том числе скорую специализированную помощь**
4. стационарную помощь

Вопрос 29
ПОЛОЖЕНИЕ ОБ АККРЕДИТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ ДЛЯ ДОПУСКА К МЕДИЦИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УТВЕРЖДАЕТСЯ

1. уполномоченным федеральным органом законодательной власти
2. **уполномоченным федеральным органом исполнительной власти**
3. органом законодательной власти субъекта Российской Федерации
4. органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации

Вопрос 31
МЕДИЦИНСКОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО, НЕОБХОДИМОЕ ПО ЭКСТРЕННЫМ ПОКАЗАНИЯМ ДЛЯ УСТРАНЕНИЯ УГРОЗЫ ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА, ДОПУСКАЕТСЯ
1. без согласия гражданина, если его состояние не позволяет выразить свою волю
2. с письменного согласия гражданина или его законного представителя
3. по приказу главного врача
4. с устного согласия гражданина или его законного представителя

Вопрос 35
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ВРАЧЕБНОЙ КОМИССИИ ВЫДАЕТСЯ ПАЦИЕНТУ НЕ ПОЗДНЕЕ

1. трех календарных дней со дня поступления запроса
2. трех календарных дней со дня оформления протокола
3. **трех рабочих дней со дня поступления запроса**
4. трех рабочих дней со дня оформления протокола

Вопрос 38

КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПЕРЕСМАТРИВАЮТСЯ НЕ РЕЖЕ ОДНОГО РАЗА В (В ГОДАХ)

1. 3
2. 4
3. 2
4. 5

Вопрос 46

ЛИСТОК НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ В ФОРМЕ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТА ПОДПИСЫВАЕТСЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ _____ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСИ МЕДИЦИНСКИМ РАБОТНИКОМ И МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ

1. заверенной
2. усиленной неквалифицированной
3. простой
4. **усиленной квалифицированной**

Вопрос 47

ДОСТУПНОСТЬ И КАЧЕСТВО МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ОБЕСПЕЧИВАЮТСЯ

1. **использованием телемедицинских технологий**
2. организацией мероприятий по первичной, вторичной и третичной профилактике хронических неинфекционных заболеваний
3. **применением порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций и стандартов медицинской помощи**
4. внедрением единых подходов к назначению стимулирующих выплат медицинскому персоналу

Вопрос 48

В СИСТЕМЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНТРОЛЯ ОБЪЁМОВ, СРОКОВ, КАЧЕСТВА И УСЛОВИЙ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ УСТАНАВЛИВАЕТ _____ МЕРОПРИЯТИЙ

1. место проведения
2. **формы проведения**
3. **продолжительность**
4. **периодичность проведения**

Вопрос 49

ВЕДОМСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ МЕДИЦИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ОСУЩЕСТВЛЯЮТ

1. органы местного самоуправления
2. **федеральные органы исполнительной власти**
3. **исполнительные органы субъектов Российской Федерации**
4. территориальные фонды обязательного медицинского страхования

Вопрос 50

В ТЕРРИТОРИАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ БЕСПЛАТНОГО ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ВКЛЮЧЕНЫ

1. **профилактические медицинские осмотры**
2. периодические медицинские осмотры
3. **мероприятия диспансеризации**
4. **мероприятия по диспансерному наблюдению**

Вопрос 51
ПРОФИЛАКТИКА НЕИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ НА УРОВНЯХ

1. межгрупповом
2. **популяционном**
3. **групповом**
4. **индивидуальном**

Вопрос 53
СТРАХОВЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ОСУЩЕСТВЛЯЮТ СВОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ОСНОВАНИИ ДОГОВОРОВ, ЗАКЛЮЧЕННЫХ МЕЖДУ СТРАХОВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ И

1. **территориальным фондом обязательного медицинского страхования**
2. застрахованным лицом
3. Федеральным фондом обязательного медицинского страхования
4. **медицинской организацией**

Вопрос 54
ЛИЦА, ЗАСТРАХОВАННЫЕ В СИСТЕМЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ, ИМЕЮТ ПРАВО НА

1. бесплатное лекарственное обеспечение при амбулаторном лечении
2. **выбор и замену страховой медицинской организации, осуществляющей деятельность в сфере обязательного медицинского страхования**
3. **выбор врача и медицинской организации, осуществляющей деятельность в сфере обязательного медицинского страхования**
4. **защиту персональных данных, необходимых для ведения персонифицированного учета в сфере обязательного медицинского страхования**

Вопрос 55
ОБЯЗАННОСТЯМИ СТРАХОВАТЕЛЯ ЯВЛЯЮТСЯ

1. **регистрация и снятие с регистрационного учета в целях обязательного медицинского страхования**
2. предоставление информации о взносах на обязательное медицинское страхование в Федеральную налоговую службу
3. предоставление информации о регистрации в качестве страхователя в Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации
4. **своевременная и полная уплата страховых взносов на обязательное медицинское страхование**

Вопрос 56
СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ В СИСТЕМЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ МОЖЕТ БЫТЬ ОБУСЛОВЛЕН

1. **заболеванием**
2. **профилактическим осмотром**

3. смертью
4. **травмой**

Вопрос 57
МЕДИЦИНСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ИНФОРМИРУЮТ ОРГАНЫ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ БЕЗ СОГЛАСИЯ ГРАЖДАНА ИЛИ ЕГО ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ О

1. поступлении пациента, с симптомами, характерными для воздействия ионизирующего излучения, при отсутствии подтверждения его контакта с источниками радиации
2. **поступлении пациента, который по состоянию здоровья, возрасту или иным причинам не может сообщить данные о своей личности**
3. **смерти пациента, личность которого не установлена**
4. **поступлении пациента с признаками вреда здоровью в результате противоправных действий**

Вопрос 58
ПРИ НЕВОЗМОЖНОСТИ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В УЧРЕЖДЕНИЯХ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ЛИЦА, ЗАКЛЮЧЕННЫЕ ПОД СТРАЖУ ИЛИ ОТБЫВАЮЩИЕ НАКАЗАНИЕ В ВИДЕ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ, ИМЕЮТ ПРАВО НА

1. **оказание медицинской помощи в медицинских организациях муниципальной системы здравоохранения** *(Примечание: а также государственной)*
2. приглашение для проведения консультаций врачей-специалистов из частных медицинских организаций, оказывающих специализированную помощь по профилю патологии пациента
3. **приглашение для проведения консультаций врачей-специалистов из государственных и муниципальных медицинских организаций, оказывающих специализированную помощь по профилю патологии пациента**
4. **оказание медицинской помощи в медицинских организациях государственной системы здравоохранения**

Вопрос 59
РЕШЕНИЕ О ВЫДАЧЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА ЗАНЯТИЕ НАРОДНОЙ МЕДИЦИНОЙ ПРИНИМАЕТСЯ НА ОСНОВАНИИ ЗАЯВЛЕНИЯ ГРАЖДАНА И

1. **совместного представления медицинской профессиональной некоммерческой организации и медицинской организации**
2. **представления медицинской профессиональной некоммерческой организации**
3. ходатайства общественной организации, объединяющей пациентовзаключения экспертизы качества и безопасности медицинской помощи, проведенной независимой группой экспертов

Вопрос 61
ГРАЖДАНИН ИМЕЕТ ПРАВО ОБРАЩАТЬСЯ В МЕДИЦИНСКУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ С

1. апелляциями
2. **жалобами**
3. **предложениями**
4. **заявлениями**

Вопрос 63
ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ В СТРУКТУРЕ МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ МОГУТ СОЗДАВАТЬСЯ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ, ОКАЗЫВАЮЩИЕ УКАЗАННУЮ ПОМОЩЬ В НЕОТЛОЖНОЙ ФОРМЕ ПРИ

1. **состояниях, не требующих экстренной медицинской помощи**
2. **внезапных острых заболеваниях и обострении хронических заболеваний**
3. **состояниях, не сопровождающихся угрозой жизни пациента**
4. состояниях, требующих проведения малоинвазивных вмешательств

Вопрос 64
МЕДИЦИНСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ НАПРАВЛЕНА НА

1. предупреждение развития сопутствующих заболеваний у пациента
2. **сохранение работоспособности пациента**
3. **предупреждение и снижение степени возможной инвалидности пациента**
4. **улучшение качества жизни пациента**

Вопрос 66
В МЕДИЦИНСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, ИСПОЛЬЗУЕМОЙ В МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, РЕГИСТРИРУЮТСЯ НОМЕРА ЛИСТКОВ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ С УКАЗАНИЕМ

1. **даты формирования (выдачи) и продления, выписки гражданина на работу**
2. **сведений о направлении гражданина в другую медицинскую организацию**
3. основного государственного регистрационного номера медицинской организации
4. **сведений о направлении гражданина в учреждение медико-социальной экспертизы**

Вопрос 67
ЕСЛИ ГРАЖДАННИН ОТСТРАНЕН ОТ РАБОТЫ В СВЯЗИ С КАРАНТИНОМ, ТО ЛИСТОК НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ ФОРМИРУЕТСЯ НА ВЕСЬ

1. **период изоляции гражданина**
2. **период временного отстранения от работы**
3. инкубационный период заболевания
4. период обследования гражданина

Вопрос 68
ФОРМИРОВАНИЕ (ВЫДАЧА) И ПРОДЛЕНИЕ ЛИСТКА НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ ПОСЛЕ

1. подачи гражданином заявления о согласии на оформление ему листка нетрудоспособности в электронном виде
2. **записи данных о состоянии здоровья пациента в медицинской документации**
3. **проведения осмотра пациента медицинским работником**
4. получения добровольного информированного согласия пациента на медицинское вмешательство

Вопрос 69

Проверка Росздравнадзора установила, что в стационаре пациенты не получали лечебного питания. Обеспечение пациентов питанием осуществлялось сторонней коммерческой организацией путем аутсорсинга. При этом питание пациентам предоставлялось, но требования к рациону лечебного питания не соблюдались.
ОЦЕНИТЕ ВЕРНОСТЬ ВСЕХ УТВЕРЖДЕНИЙ

1. **в случае нахождения на лечении в стационарных условиях пациент имеет право на получение лечебного питания**
2. право пациента на получение лечебного питания в условиях стационара закреплено в Федеральном законе № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации»
3. согласно российскому законодательству, передача функции по обеспечению пациентов стационара питанием сторонней коммерческой организации на условиях аутсорсинга недопустима
4. в случае использования механизма аутсорсинга обеспечение лечебным питанием пациентов, находящихся на лечении в стационаре, не является обязанностью медицинской организации

Вопрос 70
Пациент К. обратился к лечащему врачу с просьбой, чтобы его не осматривали студенты медицинского вуза, которые проходят практику в данном отделении стационара. Врач объяснил, что больница является клинической и поэтому любой пациент, в том числе и пациент К., может осматриваться лечащим врачом совместно со студентами и ординаторами. Пациент обратился за разъяснениями к заведующему отделением.
ОЦЕНИТЕ ВЕРНОСТЬ ВСЕХ УТВЕРЖДЕНИЙ

1. **заведующий отделением расценил данную ситуацию как нарушение прав пациента К. и принял решение о проведении инструктажа лечащих врачей о правах пациентов и недопустимости их нарушения**
2. **лечащий врач был обязан получить согласие пациента К. на участие обучающихся в оказании ему медицинской помощи**
3. заведующий отделение разъяснил, что в клинической больнице пациенты не вправе отказаться от участия обучающихся в оказании им медицинской помощи
4. **пациент К. имеет право отказаться от участия обучающихся в оказании ему медицинской помощи**

Вопрос 71
При анализе медицинской документации гражданина Ш., 42 лет, явившегося на диспансеризацию, врач установил, что месяц назад ему была сделана электрокардиограмма. Патологических изменений выявлено не было. Врач принял решение учесть результат ранее сделанной электрокардиограммы и не назначать это исследование повторно.
ОЦЕНИТЕ ВЕРНОСТЬ ВСЕХ УТВЕРЖДЕНИЙ

1. **в данной ситуации у врача есть основания учесть результаты ранее проведенных исследований**
2. **при проведении диспансеризации результаты ранее проведенных исследований могут быть учтены только в случае их подтверждения медицинскими документами гражданина**
3. при проведении диспансеризации результаты ранее проведенных лабораторных и инструментальных исследований не учитываются
4. при проведении диспансеризации могут учитываться результаты ранее проведённых исследований, если с момента их выполнения прошло не более 6 месяцев

Вопрос 72
Гражданин К., 37 лет, обратился к врачу с просьбой направить его на диспансеризацию, но получил отказ. Врач направил его на профилактический медицинский осмотр. Гражданин К. посчитал, что его права нарушены, и обратился с жалобой к главному врачу поликлиники.
ОЦЕНИТЕ ВЕРНОСТЬ ВСЕХ УТВЕРЖДЕНИЙ

1. права пациента К. нарушены, и отказ врача неправомерен, потому что гражданин имеет право на проведение диспансеризации в любом возрасте и в любой медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь
2. **отказ врача правомерен, потому что гражданам в возрасте от 18 до 39 лет диспансеризация проводится 1 раз в три года, следовательно, гражданин К. будет подлежать диспансеризации по достижении возраста 39 лет**
3. направление гражданина К. на профилактический медицинский осмотр неправомерно, поскольку перечни медицинских исследований при диспансеризации и профилактическом осмотре различаются
4. отказ врача неправомерен, потому что гражданам в возрасте от 30 лет и старше диспансеризация проводится 1 раз в год, следовательно, гражданин К. имеет право ее пройти

Вопрос 73

Гражданка Д. выписана из родильного дома на пятый день после родов со своим новорожденным ребенком. На следующий день после выписки из роддома к ним пришел врач-педиатр участковый. Мать ребенка выразила опасения: «Может ли мой малыш бесплатно получать медицинскую помощь, ведь у него еще нет полиса обязательного медицинского страхования?» Врач дал разъяснения.
ОЦЕНИТЕ ВЕРНОСТЬ ВСЕХ УТВЕРЖДЕНИЙ

1. **ребенок гражданки Д. является застрахованным той же страховой медицинской организацией, в которой застрахована гражданка Д.**
2. пока у ребенка гражданки Д. нет полиса обязательного медицинского страхования, бесплатная медицинская помощь будет оказываться только по экстренным показаниям
3. **отсутствие полиса обязательного медицинского страхования у новорожденного ребенка гражданки Д. не является основанием для отказа в оказании ему бесплатной медицинской помощи**
4. гражданке Д. необходимо до истечения 60 дней со дня государственной регистрации рождения обратиться в страховую медицинскую организацию для получения полиса обязательного медицинского страхования для своего ребенка

Вопрос 74

Гражданка Е. обратилась в страховую медицинскую организацию с жалобой на ненадлежащее качество медицинской помощи. Находясь в командировке в другом городе, она заболела и обратилась в ближайшую поликлинику, поскольку ей необходимо было получить медицинскую помощь и оформить листок нетрудоспособности. В кабинете неотложной помощи фельдшер сделал ей внутримышечную инъекцию жаропонижающего препарата. В оформлении листка нетрудоспособности фельдшер отказал, поскольку гражданка Е. была иногородней. По возвращении домой гражданке Е. был установлен диагноз «пневмония». Она проходила длительное лечение из-за того, что своевременно ей не была сделана рентгенография легких и не были назначены антибиотики.
ОЦЕНИТЕ ВЕРНОСТЬ ВСЕХ УТВЕРЖДЕНИЙ

1. **если на фельдшера кабинета неотложной помощи не были возложены отдельные функции лечащего врача, то он был обязан направить гражданку Е. к врачу-терапевту для оформления листка нетрудоспособности**
2. установление обоснованности отказа в формировании (выдаче) листка нетрудоспособности гражданке Е. не входит в полномочия страховой медицинской организации
3. установление обоснованности отказа в формировании (выдаче) листка нетрудоспособности гражданке Е. входит в полномочия территориального фонда обязательного медицинского страхования
4. если на фельдшера кабинета неотложной помощи были возложены отдельные функции лечащего врача, то он был обязан сформировать листок нетрудоспособности гражданке Е. единолично сроком до семи календарных дней

Вопрос 75

В отдел кадров поликлиники обратился врач М., который завершил обучение в ординатуре по специальности «Кардиология» и успешно прошел первичную специализированную аккредитацию 6 лет назад, однако в течение этого периода по данной специальности не работал. Руководитель медицинской организации решил принять его на работу врачом-стажером и направить на обучение по программе профессиональной переподготовки по специальности «Кардиология». Врач М. считает, что его надо принять на должность врача-кардиолога.
ОЦЕНИТЕ ВЕРНОСТЬ ВСЕХ УТВЕРЖДЕНИЙ

1. решение главного врача о принятии врача М. на должность врача-стажера неправильное: врач М. должен быть принят на должность врача-кардиолога, поскольку он закончил ординатуру по данной специальности и успешно прошел первичную

специализированную аккредитацию

врач М. не может быть принят на должность врача-кардиолога, так как он не работал по специальности «Кардиология» более пяти лет

лица, имеющие подготовку в ординатуре, после обучения по программе профессиональной переподготовки повторно первичную специализированную аккредитацию не проходят

после обучения по программе профессиональной переподготовки по специальности «Кардиология» врач М. должен пройти первичную специализированную аккредитацию

Вопрос 76

Медицинская сестра отказалась выдать электрокардиограмму пациента Е. его супруге, сославшись на врачебную тайну. Женщина обратилась к врачу функциональной диагностики. При внимательном изучении медицинской карты пациента Е. врач обратил внимание, что в добровольном информированном согласии содержится разрешение на информирование супруги о состоянии здоровья и проводимых исследованиях.
ОЦЕНИТЕ ВЕРНОСТЬ ВСЕХ УТВЕРЖДЕНИЙ

врач предоставил результаты ЭКГ-исследования супруге пациента Е. на основании того, что пациент указал ее в добровольном информированном согласии на медицинское вмешательство как лицо, которому разрешается сообщать сведения, составляющие врачебную тайну

врач не имел права выдавать результаты ЭКГ-исследования супруге пациента Е., потому что сведения, полученные при медицинском обследовании пациента, составляют врачебную тайну и не подлежат разглашению

врач не имел права выдавать результаты ЭКГ-исследования супруге пациента Е., поскольку добровольное информированное согласие дается на медицинское вмешательство, а не на разглашение сведений, составляющих врачебную тайну

врач предоставил результаты ЭКГ-исследования супруге пациента Е., поскольку это не нарушает прав пациента и не противоречит Федеральному закону № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»

Вопрос 77
Пациент В., 10 лет, поступил в городскую больницу скорой медицинской помощи в ночное время с острой хирургической патологией, требующей проведения срочной операции. Родители ребенка от операции отказались, сославшись на свои религиозные убеждения. Дежурный врач-хирург принял решение о проведении оперативного лечения.
ОЦЕНИТЕ ВЕРНОСТЬ ВСЕХ УТВЕРЖДЕНИЙ

решение дежурного врача-хирурга о проведении операции пациенту В. без согласия родителей необходимо было согласовать с главным врачом

дежурный врач-хирург не имел права проводить операцию, поскольку родители пациента В. не дали согласия на медицинское вмешательство

дежурный врач-хирург должен был получить согласие самого пациента В. на проведение операции

действия дежурного врача-хирурга правомерны, так как операция была необходима пациенту В. по экстренным показаниям

Вопрос 78
Сослуживец пациента К., поступившего накануне в отделение кардиореанимации, позвонил на пост медицинской сестры и поинтересовался, находится ли его коллега по работе К. на лечении и каково состояние его здоровья. Медицинская сестра И. сказала: «Да, такой пациент находится у нас на лечении, но информацию о его здоровье я могу сообщить только близким родственникам».
ОЦЕНИТЕ ВЕРНОСТЬ ВСЕХ УТВЕРЖДЕНИЙ

на медицинскую сестру И. не распространяются требования о соблюдении врачебной тайны, потому что она имеет среднее профессиональное образование и врачом не является

сведения о факте обращения пациента К. за оказанием медицинской помощи составляют врачебную тайну

врачебную тайну составляют только сведения о состоянии здоровья пациента К.

в данной ситуации медицинская сестра И. нарушила врачебную тайну

Вопрос 79
Гражданка М., 35 лет, работает бухгалтером в школе. С12 февраля возникла необходимость ухода за больным отцом. Ей был сформирован листок нетрудоспособности с 12 по 18 февраля. С 19 февраля она должна была приступить к работе, однако необходимость ухода за отцом сохранялась. Лечащий врач в продлении листка нетрудоспособности отказал.
ОЦЕНИТЕ ВЕРНОСТЬ ВСЕХ УТВЕРЖДЕНИЙ

1. **в данной ситуации у лечащего врача нет оснований для продления листка нетрудоспособности**
2. при сохранении необходимости ухода за взрослым членом семьи лицу, осуществляющему уход, выдается листок нетрудоспособности на весь период до выздоровления пациента
3. в данной ситуации у лечащего врача есть основания для направления гражданки М. на врачебную комиссию для продления листка нетрудоспособности на срок до 15 дней
4. **в случаях ухода за взрослым членом семьи при лечении в амбулаторных условиях листок нетрудоспособности формируется не более чем на 7 календарных дней**

Вопрос 80
Гражданка Д. обратилась в поликлинику после окончания рабочей смены. Врач установил признаки временной нетрудоспособности и сформировал (выдал) листок нетрудоспособности.
ОЦЕНИТЕ ВЕРНОСТЬ ВСЕХ УТВЕРЖДЕНИЙ

1. **дата освобождения от работы в листке нетрудоспособности может быть указана по желанию гражданки Д. со следующего календарного дня после окончания рабочей смены**
2. дата освобождения от работы в листке нетрудоспособности должна соответствовать дате признания гражданки Д. временно нетрудоспособной
3. дата освобождения от работы в листке нетрудоспособности указывается независимо от желания гражданки Д.
4. дата освобождения от работы в листке нетрудоспособности может быть указана по желанию гражданки Д. со дня обращения за медицинской помощью

Вопрос 2
СОСТАВ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ПО ПРОВЕДЕНИЮ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ МЕДИЦИНСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ УТВЕРЖДАЕТСЯ СРОКОМ НА (В ГОДАХ)

1. **три**
2. пять
3. один
4. семь

Вопрос 3
ЭКСПЕРТИЗА КАЧЕСТВА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В СИСТЕМЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ ПРОВОДИТСЯ ЭКСПЕРТОМ, КОТОРЫЙ

1. **включен в единый реестр Федерального фонда обязательного медицинского страхования** *(Единый реестр экспертов качества медицинской помощи)*
2. назначается по приказу руководителя Росздравнадзора
3. включен в Федеральный регистр медицинских и фармацевтических работников
4. назначается по решению суда

Вопрос 5

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ УСТАНАВЛИВАЕТ ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ _____ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ МЕДИЦИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1. **государственного**
2. общественного
3. независимого
4. внутреннего

Вопрос 6
ГРАЖДАНЕ С УСТАНОВЛЕННОЙ II ГРУППОЙ ЗДОРОВЬЯ

1. не подлежат диспансерному наблюдению
2. подлежат диспансерному наблюдению врачом по медицинской реабилитации
3. **подлежат диспансерному наблюдению врачом отделения медицинской профилактики или врачом центра здоровья** *(Внимание: а также фельдшером)*
4. подлежат диспансерному наблюдению врачом-терапевтом участковым

Вопрос 14
РАЗМЕР И ПОРЯДОК РАСЧЕТА ТАРИФА СТРАХОВОГО ВЗНОСА НА ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ НЕРАБОТАЮЩЕГО НАСЕЛЕНИЯ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ

1. **федеральным законом Российской Федерации**
2. постановлением Правительства Российской Федерации
3. распоряжением органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации
4. распоряжением Федерального фонда обязательного медицинского страхования

Вопрос 21
В ФЕДЕРАЛЬНОМ ЗАКОНЕ ОТ 21.11.2011 Г. №323 «ОБ ОСНОВАХ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» ОПРЕДЕЛЕНЫ _____ МЕДИЦИНСКИХ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ

1. **права и обязанности**
2. социальные гарантии
3. правила и этические нормы
4. продолжительность рабочего дня

Вопрос 27
РЕШЕНИЕ О ЛИКВИДАЦИИ ЕДИНСТВЕННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, РАСПОЛОЖЕННОЙ В СЕЛЬСКОМ НАСЕЛЕННОМ ПУНКТЕ, ПРИНИМАЕТСЯ С УЧЕТОМ МНЕНИЯ ЖИТЕЛЕЙ, ВЫРАЖЕННОГО ПО РЕЗУЛЬТАТАМ

1. социологического опроса в форме анкетирования
2. референдума жителей муниципального образования
3. электронного голосования
4. **общественных слушаний**

Вопрос 33
РАБОТУ С ЖАЛОБАМИ ПАЦИЕНТОВ РЕГЛАМЕНТИРУЕТ

1. Федеральный закон от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации»
2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ
3. Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основы охраны здоровья граждан в Российской Федерации»
4. **Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»**

Вопрос 40
ЛИЦА, ИНФИЦИРОВАННЫЕ ВИРУСОМ ИММУНОДЕФИЦИТА ЧЕЛОВЕКА, ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ ПРЕПАРАТАМИ ВКЛЮЧАЮТ СЯ В

1. **Федеральный регистр**
2. Национальный реестр
3. персонифицированный реест
4. рмуниципальный регистр

Вопрос 41
ПЕРЕЧЕНЬ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ УТВЕРЖДАЕТСЯ

1. **Правительством Российской Федерации**
2. Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
3. Министерством здравоохранения Российской Федерации
4. Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения

Вопрос 42
ВЫДАЧА ЛИСТКА НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ НА БУМАЖНОМ НОСИТЕЛЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПРИ ПРЕДЪЯВЛЕНИИ

1. страхового номера индивидуального лицевого счета гражданина в системе индивидуального (персонифицированного) учета
2. идентификационного номера налогоплательщика
3. **документа, удостоверяющего личность**
4. заявления на имя главного врача медицинской организации, в которой гражданин был признан нетрудоспособным

Вопрос 46
ГРАЖДАНЫНУ, НУЖДАЮЩЕМУСЯ В СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, ЛИСТОК НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ ФОРМИРУЕТСЯ (ВЫДАЕТСЯ)

1. **врачом медицинской организации, оказывающей специализированную медицинскую помощь**
2. по решению врачебной комиссии медицинской организации, направившей его для оказания специализированной медицинской помощи
3. врачом, направившим его в медицинскую организацию для оказания специализированной медицинской помощи
4. по решению консилиума врачей, определившего показания для направления его в медицинскую организацию, оказывающую специализированную медицинскую помощь

Вопрос 47
КАЧЕСТВО МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ ЗА СЧЕТ ПРИМЕНЕНИЯ

1. **порядков оказания медицинской помощи**
2. **клинических рекомендаций**

3. методических рекомендаций
4. **стандартов медицинской помощи**

Вопрос 48
ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ РАЗРАБАТЫВАЕТСЯ ПО

1. **состояниям или группам состояний**
2. отдельным возрастным группам
3. **заболеваниям или группам заболеваний**
4. **отдельным профилям**

Вопрос 49
ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ВКЛЮЧАЕТ

1. **правила организации деятельности медицинской организации**
2. **рекомендуемые штатные нормативы медицинской организации**
3. тарифы на оплату медицинских услуг
4. **стандарт оснащения медицинской организации**

Вопрос 50
ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ У НАСЕЛЕНИЯ ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА

1. **информирование граждан о факторах риска для их здоровья**
2. повышение качества жизни граждан
3. **создание условий для занятий физической культурой и спортом**
4. раннее выявление симптомов заболеваний

Вопрос 52
ПЕРИОДИЧЕСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ОСМОТР ПРОВОДИТСЯ В ЦЕЛЯХ

1. определения потребности в реабилитации и мерах социальной защиты
2. **выявления медицинских противопоказаний к осуществлению отдельных видов работ**
3. **динамического наблюдения за состоянием здоровья работников**
4. **своевременного выявления начальных форм профессиональных заболеваний**

Вопрос 53
ЗАСТРАХОВАННЫЕ ЛИЦА ИМЕЮТ ПРАВО НА

1. получение информации от Федерального фонда и территориальных фондов об уплате страхователями страховых взносов на обязательное медицинское страхование
2. **выбор медицинской организации из медицинских организаций, участвующих в реализации программ обязательного медицинского страхования**
3. замену страховой медицинской организации путем подачи заявления во вновь выбранную страховую медицинскую организацию
4. **бесплатную медицинскую помощь при страховом случае на всей территории России в объеме базовой программы обязательного медицинского страхования**

Вопрос 54

СУБЪЕКТАМИ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ ЯВЛЯЮТСЯ

1. медицинские организации
2. **Федеральный фонд**
3. **застрахованные лица**
4. **страхователи**

Вопрос 55
УЧАСТНИКАМИ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ ЯВЛЯЮТСЯ

1. Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
2. **медицинские организации**
3. **территориальный фонд обязательного медицинского страхования**
4. **страховые медицинские организации**

Вопрос 57
ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ГРАЖДАН В СФЕРЕ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ НЕ ВПРАВЕ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ РЕКЛАМУ

1. **торговых наименований лекарственных препаратов, биологически активных добавок**
2. **заменителей грудного молока**
3. **специализированных продуктов лечебного питания**
4. технических средств реабилитации, не являющихся медицинскими изделиями

Вопрос 59
ГРАЖДАНЕ ИМЕЮТ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ ДОСТОВЕРНОЙ И СВОЕВРЕМЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ О

1. **безопасности пищевых продуктов и рациональных нормах питания**
2. **потенциальной опасности для здоровья выполняемых работ и оказываемых услуг**
3. рейтингах медицинских организаций и индивидуальных показателях эффективности работы медицинских работников
4. **санитарно-эпидемиологическом благополучии района проживания**

Вопрос 60
ПРИ РАССМОТРЕНИИ ОБРАЩЕНИЯ В МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ГРАЖДАННИН ИМЕЕТ ПРАВО

1. **подать заявление о прекращении рассмотрения обращения**
2. **знакомиться с документами и материалами, касающимися рассмотрения обращения**
3. получать информацию о ходе рассмотрения обращения в электронном виде
4. **получать письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов**

Вопрос 67
ПРИ ОФОРМЛЕНИИ ЛИСТКА НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ ДВУЗНАЧНЫЙ КОД УКАЗЫВАЕТСЯ В ПОЛЕ

1. **«Родственная (семейная) связь»**
2. **«Отметки о нарушении условий оказания медицинской помощи»**
3. «Дополнительный код»
4. **«Причина нетрудоспособности»**

Вопрос 68
ЭКСПЕРТИЗА ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ ПРОВОДИТСЯ В ЦЕЛЯХ

1. **принятия решения о направлении гражданина на медико-социальную экспертизу**
2. **определения способности работника осуществлять трудовую деятельность**
3. **определения необходимости и сроков временного или постоянного перевода работника по состоянию здоровья на другую работу**
4. принятия решения о предоставлении мер социальной поддержки

Вопрос 73
Гражданка С. приехала отдыхать в другой регион, где внезапно заболела. Она обратилась в поликлинику с высокой температурой, имея при себе электронный полис обязательного медицинского страхования (ОМС). В регистратуре поликлиники ей отказали в оказании бесплатной медицинской помощи и направили в отделение платных медицинских услуг. Основанием для отказа послужило отсутствие у гражданки С. полиса обязательного медицинского страхования на материальном носителе.
ОЦЕНИТЕ ВЕРНОСТЬ ВСЕХ УТВЕРЖДЕНИЙ

1. **гражданке С. неправомерно отказали в оказании бесплатной медицинской помощи, так как полис ОМС как на материальном носителе, так и в электронном виде подтверждает ее право на бесплатную медицинскую помощь в системе ОМС**
2. отказ в оказании бесплатной медицинской помощи гражданке С. правомерен, поскольку электронный полис ОМС не служит документом, подтверждающим право на бесплатную медицинскую помощь, в отличие от полиса на материальном носителе
3. **наличие электронного полиса ОМС давало право гражданке С. на бесплатное оказание медицинской помощи в любом регионе страны при наступлении страхового случая**
4. **гражданка С. имеет право обратиться в свою страховую медицинскую организацию с жалобой на неправомерный отказ в оказании бесплатной медицинской помощи**

Вопрос 74

В Оренбургскую областную клиническую больницу поступил пациент К., которому по жизненным показаниям требуется оказание специализированной медицинской помощи в федеральном центре в городе Москве. Главный врач больницы обратился к руководителю территориального фонда обязательного медицинского страхования с просьбой решить вопрос оплаты транспортировки пациента К. на самолете санитарной авиации за счет средств обязательного медицинского страхования.
ОЦЕНИТЕ ВЕРНОСТЬ ВСЕХ УТВЕРЖДЕНИЙ

1. **главный врач получил отказ от руководителя территориального фонда обязательного медицинского страхования, поскольку оплата транспортировки пациента К. санитарной авиацией за счет средств обязательного медицинского страхования невозможна**
2. **оплата санитарно-авиационной транспортировки пациента К. согласно Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи проводится за счет средств регионального бюджета**
3. все вопросы финансового обеспечения медицинской помощи застрахованным лицам в регионе находятся в компетенции территориального фонда обязательного медицинского страхования
4. **пациент К. имеет право на медицинскую эвакуацию в федеральный специализированный медицинский центр**

Вопрос 75
Главному врачу больницы поступила жалоба от гражданки Д. в связи с отказом обеспечить ее питанием на период нахождения в

стационаре по уходу за ребенком 6 лет. При проведении проверки установлено, что ребенок получает плановое противорецидивное лечение в связи с хроническим заболеванием в стадии компенсации.
ОЦЕНИТЕ ВЕРНОСТЬ ВСЕХ УТВЕРЖДЕНИЙ

1. **матери ребенка Д. предоставлено право на бесплатное совместное нахождение с ребенком на весь период лечения в стационаре, при этом обеспечение ее бесплатным питанием не предусмотрено**
2. мать ребенка Д. вправе претендовать на бесплатное питание, так как ей предоставлено право на бесплатное совместное нахождение с ребенком на весь период лечения в стационаре
3. **бесплатным питанием обеспечивается мать ребенка в возрасте старше 4 лет только в том случае, если она госпитализирована по уходу за ним при наличии медицинских показаний**
4. **бесплатным питанием обеспечивается мать ребенка до достижения им возраста 4 лет в течение всего периода лечения в стационаре**

Вопрос 77
Ребенок М., 2 лет, был доставлен машиной скорой помощи в приемный покой детской городской больницы в бессознательном состоянии с признаками аспирации инородного тела. Сопровождающая ребенка мать находилась в состоянии алкогольного опьянения, проявляла агрессию по отношению к медицинским работникам и отказывалась дать согласие на проведение бронхоскопии. Консилиум врачей провести не удалось из-за отсутствия специалистов. Несмотря на отсутствие согласия матери, дежурным врачом была проведена срочная бронхоскопия и инородное тело было удалено.
ОЦЕНИТЕ ВЕРНОСТЬ ВСЕХ УТВЕРЖДЕНИЙ

1. после проведения бронхоскопии дежурный врач должен был написать объяснительную по факту проведения медицинского вмешательства ребенку М. без согласия матери
2. после проведения бронхоскопии дежурный врач должен был проинформировать заведующего приемным отделением, что медицинское вмешательство ребенку М. было проведено без согласия матери и без проведения консилиума
3. **поскольку мать ребенка М. не подписала информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство, дежурный врач был обязан проинформировать об этом органы внутренних дел**
4. **дежурный врач был вправе единолично принять решение о проведении процедуры бронхоскопии ребенку М.**

Вопрос 78
Врач-терапевт участковый, который только начал свою трудовую деятельность после окончания вуза, установил, что по заболеванию, которым страдает пациентка О., клинических рекомендаций нет. Молодой врач обратился к своему наставнику — более опытному врачу-терапевту — с вопросом, как правильно назначить лечение в данном случае. Наставник дал разъяснения своему молодому коллеге.
ОЦЕНИТЕ ВЕРНОСТЬ ВСЕХ УТВЕРЖДЕНИЙ

1. в данной ситуации молодой врач должен уточнить наличие стандарта медицинской помощи и руководствоваться им при назначении лечения пациентке О.
2. при отсутствии стандартов медицинской помощи по заболеванию пациентки О. молодой коллега должен направить ее в стационар для подбора лекарственной терапии
3. при отсутствии стандартов медицинской помощи по заболеванию пациентки О. молодой коллега должен направить ее на врачебную комиссию для решения вопроса о назначении лечения
4. **при отсутствии стандартов медицинской помощи по заболеванию пациентки О. молодой коллега может руководствоваться методическими рекомендациями, национальными руководствами или привлечь к обсуждению лечения коллег – собрать консилиум**

Вопрос 79

Гражданин М., 18 лет, работает по трудовому договору. Он был направлен военным комиссариатом для прохождения медицинского обследования в стационар. Гражданин настаивает на оформлении листка нетрудоспособности.
ОЦЕНИТЕ ВЕРНОСТЬ ВСЕХ УТВЕРЖДЕНИЙ

1. врач вправе единолично сформировать листок нетрудоспособности гражданину М. на весь период его пребывания в стационаре

2. в данной ситуации имеются законные основания для оформления гражданину М. листка нетрудоспособности по решению врачебной комиссии
3. **гражданину М. листок нетрудоспособности не оформляется, потому что он направлен на обследование военным комиссариатом**
4. ражданин М. вправе отказаться от предложенного стационарного обследования, если не получит листок нетрудоспособности

Вопрос 80

Пациент Н., 41 год, работает по трудовому договору. В течение четырех месяцев является временно нетрудоспособным в связи с заболеванием, листок нетрудоспособности оформлен. При очередном приеме признаки временной нетрудоспособности сохраняются. По заключению врачебной комиссии клинический и трудовой прогноз благоприятный.
ОЦЕНИТЕ ВЕРНОСТЬ ВСЕХ УТВЕРЖДЕНИЙ

1. в данной ситуации пациент Н. может быть направлен на медико-социальную экспертизу только при наличии обращения от его работодателя
2. в данной ситуации направление пациента Н. на медико-социальную экспертизу является обязательным
3. в данной ситуации пациент Н. может быть направлен на медико-социальную экспертизу по решению врачебной комиссии
4. **в данной ситуации пациент Н. на медико-социальную экспертизу не направляется**

Вопрос 4
РЕЗУЛЬТАТЫ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ МЕДИЦИНСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ВКЛЮЧЕНЫ В ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ

1. главного государственного санитарного врача субъекта Российской Федерации
2. директора территориального фонда обязательного медицинского страхования субъекта Российской Федерации
3. главных медицинских сестер медицинских организаций
4. **руководителей медицинских организаций**

Вопрос 8
К ВИДАМ МЕДИЦИНСКИХ ОСМОТРОВ ОТНОСЯТ

1. первичные и вторичные
2. диспансерные и углубленные
3. индивидуальные и групповые
4. **предсменные и предрейсовые**

Вопрос 44
ПРОВЕРКУ СОБЛЮДЕНИЯ ПОРЯДКА ФОРМИРОВАНИЯ (ВЫДАЧИ), ПРОДЛЕНИЯ И ОФОРМЛЕНИЯ ЛИСТКОВ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ ПРОВОДИТ

1. Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
2. Министерство здравоохранения Российской Федерации
3. территориальный фонд обязательного медицинского страхования
4. **Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации**

УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ (ВЫДАЧИ) ЛИСТКОВ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ УТВЕРЖДАЮТСЯ

1. инструкцией Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации
2. **приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации**
3. распоряжением Федерального фонда обязательного медицинского страхования
4. постановлением Правительства Российской Федерации

Вопрос 47
ПОД КАЧЕСТВОМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПОНИМАЮТ

1. социальную защищенность граждан в случае утраты здоровья
2. **степень достижения запланированного результата**
3. **правильность выбора методов профилактики и реабилитации**
4. **правильность выбора методов диагностики и лечения**

Вопрос 48
ПРИ ОКАЗАНИИ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ НЕНАДЛЕЖАЩЕГО КАЧЕСТВА СТРАХОВЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ИМЕЮТ ПРАВО

1. **отказать медицинской организации в оплате медицинской помощи**
2. **наложить штраф на медицинскую организацию**
3. заблокировать счет медицинской организации
4. **уменьшить медицинской организации сумму оплаты медицинской помощи**

Вопрос 50
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ОСМОТР ПРОВОДИТСЯ ЕЖЕГОДНО

1. **в качестве самостоятельного мероприятия**
2. **в рамках диспансеризации**
3. **в рамках диспансерного наблюдения**
4. в рамках консилиума врачей

Вопрос 52
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО МЕДИЦИНСКОГО ОСМОТРА У ГРАЖДАНИНА ОПРЕДЕЛЯЮТ ГРУППУ

1. **здоровья**
2. инвалидности
3. физической подготовленности
4. **диспансерного наблюдения**

Вопрос 53
В СОСТАВ КОМИССИИ ПО РАЗРАБОТКЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ В СУБЪЕКТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ВХОДЯТ ПРЕДСТАВИТЕЛИ

1. общественных некоммерческих организаций, представляющих интересы пациентов
2. **территориального фонда, страховых медицинских организаций, медицинских организаций**
3. **органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации**
4. **медицинских профессиональных некоммерческих организаций, профессиональных союзов медицинских работников**

Вопрос 64
МЕДИЦИНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЯЗАНА ПРЕДОСТАВЛЯТЬ СВЕДЕНИЯ О МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, ОКАЗАННОЙ ЗАСТРАХОВАННОМУ ЛИЦУ

1. **территориальному фонду обязательного медицинского страхования**
2. Фонду пенсионного и социального страхования Российской Федерации
3. Федеральномускому фонду обязательного медицинского страхования
4. **страховым медицинским организациям**

Вопрос 55
МЕДИЦИНСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ИМЕЮТ ПРАВО ОБЖАЛОВАТЬ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ПО ОЦЕНКЕ ОБЪЕМОВ, СРОКОВ, КАЧЕСТВА И УСЛОВИЙ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, ПОЛУЧЕННЫЕ ОТ

1. Координационного совета по защите прав застрахованных
2. Федерального фонда обязательного медицинского страхования
3. **страховых медицинских организаций**
4. **территориального фонда обязательного медицинского страхования**

Вопрос 56
К ПОЛНОМОЧИЯМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СФЕРЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ ОТНОСЯТ

1. **организацию обязательного медицинского страхования на всей территории страны**
2. **организацию управления средствами обязательного медицинского страхования**
3. утверждение территориальных программ обязательного медицинского страхования
4. **установление круга лиц, подлежащих обязательному медицинскому страхованию**

Вопрос 60

В ЦЕЛЯХ СОХРАНЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН НА ПРЕДПРИЯТИЯХ С ВРЕДНЫМИ И (ИЛИ) ОПАСНЫМИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ ФАКТОРАМИ РАБОТОДАТЕЛЬ ВПРАВЕ СОЗДАВАТЬ

1. **медицинский кабинет**
2. **здравпункт**
3. **медицинскую часть**
4. санитарный пункт

Вопрос 61
ПРИ НАПРАВЛЕНИИ В МЕДИЦИНСКУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ ЖАЛОБЫ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ ГРАЖДАННИН В ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ ДОЛЖЕН УКАЗАТЬ

1. фамилию, имя, отчество должностного лица, к которому он обращается
2. наименование медицинской организации, в которую он направляет жалобу
3. **свои фамилию, имя и, при наличии, отчество**
4. **адрес электронной почты либо уникальный идентификатор личного кабинета на Едином портале государственных услуг**

Вопрос 62
ДОЛЖНОСТНОЕ ЛИЦО МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВПРАВЕ РАССМОТРЕТЬ ЖАЛОБУ ГРАЖДАННИНА

1. на основании заключения экспертов страховой медицинской организации
2. **с его участием**
3. **с выездом на место, если это необходимо**
4. **на основании его медицинской документации**

Вопрос 64
ПРИМЕНЕНИЕ ТЕЛЕМЕДИЦИНСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ОКАЗАНИИ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ С

1. **соблюдением требований по защите персональных данных**
2. **соблюдением врачебной тайны**
3. **учетом стандартов медицинской помощи**
4. соблюдением правил использования гибридных форматов консультаций

Вопрос 65
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РАССМОТРЕНИЯ ПРОЕКТА КЛИНИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ СОВЕТ ПРИНИМАЕТ РЕШЕНИЕ ОБ ИХ

1. утверждении
2. **направлении на доработку**
3. **отклонении**
4. **одобрении**

Вопрос 66
В ЛИСТКЕ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ НЕ УКАЗЫВАЕТСЯ

1. наименование медицинской организации
2. период временной нетрудоспособности
3. **номер документа, удостоверяющего личность**
4. **диагноз**

Вопрос 69
При проведении в поликлинике проверки в рамках внутреннего контроля качества медицинской помощи было установлено, что в медицинских картах пациентов, которым были проведены электрокардиографические исследования, нет информированного добровольного согласия пациента на медицинское вмешательство или отказа от медицинского вмешательства.
ОЦЕНИТЕ ВЕРНОСТЬ ВСЕХ УТВЕРЖДЕНИЙ

1. для проведения электрокардиографических и других функциональных исследований информированного добровольного согласия не требуется
2. **наличие в медицинской документации пациента информированного добровольного согласия является необходимым предварительным условием медицинского вмешательства**
3. информированное добровольное согласие пациента на медицинское вмешательство требуется только для проведения инвазивных диагностических исследований
4. **проведение электрокардиографических и других функциональных исследований без информированного добровольного согласия пациента на медицинское вмешательство не допускается**

Вопрос 70
В ходе проверки, проводимой Комиссией по внутреннему контролю качества и безопасности медицинской деятельности, пациент одного из отделений стационара городской больницы пожаловался, что к нему не допустили священнослужителя.

ОЦЕНИТЕ ВЕРНОСТЬ ВСЕХ УТВЕРЖДЕНИЙ

1. **в данной ситуации было нарушено право пациента на допуск к нему священнослужителя**
2. вопросы соблюдения прав пациента не являются предметом внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности
3. **в случае лечения в условиях стационара пациент имеет право не только на допуск к нему священнослужителя, но и на отправление религиозных обрядов**
4. допуск священника к пациенту, находящемуся в стационаре, является нарушением лечебно-охранительного режима

Вопрос 71
Гражданин Р., 29 лет, обратился в поликлинику с просьбой назначить ему исследование на гепатит С, поскольку узнал из средств массовой информации, что данное заболевание часто регистрируется у молодых людей и приводит к циррозу печени.
ОЦЕНИТЕ ВЕРНОСТЬ ВСЕХ УТВЕРЖДЕНИЙ

1. **исследование на антитела к вирусу гепатита С проводится гражданам в возрасте 25 лет и старше 1 раз в 10 лет**
2. **исследование на антитела к вирусу гепатита С включено в первый этап диспансеризации взрослого населения**
3. **врач предложил гражданину Р. пройти профилактический медицинский осмотр, который включает исследование на антитела к вирусу гепатита С**
4. исследование на антитела к вирусу гепатита С проводится только гражданам, имеющим факторы риска данного заболевания

Вопрос 72
Гражданин У., 67 лет, пенсионер, прикреплен к поликлинике №1, где получает первичную медико-санитарную помощь. Для прохождения диспансеризации он обратился в поликлинику №2, поскольку считает, что в ней работают более квалифицированные специалисты. В проведении диспансеризации в поликлинике №2 ему отказали и пояснили, что уровень квалификации врачей поликлиник №1 и №2 одинаков, к тому же в настоящее время в поликлинике №2 существует очередь более 14 дней на проведение лабораторных исследований, входящих в диспансеризацию.
ОЦЕНИТЕ ВЕРНОСТЬ ВСЕХ УТВЕРЖДЕНИЙ

1. **гражданин может проходить диспансеризацию в иной медицинской организации, если он является работником образовательной организации или обучающимся**
2. гражданин У. должен проходить диспансеризацию в поликлинике №1, поскольку уровень квалификации специалистов в поликлиниках №1 и №2 одинаковый
3. гражданин У. должен проходить диспансеризацию в поликлинике №1, поскольку в настоящее время в поликлинике №2 существует очередь более 14 дней на проведение лабораторных исследований, входящих в диспансеризацию
4. **гражданин проходит диспансеризацию в медицинской организации, в которой он получает первичную медико-санитарную помощь**

Вопрос 73
Гражданка И. обратилась в страховую медицинскую организацию с жалобой на ненадлежащее качество медицинской помощи, оказанной ей в городской больнице. В медицинской организации гражданке И. и эксперту страховой медицинской организации, направленному для проверки качества медицинской помощи, в выдаче соответствующих медицинских документов было отказано.
ОЦЕНИТЕ ВЕРНОСТЬ ВСЕХ УТВЕРЖДЕНИЙ

1. **гражданка И. имеет право непосредственно знакомиться с медицинской документацией, отражающей состояние ее здоровья, и получать на ее основании консультации у других специалистов**
2. **поступление в страховую медицинскую организацию жалобы от гражданки И. служит основанием для проведения внеплановой проверки, поскольку количество обоснованных жалоб является одним из критериев качества медицинской помощи**
3. действия администрации городской больницы не являются нарушением законодательства об обязательном медицинском страховании, поскольку предоставление медицинской документации по жалобе гражданки И. возможно только по запросу органов дознания, следствия или суда
4. **по запросу эксперта, направленного для проверки качества оказания медицинской помощи и обоснованности жалобы гражданки И., городская больница обязана предоставить соответствующую медицинскую документацию**

Вопрос 74
Иностранный гражданин, работающий по трудовому договору в частной строительной компании города Н., обратился в департамент здравоохранения с жалобой. В страховой медицинской организации ему отказали в выдаче полиса обязательного медицинского страхования и предложили заключить договор добровольного медицинского страхования.
ОЦЕНИТЕ ВЕРНОСТЬ ВСЕХ УТВЕРЖДЕНИЙ

1. **иностранные граждане, постоянно или временно проживающие в Российской Федерации и работающие по трудовому договору, относятся к застрахованным лицам** *(Внимание: норма закона расширена, детализация в комментарии)*
2. страховые медицинские организации, работающие в системе обязательного медицинского страхования, не имеют права заключать договоры добровольного медицинского страхования
3. страховая медицинская организация обязана удостовериться в уплате строительной компанией, выступающей работодателем иностранного гражданина, страховых взносов на обязательное медицинское страхование в отношении данного лица
4. **полис обязательного медицинского страхования удостоверяет право застрахованного лица на бесплатное оказание медицинской помощи на всей территории Российской Федерации в объеме, предусмотренном базовой программой обязательного медицинского страхования**

Вопрос 77
Врач-терапевт участковый, который только начал свою трудовую деятельность после окончания вуза, решил назначить пациентке Л. лекарственный препарат, не предусмотренный клиническими рекомендациями. Ранее у пациентки Л. была тяжелая аллергическая реакция на лекарственный препарат, входящий в клинические рекомендации. Молодой врач обратился к более опытному коллеге с вопросом о том, как правильно оформить это назначение. Опытный врач-терапевт дал разъяснения молодому коллеге.
ОЦЕНИТЕ ВЕРНОСТЬ ВСЕХ УТВЕРЖДЕНИЙ

1. в данной ситуации врач-терапевт участковый вправе единолично принять решение о назначении пациентке Л. лекарственного препарата, не предусмотренного клиническими рекомендациями
2. в данной ситуации врач-терапевт участковый должен направить пациентку Л. в стационар для подбора персонализированной лекарственной терапии
3. в данной ситуации врач-терапевт участковый должен собрать консилиум врачей для подбора лекарственной терапии с учетом индивидуальных особенностей пациентки Л.
4. **в данной ситуации врач-терапевт участковый должен направить пациентку Л. на врачебную комиссию для назначения лекарственного препарата, не предусмотренного клиническими рекомендациями**

Вопрос 78
Пациентка Н. была направлена на лечение в кардиологический диспансер. Она попросила заведующего отделением предоставить информацию о квалификации лечащего врача.
ОЦЕНИТЕ ВЕРНОСТЬ ВСЕХ УТВЕРЖДЕНИЙ

1. **пациентка Н. имеет право на получение запрашиваемой информации в доступной для нее форме**
2. сведения об уровне образования и квалификации врача не могут быть предоставлены пациентке Н., поскольку относятся к личным данным и не подлежат разглашению
3. сведения об уровне образования и квалификации врача могут быть предоставлены пациентке Н. только с согласия самого врача
4. **сведения об уровне образования и квалификации врача размещаются в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе на сайте медицинской организации**

Вопрос 79
Пациент К., 25 лет, работает по трудовому договору. Является временно нетрудоспособным в течение четырех месяцев в связи с травмой, листок нетрудоспособности оформлен. При очередном осмотре на приеме признаки временной нетрудоспособности сохраняются, при этом врачебная комиссия дала заключение о благоприятном клиническом и трудовом прогнозе.
ОЦЕНИТЕ ВЕРНОСТЬ ВСЕХ УТВЕРЖДЕНИЙ

1. в данной ситуации пациент К. должен быть направлен на медико-социальную экспертизу
2. **в данной ситуации продление листка нетрудоспособности пациенту К. возможно, поскольку клинический и трудовой прогнозы**

благоприятны

продление листка нетрудоспособности при состояниях после травм и реконструктивных операций разрешено на срок не более десяти месяцев

в данной ситуации для решения вопроса о продлении листка нетрудоспособности пациенту К. необходимо заключение врачебной комиссии

Вопрос 80

Пациент Р., 59 лет, работающий по трудовому договору, наблюдается в поликлинике с хроническим заболеванием. В течение 4 месяцев является временно нетрудоспособным. Врачебная комиссия сделала заключение о неблагоприятном клиническом и трудовом прогнозе и направила пациента Р. на медико-социальную экспертизу. Однако пациент отказался от ее прохождения.

ОЦЕНИТЕ ВЕРНОСТЬ ВСЕХ УТВЕРЖДЕНИЙ

в случае отказа от прохождения медико-социальной экспертизы пациент направляется на стационарное лечение с открытым листком нетрудоспособности

пациент Р. имеет право отказаться от проведения медико-социальной экспертизы без объяснения причин

в данной ситуации листок нетрудоспособности продлевается по решению врачебной комиссии на срок не более десяти месяцев

в случае отказа пациента Р. от прохождения медико-социальной экспертизы листок нетрудоспособности не продлевается